

虛証論

索正昌著



责任编辑 呼素华
封面设计 王杏云



ISBN 7-117-02355-4



9 787117 023559 >

定 价：16.50 元

虚 证 论

索延昌 著

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

虚证论/索延昌著. —北京: 人民卫生出版社, 1996 年 5
ISBN 7-117-02355-4

I. 虚… II. 索… III. 虚劳-研究 IV. R255. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 21210 号

虚 证 论

著 者: 索延昌

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

印 刷: 北京隆华印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 6.25

字 数: 164 千字

版 次: 1996 年 5 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 版第 3 次印刷

印 数: 7 001—10 000

标准书号: ISBN 7-117-02355-4/R·2356

定 价: 16.50 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

濟世壽人福妙
手望聞問切慶
回春

癸亥夏月書贈
延昌國手曹念

溥杰

今日可以說中西醫和平共處還不是中西醫合為一中。西醫
不令研究的途徑就不統一使無法探知人體的秘寔使今後
老之病以能事別人終不免死亡於疾病不能存其天年共其
素為中西醫合為一就必需在二者與科學相近相似之處入手病下
一番結合的工作如果說中西醫永遠是兩個體系那還未處於合
而為一呢。科學與國高科學水平的新醫學將何實現呢。

一九六三年國慶節後錄六一年四件隨筆之一類

施今吾訂正

施今吾

序 言

索延昌君是我青年时的好友。他早年立志学医，毕业于华北国医学院，并拜名医施今墨先生为师，以弱冠之年悬壶京城。由于经常随侍前辈名家左右，亲承风旨，得以朝益暮习，医道大进。

一九五五年，延昌君入北京第四医院工作以后，有机会较多地接触西医，并开始努力学习西医理论，知见日益扩大。

施今墨先生曾对索延昌君寄予厚望，勉励他结合临床实践，借鉴西医理论，致力于研究改进中医学。一九八一年索延昌君以其从医四十余年的经验，撰写了《虚证论》一书。这是继中医治虚专著《理虚元鉴》之后，更进一步对虚证进行深入探讨和全面论述的著作。

明代汪倚石的《理虚元鉴》，谓虚证有“六因”，即先天因、后天因、病后因、外感因、境遇因、医药因。谓治虚有“三本”，即肺、脾、肾；及“二统”，即肺、脾。被后学视为治虚之大法。但汪倚石因受前人所谓“心无虚、肝无虚”的论点影响，对心虚、肝虚避而不谈，实为缺憾。

索延昌君之《虚证论》，继承和发扬前人的中医理论，提出了百病乘虚而入，虚者正气必损，故须扶正以祛邪，驱邪以安正的论点。不但对阳虚、阴虚、气虚、血虚、虚热、虚寒等进行全面论述，而且对心虚、肝虚、脾虚、肺虚、肾虚，以及男虚、妇儿虚等亦详

辨析。并结合临床实践，阐其病因，明辨治法方剂与用药。其处方药到病除，由所附之典型病例中可见一斑。

这部《虚证论》自一九八二年由山西人民出版社出版以来，受到国内外医学界的好评，不但一九八五年第二次印刷，且印数达两万册以上，目前经补充修订，将由人民卫生出版社再行出版。

我很高兴索延昌君有这样的贡献，值兹再版之际，谨致数言以表敬贺之意。

A stylized handwritten signature in black ink, likely reading '钱洁' (Qian Jie).

一九八五年秋于北京

再版序言

近年来，由于人民生活水平不断提高，许多人认为进补即可强身，这是非常片面的。作为医务工作者责无旁贷地应当帮助人民群众从医学角度认识怎样防病去病，怎样补虚强身，如何延年益寿。欲知如何补虚，必先知虚之所在，未知虚，焉知补？为此决定修订再版《虚证论》一书，向广大群众和临床医生阐述中医学的有关虚证学理和表现，以及如何治疗虚证的经验体会。

中医认为：百病乘虚而入，正气常存则邪不干正；邪之所凑，其气必虚。大病伤身可使身虚，久病伤正可使正损，“虚”与“治虚”是贯穿整个中医理论的全过程。中医治病就是扶正驱邪的过程，正胜邪，则病去正复，虚象解除；邪盛正则病情危重，急需扶正。扶正不只是单纯的补，以通为补，以调为补，临床则需灵活运用，就是需要进补，也要首先查明虚之所在？是脏损还是腑虚？是气弱还是血少？是阴亏还是阳不足？必须对症下药，不可盲目进补一概而论。如不分病因、病情、病位，乱用补品、补药，非但不能去病强身，反而有可能使病情加重，因此如何认识虚证，怎样治疗虚证，则是每一位临床医生需要解决的问题，也是一些医学爱好者及患者需要了解的问题。

《虚证论》是一部论述虚证及治疗的专著，自1982年问世以来，先后发行两万余册，受到医务界同行及

各界爱好中医朋友的关注，一些读者对本书各章内容直言短长，提出了宝贵意见，深表谢意。今参考各界人士意见和建议，对本书内容进一步思考，将部分内容重新调整，并又新增 10 个章节，以资更加完善和丰富，有利于同道参考。同时亦热忱欢迎专家学者和海内外医学爱好者批评赐正。

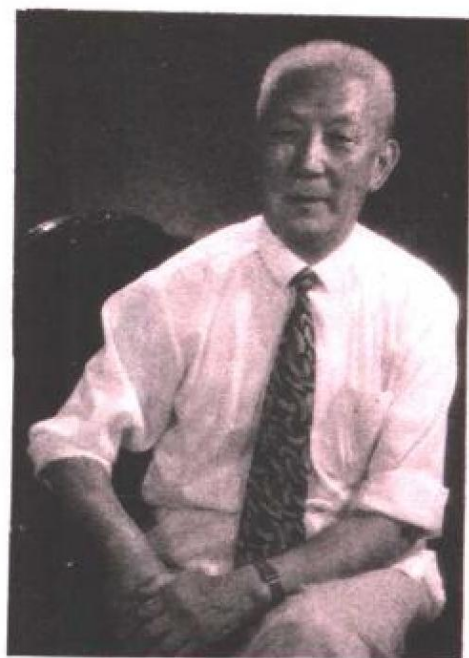
此次再版得到有关部门的鼓励和支持，并蒙著名中医专家关幼波师兄惠序，在此一并致以衷心的感谢！

谨致数语，聊以为序。

索延昌

1995. 10. 9

北京大北窑门诊部



索延昌教授，北京人，满族，1918年生。1936年毕业于华北国医学院，拜京城四大名医之一——施今墨先生为师，得其亲传。其自幼习医，勤谙岐黄之精奥，临证诊疗50余年，积累了丰富的经验，对各种虚证及脾胃学说有精辟论述，独特疗效。其高尚的医德，精湛的医术，坚深的学术造诣，深得广大患者及海内外专家学者的爱戴和崇尚。

本书是北京市著名中医专家索延昌先生的力作。其自幼习医，出身于名门，在半个多世纪的医疗实践中积累了丰富的经验，所治难病、重病无算，起死回生之侧不鲜，《虚证论》是他医疗实践的经验总结。

本书分总论与各论两部分。总论论及阴阳气血、寒热表里之虚证、全面而概括；各论论及男女老幼、五脏六腑之虚损病证，详明而清晰。每论一病，理法方药悉备，其中方解与按语，充分体现了老先生用药之独到，认证之精辟。

本书可供临床医生参考，也可作为医学爱好者及患者的辅助读物。

目 录

总 论

第一篇 总论	(1)
第一章 阳虚	(8)
第二章 阴虚	(9)
第三章 气虚	(11)
第四章 血虚	(12)
第五章 气血两虚	(14)
第六章 虚热	(16)
第七章 虚寒	(17)
第八章 阳虚自汗	(18)
第九章 阴虚盗汗	(20)
第十章 厥逆	(22)

各 论

第二篇 心虚论	(25)
第一章 心气虚	(26)
第二章 心阳虚 (胸痹)	(28)
第三章 心阴虚	(34)
第四章 心血虚	(35)
第五章 心阴心阳两虚	(37)
第六章 心脾两虚	(39)
第七章 中 风 (脑血管意外)	(40)

第八章 小肠虚	(47)
第三篇 肝虚论	(49)
第一章 肝气虚	(50)
第二章 肝血虚 (肝硬化)	(52)
第三章 肝阳虚 (臌胀)	(54)
第四章 肝阴虚证	(59)
第五章 水不涵木浮阳上越	(60)
第六章 胆虚不眠症	(62)
第四篇 脾虚论	(65)
第一章 脾阳虚	(67)
第二章 脾阴虚	(68)
第三章 脾胃虚寒	(70)
第四章 胃经虚热	(71)
第五章 湿伤脾胃	(73)
第六章 湿困脾阳 (阴黄证)	(74)
第七章 脾虚久泻	(75)
第八章 脾肾虚寒 (五更泻)	(77)
第九章 食伤脾胃	(78)
第十章 中气下陷	(79)
第五篇 肺虚论	(82)
第一章 肺气虚	(83)
第二章 肺虚感寒	(85)
第三章 肺阴虚	(86)
第四章 肺虚失音	(87)
第五章 肺 痿	(89)
第六章 肺虚喘	(92)
第七章 大肠虚寒泻	(94)
第八章 肠虚不固	(95)
第九章 脱 肛	(96)
第六篇 肾虚论	(98)
第一章 肾阳虚	(100)

第二章	肾阴虚·····	(101)
第三章	消渴病·····	(103)
第四章	不寐证·····	(108)
第五章	肝肾虚损(下痿)·····	(116)
第六章	肾虚内障眼·····	(118)
第七章	遗尿·····	(119)
第八章	水肿病(慢性肾炎)·····	(121)
第九章	肾功能衰竭(尿毒症)·····	(123)
第七篇 男虚论	·····	(126)
第一章	阳痿·····	(126)
第二章	遗精·····	(128)
第三章	老年癃闭(前列腺肥大症)·····	(130)
第四章	寒疝·····	(131)
第八篇 女虚论	·····	(134)
第一章	月经先期·····	(135)
第二章	月经后期·····	(137)
第三章	漏下·····	(139)
第四章	痛经·····	(141)
第五章	带下·····	(142)
第六章	不孕症·····	(145)
第七章	胎漏(先兆流产)·····	(148)
第八章	滑胎(习惯性流产)·····	(149)
第九章	产后缺乳·····	(151)
第十章	产后腰痛·····	(152)
第十一章	产后腹痛·····	(154)
第十二章	产后虚汗·····	(155)
第十三章	产后浮肿·····	(156)
第十四章	阴脱(子宫脱垂)·····	(158)
第十五章	产后毛发脱落病(席汉氏综合征)·····	(159)
第十六章	产后厥逆·····	(161)
第十七章	妇人更年期综合征·····	()

第十八章	脏 躁	(165)
第九篇	儿虚论	(168)
第一章	小儿五软五迟	(169)
第二章	慢惊风	(171)
第三章	慢脾风	(172)
第四章	小儿虚胀	(173)
第五章	小儿脱证	(175)
第六章	小儿多汗	(177)
第七章	小儿脱肛	(178)
第八章	疳 证	(180)

总 论

第一篇 总 论

一、何谓虚证？虚证者乃正气受损也。实者乃邪气盛也。《素问·评热论》曰：“邪之所凑，其气必虚。”气是指人体正气而言，气属阳。《素问·阴阳应象大论》曰：“阳为气。”明·张景岳曰：“夫生化之道，以气为本，天地万物，莫不由之……四时万物得以生长收藏，何非气之所为，人之有生，全赖此气。”《素问·生气通天论》曰：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰。”论述：人得气则生，气损则伤，气绝则亡。

正气乃禀受于先天之真气，又得后天之精气滋养和补充化生而成。又《灵枢·刺节真邪篇》曰：“真气者，所受于天，与谷气并而充身者也。”正气就是指人身之精、气、津、液、血，以及脏腑之气和经脉之气是否充盈而言。如果说：“风为百病之长。”则可以说：“气为生命之帝”。

东汉唯物主义思想家王充，继承先秦以来的“精气”学说，并吸取了医学的科学成就，更明确地指出“人之所以生者，精气也”。王充《论衡·纪妖》曰：“非物则气”，又《祀义》曰：“无体则气”。他认为气是无形体，它与有形的物体共同构成客观世界。同时他认为“万物之生，皆禀元气”。这说明元气是一切生物的物质基础，没有元气物体就失去生命力。所以说“万物之生，皆禀元气”。

“气”，古人认为它是天地间构成一切物质的基础。战国·惠施曰：“至小无内，谓之小一。”惠子所谓之小一，即气也。东汉

·何邵公曰：“元者，气也，无形以起，有形以分，造取天地，天地之始也。”说明最初宇宙是一混沌之气，经过运转分为阴阳。阳气上升为天，阴气凝结为地，天气演生四时及六气，地气化生五行与五味，阴阳交泰，上下相应，化生万物。所以，气是物质的实体，而它的固有属性是运动。气的运动变化规律，首先表现在阴阳两方面，阴阳是对立的统一，气便在对立统一的矛盾运动中演化流行。如阳气性升越，阴气性沉滞，阳极而阴，阴极而阳，阳统阴，阴承阳，阳性动，阴性静。总之，阴阳之气是相反相成和交流转，万物乃能繁殖（见表1）。

表 1 正气分类

正 气											
肾气主骨	肺气主皮毛、主一身之气	脾气主肌肉	肝气主筋	心气主血脉	膻中者气之海	少阳之气发于肾脏	太阳之气	营气	卫气	胃气	真气
								营卫之气生于阳明		后天水谷精微之气、宗气	先天之元气、先天之精气

凡正气虚的原因，不外由于五劳七伤所致。五劳者即：久视伤血，劳于心也；久卧伤气，劳于肺也；久坐伤肉，劳于脾也；久立伤骨，劳于肾也；久行伤筋，劳于肝也。心劳神损。肺劳气损。脾劳食损。肝劳血损。肾劳精损。七伤者即：大饱伤脾；大怒气逆伤肝；强力举重久坐湿地伤肾；形寒饮冷伤肺；忧愁思虑伤心；风雨寒暑伤形；恐惧不节伤志。当外邪侵入人体以后，造成邪气盛，正气虚的后果。邪正相争而对立，也就是生理机能对病理刺激的反应。在这个对立斗争过程中，即使正气战胜邪气，正气也必然要受到损伤。因此，人必须经常保持强壮健康的身体。《素问·上古天真论》曰：“……恬憺虚无，真气从之，精神内守，病安

从来？”这段经文的意思，是说注意保养身体，使人的精神充沛，就有充足抵御外邪的能力。古人很善于保健，“养吾浩然之气”，以达到却病延年的目的。祖国医学非常重视“气”在人体的重要作用，所以说“气为生命之帝”。

虞花溪的《医学正传》曰：“虚者，正气虚也，为色惨形瘦，为神衰气怯，或自汗不收，或二便不禁，或梦遗滑精，或呕吐膈塞，或久病攻多，或短气似喘，或劳伤过度，或暴困失志。虽外症似实，而脉弱无力者，皆虚症之，当补也。”《景岳全书·虚损》曰：“虚损伤阴本由五脏，虽五脏各有所主，然五脏证治有可分者，有不可分者。如诸气之损，其治在肺；神明之损，其治在心；饮食肌肉之损，其治在脾；诸血筋膜之损，其治在肝；精髓之损，其治在肾；此其可分者也。然气主于肺，而化于精；神主于心，而化于气，肌主于脾，而土生于火；诸血藏于肝，而化血于脾胃；精髓主于肾，而受于五脏；此其不可分者也。及乎既甚则标本相传，连及脏腑。此又方之不可执言也。故凡补虚之法，但当明其阴阳升降寒热温凉之性。精中有气，气中有精之因”。这两段论述对虚证的病理机制讲得十分透彻。

至于明辨虚证之真假更为重要。明·张景岳曰：“假虚之症不多见，而假实之症最多”。又曰：“虚者宜补，实者宜泻，此易知也，而不知实中复有虚，虚中复有实。每以至虚之病反见盛势，大实之病，反有羸状，此不可不辨也。”如病起七情，或饥饱劳倦，或酒色所伤，或先天不足。及其既病，每多身热便秘，戴阳胀满，虚狂，假斑等症，似为有余之病。究其因，实乃不足也。

人体与疾病作斗争，邪正力量互相争长，不是邪胜正衰，就是正胜邪退。如在邪正斗争之际，若正气充实，抵抗力强，病邪对人体的作用消失，脏腑的气血功能迅速得到恢复，正气完全战胜邪气，就是正胜邪退。如在对比相持斗争决定胜负之际，病渐强，体渐弱，就是邪胜正衰。出现虚象就是真虚。所以病人到此阶段未有不见虚象者，乃为真虚。假虚是少见的，如果假虚，医者细心诊察，着意体会，必然仍有真实可见。辨认错误，虚虚之害，危亡顷刻，医者不可不慎。（见图 1、2、3）

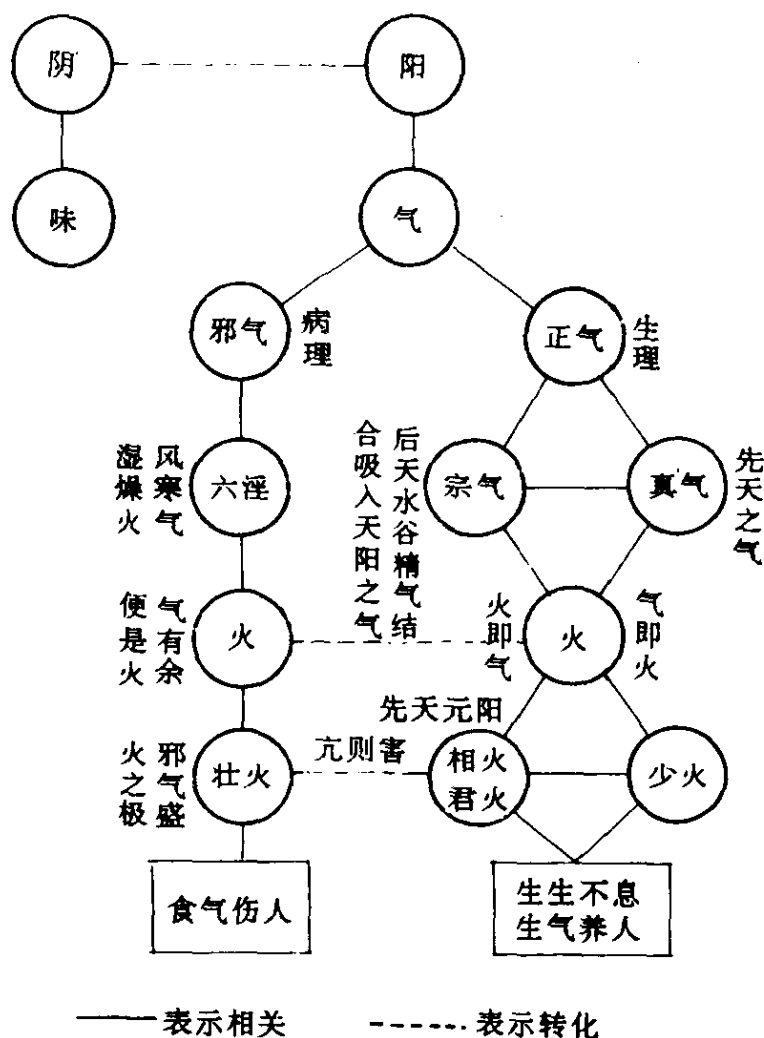


图1 正气与邪气之区别图

虚证属里，属寒。但和表证、实证也有密切关系。疾病的转化，在生理活动和病理变化的过程中，往往是错综复杂的，互相转化，变化多端。因此，无论患者是何种病症，在未患病以前，必然是由于正气的虚弱引起外邪的侵入，所谓“百病乘虚而入”是也。患病之后又必由于邪正交争使正气损伤，因此，“扶正以祛邪”，“驱邪以安正”，这个辨证关系，成为中医辨证论治的基本大法，医家不可不晓。

按：人体的生理正常活动，必须依赖正气而进行，正气概括地说：就是精、气、神。人的精、气、神来源于先天之真气和后天之宗气，再加养生有道，使正气充沛，当能抵御外邪，病安从来？

人体的精、气、神就是机体活动外在的表现，更通俗一些说

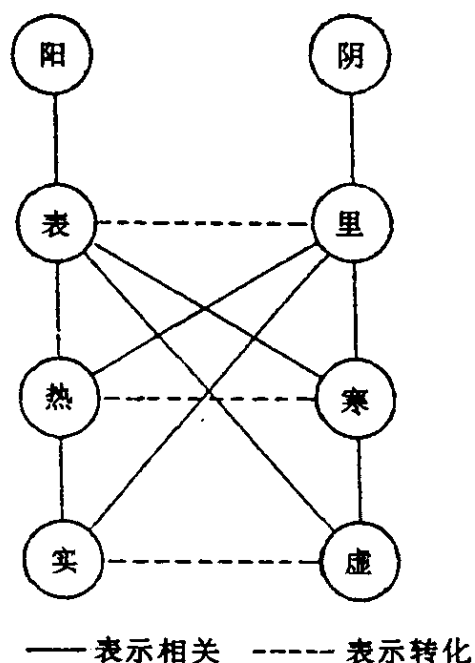


图2 八纲关联示意图

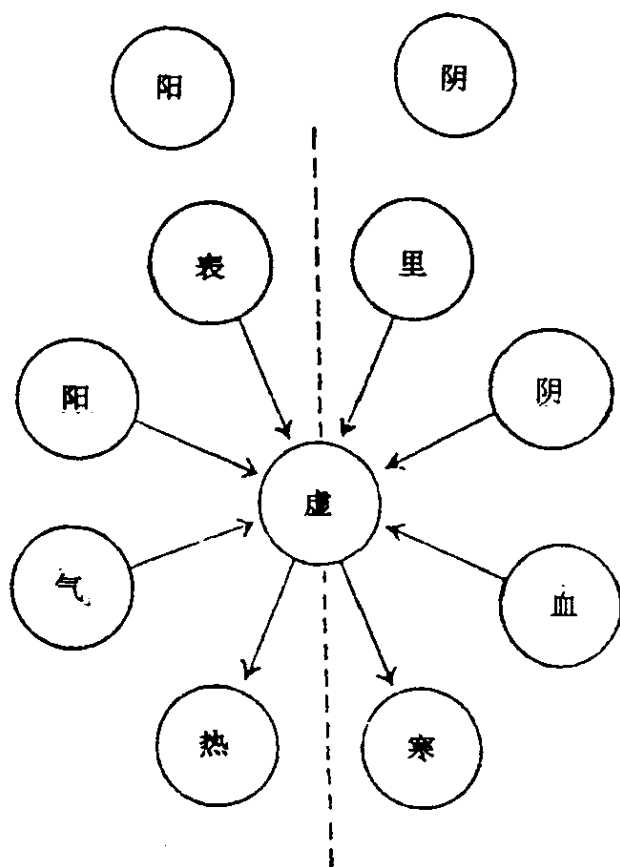


图3 虚证分类示意图

即日常所讲的“神气”。中医在望诊领域中，如精神饱满，言语清亮，神思不乱，肌肉不削，气息正常为有神。在切脉方面也是主张脉贵有神。李东垣曰：“脉之不病，其神不言，当自有也。脉既病，当求其中神之有无焉。如六数七极热也，脉中有力，即有神也；三迟二败寒也，脉中有力，即有神也。热而有神，当泻其热，则神在焉；寒而有神，当去其寒，则神在焉。寒热之脉，无力无神，将何持而泻热去寒乎？”这段话是指脉有力无力而言，但还应注意脉的形态和节律，综合起来决定脉是否有神。

《灵枢·天年篇》曰：“失神者死，得神者生也。”可见神在对于论证疾病预后方面是何等重要！神的盛衰体现在精的充沛与否，以及气的盈虚。这三者的结合，精是脏腑功能活动的物质基础，气是脏腑功能的动力，神是脏腑功能活动的外在表现。古人称精、气、神为**人身三宝**，其旨奥矣。

二、如何治疗虚证？治疗虚证的原则当用补法。《灵枢·经脉篇》曰：“盛则泻之，虚则补之。”（《素问·阴阳应象大论》）曰：

“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。”补益乃是治疗虚证的基本法则。关于补法的作用，徐之才曰：“补可去弱。”此论可谓言简意赅，高度概括了它的作用。百病乘虚而入，如能在虚弱初见端倪之时，及早运用补法，调补正气，自可抵御外邪，何病之有？此为治未病也。即具有预防疾病发生的作用。

凡先天不足，体质素弱，久病失养，大病之后，以及产后失调所引起身体虚衰之证，如不及时补养，则体力难于康复。应当根据患者症状，辨认其气、血、精、津之盈亏，以及何脏虚弱，辨证施治，补其不足。因此，补法具有调摄和促进恢复身体健康的作用。

补虚之时，首辨阴、阳、气、血之盈衰，此四者乃人身活力之根本。培补阴、阳、气、血虽有重点，但不能截然划分。同时脏与脏又是有机的联系，互相制约，互相生化。李东垣《脾胃论》曰：“血不自生。须得生阳气之药，血自旺矣。”因此，补血时宜加入补气之药，以助生化，或重补气以生血；如大失血而虚极欲脱者，更应峻补其气，扶元固脱，使气返血生；如久病气血俱虚，则可气血双补。但补气之时宜少加补血之药，使气有所附，但补血药性多滋腻，不宜过多，多则易于滞气。

补阴、补阳亦是如此，阴阳相互依存的关系，名为阴阳互根，二者能够相互转化，阴可转化为阳，阳亦可转化为阴。如精化为气，寒化为热，即阴化为阳；气生精，热化为寒，为阳转化为阴。阴的不足可导致阳的衰弱；阳的不足亦可导致阴的亏损。故有“善补阳者宜阴中求阳”之说。血为气之母，血亏则气虚，气为血之帅，气虚则血的生化不足，故血亦少。其转化的结果是阴阳俱虚，精气两亏，气血皆虚。同时还有阴阳消长的特点，如阴虚则阳亢，阳虚则阴盛。另外在转化的过程中，亦可出现阳极似阴，阴极似阳的假象，即寒极生热，热极生寒，真寒假热，假热真寒的现象，在临床使用补法时不可不辨。

对五脏之补法，有直接补法和间接补法两种。直接补法即分补法。《难经·十四难》曰：“损其肺者益其气；损其心者调其营卫；损其脾者调其饮食，适其寒温；损其肝者缓其中；损其肾者

益其精。”即指五脏之分补法。

至于脏腑与脏腑之间是相互联系，相互作用的。可利用脏腑之间母子关系，相生、相克的关系，使用间接补法。如肺气的强弱有赖于水谷之气的供给，水谷之气与脾的运化密切相关，故肺气虚弱可以补益脾胃，即肺虚者用补脾之法；如脾阳须依肾阳之温煦才能发挥运化之作用，故脾不足者可温补肾阳，即脾虚者用补肾火之法；又如肝阴必依赖肾精的滋养才能发挥正常功能，故肝阴不足者可以滋养肾阴，即肝虚者用补肾水之法也。

在五脏补法之中，又有强调脾、肾二脏之说，因肾为先天之本，是真阴、真阳之所在；脾为后天之本，是气、血生化之源，故补肾、补脾是补法中最重要的一环。

此外尚有“气以通为补，血以和为补”，“腑以通为补”的说法。还有用泻来达到补的目的；用补来达到泻的目的。如用理中汤治疗虚寒便秘温运脾阳，可达到泻的作用；用大黄蟅虫丸以泻达到补的作用。又如为了防滞，多于补药方中加通药，如补中益气汤中的陈皮，即此意也。

综合上述，补法在未病时可以预防；在已病后可以治疗；在危病时可以急救；在体弱时可以调养。同时在临证治疗各种不同虚证时，应使用各种不同的补法。如峻补、滋补、平补、清补、温补、以及补阴、补阳、补气、补血、补心、补肝、补脾、补肺、补肾等均要根据各脏腑、气、血、精、津的不同虚损情况，使用培补之法。

《医学心悟》曰：“补之为义大矣哉！然有当补不补误人者；有不当补而补误人者；亦有当补而不分气血、不辨寒热、不识开阖、不知缓急，不分五脏、不明根干、不深求调摄之方以误人者。”可见运用补法之重要性，不可掉以轻心。临证应详审真伪，在辨证论治的基础上进行治疗。

按：人生之生存端赖脏腑充实与否。抵御外邪之入侵亦赖气血之盛衰。因此，医者对患者脏腑、阴阳、气血、精津之盈虚不可不辨。当识何脏为虚？何脏为实？应悟脏与脏相生相克与母子之关系。虽属实邪亦不可遽用攻伐之药，岂不闻“大积大聚其可

犯也，衰其大半而止，过者死。”《素问·六元正纪大论》之训乎？虽为虚证亦不可遽用峻补之药，岂不知脏与脏之母子关系，母盛子亢之理，治一经损一经之弊？使用补法之际应辨有无外邪之羁留，如遽用补药可使外邪弥留不解。使用补法亦在于巧，当补不补谓之失机，不当补而补谓之失治。临证慎之。

第一章 阳 虚

阳气衰弱则阴寒内盛。《素问·调经论》曰：“阳虚则外寒……阴盛则内寒。”其症见四肢厥冷。由于阳气虚弱，内脏虚寒，外表便要形寒怕冷；阳气不能布于四肢，故证见四肢厥冷，同时出现精神疲惫，倦怠乏力，喜卧嗜睡，少气懒言，自汗，面色晄白，夜尿频，大便溏，舌胖色淡，苔润，脉沉微弱而迟。《素问·阴阳应象大论》曰“形不足者，温之以气。”治宜用温中回阳法，用附子、肉桂、干姜、炙甘草。

四肢为诸阳之末。阳虚则气不能温运全身，症见畏寒；神气失养，故神疲善卧欲寐；阳气衰微，不能鼓动血液运行，故脉沉微而迟。此时治法宜“益火之源，以消阴翳”，用四逆汤加减救治。以附子大辛大热之药兴振阳气，逐祛寒邪；以干姜温中散寒；以甘草温养阳气，并缓和姜附燥烈之性，共成温阳之圣药。更应察其为心阳虚？脾阳虚？抑肾阳虚？分而治之。

四逆汤

熟附子 干姜 炙甘草

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《伤寒论》中。四逆汤有回阳救逆之功。四肢者为诸阳之末。由于阳气不足，阴寒内盛，阳气不能四布，以致手足厥逆；寒邪深入于内，脾肾阳衰，故下利清谷；阳虚不能温运全身，故恶寒。《素问·生气通天论》曰：“阳气者，精则养神。”今阳气虚衰，神气失养，必然蜷卧嗜睡，此乃阳气虚，阴寒盛之象也。宜用大辛大热之药，振兴阳气以祛寒邪。方中以附子大辛大热，温煦阳气，祛散寒邪为主药；以干姜

温中散寒，助附子回阳之力；以甘草温养阳气，并缓和姜、附，过于燥烈之性，共成回阳救逆之良方。《素问·至真要大论》曰：“寒淫于内，治以甘热。”此即四逆汤立方之宗旨也。

典型病例

林××，男，72岁，崇文区唐洗泊街42号，退休工人，1969年12月5日就诊。

患者年老体弱，精神疲惫，嗜睡懒言，肢冷畏寒，尿频便溏。查：面色晄白，舌淡苔白，两脉沉迟，偶见结代脉。

辨证：阳气虚损，寒自内生。

治法：以温中散寒，益气回阳之法。

处方：

党参10克 附子10克 干姜10克 肉桂10克

生黄芪20克 当归10克 远志10克 五味子10克

白术10克 炙甘草5克 生姜3片 大枣5枚

服药20剂，症状逐渐消失，又服人参鹿茸丸，附子理中丸各30丸，早晚各一丸服用，一个月后体力恢复。

按：阳气乃人体真元之气，今阳气虚损，则人的内脏生理功能必然低下，出现内寒之证。虚则补之，寒则温之，治疗此证当以温热之药，以驱散内结之凝寒。附子、肉桂、干姜为首选之良药，大热辛温能补命门之火，以复元阳，则内寒自解；同时可逐外寒，能温暖痼冷沉寒。以上三药诚为补火回阳，驱冷散寒之主药，无可比拟。

第二章 阴 虚

《灵枢·本神篇》曰：“五脏主藏精者也，不可伤，伤则失守而阴虚，阴虚则无气，无气则死矣。”阴虚必导致阳亢。此症由于阴津亏耗，虚火上炎，以致五心炽热，口干舌燥，烦躁易激动，怕热颧红，午后潮热，寐时盗汗，形体消瘦，便秘尿赤，舌红少苔，脉弦细数。阴虚无热者，用纯甘壮水之剂左归饮主之，以滋养生

化之源；阴虚有内热者，用培本清源之剂大补阴丸主之，以滋阴清热。阴平则阳秘，无不奏效。对于骨蒸劳热，热伏阴分亦为有效。

左归饮

熟地黄 枸杞子 山茱萸 炙甘草 茯苓 山药

方解：此方是明·张景岳所拟，载于《景岳全书》中。主治肝肾两虚，精血亏损，所致腰腿酸软、眩晕、耳鸣、盗汗、口干舌燥、遗泄不禁、小便自遗等症。此方在六味地黄丸的基础上，去泽泻、丹皮，增加枸杞子，以滋补肝肾，炙甘草益气建中组合而成，为纯甘壮水之剂，有补无泻，滋补之力量较六味地黄丸为大。凡精血亏损，津液不足之阴虚证，均可用之。

大补阴丸

黄柏 知母 熟地黄 龟板

方解：此方是元·朱丹溪立方，载于《丹溪心法》中。本方为滋肾阴降虚火的主方。阴虚生内热，故见骨蒸潮热，盗汗，足膝疼热等症。咳嗽咯血为虚火灼伤肺叶。如虚火扰胃，胃热则消谷善饥。根据“阳常有余，阴常不足”之说，应当经常养阴。故宜泻亢盛之阳，滋不足之阴。阴与阳相济，则水能制火，达到培本清源二者兼顾之目的。方中用黄柏苦寒泻肾火，以坚肾阴；知母清热滋阴，以保肺金；二者合用达到肺肾相滋的作用，这是清源的一面。而熟地黄滋补肾阴；龟板育阴潜阳，达到滋水以制火，这是培本的一面。合用成为滋阴降火之妙方。

典型病例

杨××，女，65岁，健康里 妇女，1970年10月3日就诊。

主诉：患者素有浸润性肺结核，经结核病防治所用抗结核药物治疗，惟面红颧赤，咽干口渴，午后低烧，烦躁不宁，查：脉细数，舌绛。

辨证：为阴虚火亢之证。

治法：以滋阴降火，清热除烦之法。

处方：

生地黄 10克 鳖甲 10克 青蒿 10克 龟板 10克

麦门冬 10 克 丹皮 10 克 黄柏 10 克 知母 10 克
地骨皮 10 克 白薇 10 克 赤芍 10 克 生甘草 5 克

经服药 30 剂，低烧退，烦渴消减，精神大为改善。嘱常服养阴清肺膏，辅助调养之。

按：阴虚的意义有三：第一是由于人体功能活动中燥的一方太过，静的一方不足，阴阳就失去平衡。这并不是阴虚导致发热，而是阳亢导致阴虚。第二是人体生命活动中所必需的某些物质缺乏。如：癭瘤病（甲亢）、消渴病等，乃生化阴精的脏腑功能发生障碍所致。第三是由于邪气留而不去，导致阴虚。这是慢性、消耗性虚热病所引起的后果。如：肺癆病（肺结核）的发热，不是阴虚所引起的发热，乃邪气（结核菌）羁留不去受邪热所伤，导致阴虚，应以去邪为主。第二种的消渴病等也应从病因方面治疗，不可一意舍本治标。

第三章 气 虚

此证多因大病之后，或操劳过度，损伤元气所致。故见头晕自汗，气短乏力，动则作喘，目无精彩，懒于言语，肢体倦怠，面色㿔白，口中无味，食欲不振，大便溏薄或脱肛，妇女则见子宫脱垂，脉沉微无力。用补益中气之法，宜四君子汤加减。方用党参、茯苓、白术、黄芪、升麻、生姜、炙甘草。

四君子汤

党参 茯苓 白术 甘草

方解：此方为宋代《太平惠民和剂局方》所立。本方是补中气，健脾胃之主要方剂。对于脾胃气虚，运化力弱，消化不良所引起的四肢无力，食少便溏，面色㿔白，语言轻微等症，有着良好的功效。方中用党参甘温扶脾养胃，补益中气，使脾胃健旺，运化力强，资生气血，为主药；脾虚每易生湿，故用白术健脾燥湿，扶助运化；茯苓之甘淡，合白术之苦温，以健脾渗湿；炙甘草甘温，补中和胃。合而用之，有甘温益气，健脾养胃的作用。

典型病例：

成××，男，68岁，退休工人，1969年12月5日就诊。

患者平素年老体弱，又兼感冒之后，损伤元气，近半月来，头晕自汗，面色晄白，动则作喘，肢倦懒言，气短神疲，食欲不振，脉弦迟，舌淡苔白。

辨证：中气亏损。

治法：以补益中气之法。

处方：

党参10克 白术10克 茯苓10克 生黄芪15克

怀山药10克 升麻2克 当归10克 炙甘草10克

生姜3片 大枣5枚

经服药15剂，精神好转，体力恢复。

按：《素问·生气通天论篇》曰：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰”。《素问·阴阳应象大论篇》曰：“阳生阴长，阳杀阴藏，阳化气，阴成形。”说明古人重视阳气在人体中之作用，如天体与太阳的关系一样，阳化而为气，气属于阳。因此气在人体中起着极其重要的作用。

气不足症，有气虚与气陷之分，气虚证临床多表现为头晕，目眩，少气懒言，疲倦乏力，自汗等症，活动时诸症增重。此病多见于年老体弱者或大病、久病之后，其病因病机乃由于元气不足，脏腑机能衰退，气虚不能营上则头晕，目眩。卫气虚弱失其固秘肌表之能，所以自汗。气虚则懒言。动则气耗，诸症自当加剧。

气陷为气虚病变另一种表现，是以气虚下陷，无力升举为其主要特征。如脱肛，子宫脱垂，胃下垂，肾下垂等症，即诸脏器失其升举之力，将在另章详加论述。

第四章 血 虚

此证多由过度忧愁思虑，营阴暗耗，或失血过多，以及妇女崩漏，产后失血等原因，损伤营血，以致头晕目花，急躁易怒，心

烦少眠，手足心热，朝凉暮热，皮肤甲错甚至拘挛。《内经》曰：“血虚则筋急也”，周身筋赖血以濡养，今血少筋失所养，故拘急也。拘急乃筋脉挛急，关节抽掣屈伸不利而言，两脉细涩无力。治当补养营血之法。用四物汤加减。方用当归身、杭白芍，熟地黄、川芎、丹参、鳖甲、龟板、阿胶等。前人谓“有形之血不能自生，生于无形之气。”故补血剂中常配以党参、黄芪、茯苓之类，以益气生血。血虚有寒加肉桂、炮姜以温养血脉；血虚有热加黄芩炭、丹皮。熟地黄易生地黄，以清热凉血。

四物汤

当归 川芎 熟地黄 白芍

方解：此方为宋代《太平惠民和剂局方》所立。以《金匱要略》中胶艾汤化裁而来，方中减阿胶、艾叶、甘草、名为四物汤。本方是补血的主方，又是调经的重要方剂。方中以熟地黄益肾补血，为主药；肝肾同源，肾虚则肝血亦虚，故辅以当归补血养肝，和血调经；再以白芍养血和阴；川芎和血行气，畅通气血，使补而不滞，营血调和。四药合用，具有补血调经的作用，多用于一般血虚、血滞之症。特别对于妇女月经不调，痛经，尤为有效。

典型病例

白××，女，42岁，北京拉锁厂工人，1970年10月9日就诊。

患功能性子宫出血月余。经治疗血已止，惟失血过多，血红蛋白已下降为6克，自觉头晕心烦，手足心热，面色晄白，脉迟涩，舌淡苔白。

辨证：气血两虚。

治法：益气养血，佐以升提之法。

处方：

党参10克 生黄芪10克 熟地黄10克 海螵蛸15克
蒲黄炭10克 棕炭10克 白芍10克 升麻3克
白术10克 麦门冬10克 茜草根10克 当归10克
肥知母10克 炙甘草5克 大枣5枚 生姜3片
连服10剂，症状消失，血色素上升至12克，体力恢复，痊

愈。

按：此章所论之血虚症，即相当于现代医学之贫血病的范畴，原因多由失血过多，或大病，久病，劳伤精血，身体虚衰，化源不足所致。心主血，肝藏血，脾统血，血乃后天水谷精微化合而成。同时脾有摄血的功能。如血液减少，全身出现青紫，乃脾不摄血，血不循经也。血生脾。今血虚则脾亦虚，恶性循环，焉有不贫血之理。因此补血亦当补脾，应在四物汤中酌加参、芪、术、草等补脾之药，使脾健运则血有生化之源，血充脾旺则自能摄血也。

第五章 气血两虚

气为阳，血为阴，气、血、阴、阳乃互为存在的依据，关系密切。因为“气为血之帅”，“血为气之母”，所以血虚常常影响到气虚，而气虚也可导致血虚。血属阴，气属阳，血亏又可引起阴阳平衡的失调。其主症多见面色苍白，唇舌指甲淡白，形气怯弱，精神疲倦，喜卧，脉沉细弱。用八珍汤加减。以党参、白术、茯苓、炙甘草、生黄芪益气，当归、阿胶、熟地黄、紫河车、鹿角胶养血。丸药可以使用人参养荣丸，功在气血双补。此病也包括相当于现代医学的再生障碍性贫血，纯属虚症。

八珍汤

党参 茯苓 白术 川芎 当归 白芍 生姜 大枣
炙甘草 熟地黄

方解：此方是明·薛己立方，载于《正体类要》中，有益气补血之功。主治病后失调，或久病失治，或失血过多等气血两虚之症。本方由四君子汤与四物汤合并组成，具有气血双补之功。以四君子汤加生姜、大枣，调和营卫治气虚；以四物汤补营而治血虚，使气血互相生长，本方已延循数百年成为对气血双补的有效良方。

人参养荣汤

人参 黄芪 白术 当归 熟地黄 远志 肉桂 陈皮
白芍 茯苓 五味子 炙甘草 生姜 大枣

方解：此方是宋代太平惠民和剂局所立。本方由四君子汤与四物汤共同组成八珍汤，减去川芎，增加黄芪健脾以补中气；远志、五味子补心肾以益智；生姜行阳散寒；肉桂益肾助阳；大枣调和营卫；补药之中佐陈皮以利气。此方使气旺以摄血，脾健血自生。可对于失血过多，气血两虚，心失所养而出现面色㿔白、心悸气短，四肢乏力，气血双虚之症，最为有效。

典型病例

李××，女，34岁，北京拉锁厂工人，自1968年起，因产后大出血调养不善，健康日渐下降，面色㿔白，精神萎靡，经常嗜睡和头痛，气短乏力。检查：血红蛋白6克，红细胞计数160万立方毫米，1970年5月4日来中医科治疗。

主诉：经常头痛、嗜睡，动则心乱，气短、乏力，月经行时量多，查：脉细涩，舌淡苔白。

辨证：气血两亏。

治法：以益气养荣之法。

处方：

党参10克 熟地黄10克 白芍10克 茯苓10克
白术10克 当归10克 川芎5克 阿胶10克
鹿角胶10克 炙甘草5克 生姜3片
紫河车面2克 冲二次

连续治疗半年，以此方加减共服药120剂，血红蛋白升至13克，红细胞计数390万/立方毫米，症状消失，又服人参养荣丸二个月，观察二年未复发。

按：血的功能可营养身体各部组织，如目之能视，足之能行，指之能握，都与血的功能有关。而血的功能，又必须在气的推动下，才能得到充分的发挥。如气虚则运血无力，化血无能，所以说“气为血之帅”，血虚则气亦虚，血脱则气亦脱，所以又有“血为气之母”的说法。气血在人体内是相互为用的，因此强调“气为生命之帝”。

第六章 虚 热

热有虚实之分，对热病后期，邪热耗阴，热留阴分，长期低热不退，并出现全身症状，肢体倦怠，食欲不振，口干舌燥，脉虚数，舌尖红，皆属虚热症也。在治法上宜用青蒿鳖甲汤加减；方用生地黄、青蒿、知母、丹皮、赤芍、鳖甲、地骨皮、白薇、银柴胡、生甘草，以透热养阴。

青蒿鳖甲汤

青蒿 鳖甲 生地黄 知母 丹皮

方解：此方是清·吴鞠通立方，载于《温病条辨》中。青蒿鳖甲汤有养阴清热之作用，为治疗虚热症之主方。方中用鳖甲直入阴分，咸寒滋阴，以退虚热；用青蒿芳香以清血中之热；二者共为主药。生地黄、知母清热养阴，以退虚热；丹皮助青蒿，以泄阴分之伏热。本方常用于治疗热病后期，热留伤阴，邪扰阴分，低热不退，以及阴虚骨蒸潮热之症，最为有效。

典型病例：

明××，女，40岁，中药厂工人，1972年12月4日就诊。

主诉：半个月前患重感冒，持续高烧10余天，经治疗体温逐渐减退，现上午体温正常，下午四点以后，体温逐渐上升，夜间37度5左右。头晕，心乱，周身无力，唇干口渴，食欲不振。

检查：脉细数，舌尖红，苔淡黄。

辨证：热邪滞留阴分，损伤阴津。

治法：以清热养阴，和解透邪之法。

处方：

银柴胡 10克 青蒿 10克 白芍 10克 肥知母 10克
丹皮 10克 大青叶 10克 麦门冬 10克 白薇 10克
生甘草 5克

连服10剂，低烧退，症状消失，恢复工作。

按：本章所论虚热多为温热病之后期，热留阴分，津液受燔

所致。这种虚热，阴液虽虚，但仍有余邪，已经化热，滞留阴分，故不能纯用滋阴之药，因滋阴之药可使余邪滞留阴分；更不能使用苦寒之药来清热，因苦寒之药化燥可伤阴。只能一方面养阴，一方面透热，使阴复以制火，邪去则热清，此者不可不晓。

第七章 虚 寒

虚寒之证多由命门火衰，元阳不足所致。因火不生土，寒必从内生。脾主运化，赖火以生。火虚不能生土，土虚不能胜湿。中土阴湿，焉能敷布精微，致令升降失常而生濡泻。或五更即泻，小便清长，少腹隐痛，面色㿔白，神疲嗜睡，肢体恶寒，手足不温，脉沉细而迟，舌淡苔薄白。此乃火亏于下，虚寒证也。虚则补之，寒则温之，治宜益火温中，以驱湿寒，应用理中汤加减温补治之。方中以党参、干姜为主，白术、炙甘草为辅，再加肉桂、吴茱萸等，益气健脾，温中散寒。

理中汤（丸）

党参 干姜 白术 炙甘草

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《伤寒论》中。此方有温中散寒，补益脾胃之功。宋代《太平惠民和剂局方》以本方加附子名为附子理中丸，主治脾胃虚寒证。脾胃属中焦而主运化之能，若脾胃阳虚有寒，就会出现肢体倦怠，手足不温，脘腹冷痛，呕吐恶心，不思饮食，泄泻清稀，腹满少食等症。本证多因脾阳素虚，过食生冷，寒湿内侵，脾阳受遏，清气不升，浊气不降，以致上吐下泻，寒邪内盛，阳气不伸，运化失常，腹满而痛，故泻下清稀。治以温运中焦，补益脾胃，使脾胃健运，升清降浊的机能得以恢复正常。方中以干姜温运中焦，祛散寒邪，恢复脾阳为主药；以党参补气健脾，振奋脾胃功能；以白术健脾燥湿；以炙甘草调和诸药兼补脾和中。本方对寒多者以干姜为主要药，虚多者以党参为主要药，虚寒俱甚者，则党参，干姜共同为主要药。如泄泻较重时，方中白术可用土炒，以增加涩肠止泻功能。如虚寒

较甚，出现面色晄白，手足不温，或昏睡露睛，可加熟附子，以加强温阳祛寒之力，名为附子理中丸。如再加肉桂，名为桂附理中丸，其补阳祛寒之功更大矣。

典型病例

崇××，男性，70岁，退休工人，1976年1月15日就诊。

主诉：半个月以来，少腹隐痛，痛即泻稀软便，日3—4次，畏寒喜暖，手足冰凉，精神疲倦，嗜睡，脉弦迟，舌淡苔白。

辨证：脾胃虚寒。

治法：以补脾止泻，温中散寒之法。

处方：

党参10克 黑附子10克 油肉桂5克 吴茱萸10克

茯苓10克 广木香3克 姜炭10克 白扁豆10克

炙甘草5克 生姜3片 大枣5枚

连服15剂，便泻腹痛均止，痊愈。

按：脾胃主腐熟水谷，司运化精微之职能。虚寒则水谷不能腐熟，精微不能运化，水液糟粕混杂而下，以致泄泻，此乃是因虚关门不固而易泻，气随泻去，气去则阳衰，愈泻愈虚。阳虚则寒从内生，不必感受外寒，而谓之寒，即此理也。当用温补，所谓虚则补之，寒则温之。因此治疗老年人的泄泻，首先考虑命门火衰所致，当用补火生土之法，温补元阳，使脾能健运，泄泻自愈。

第八章 阳虚自汗

阳虚则不能敛阴，卫气虚则不能外固，腠理疏故自汗出。汗为心液，汗出过多，心气必虚，阳不内守。故同时可出现心悸气短。治宜益气固表，敛阴止汗之法。用黄芪建中汤，牡蛎散加减。方用生黄芪、肉桂、白芍、炙甘草、大枣、生姜、煅牡蛎、麻黄根、浮小麦、白术、何首乌、熟地黄。使阳气充足，卫表固守，其汗自止。

至于中阳不振，阳气暴脱，大汗以致亡阳者，应以芪附汤加减，方用生黄芪、熟附子、五味子、肉桂、煅龙骨等。益气止汗，回阳固脱。

黄芪建中汤

黄芪 白芍 桂枝 炙甘草 生姜 大枣 饴糖

方解：本方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中。本方为《伤寒论》中小建中汤加黄芪。小建中汤即桂枝汤倍加白芍，重加饴糖所组成，使解肌发表之剂，变成温中补虚之剂。由于中气虚寒，不得温煦，以致脘腹挛急，时时作痛。脾胃乃营卫气血化生之源，脾胃不健，则营卫俱虚，导致阴阳失调。常见虚劳烦热，心气不足，心阳不振，心悸不安等，皆为气血不足之象。此乃阴阳两虚之候，在治法上，补阴则碍阳，补阳则耗阴，治宜调以甘药，温中补虚为主。方中以饴糖之甘平，补中缓急；桂枝之辛温，以温中散寒，两药合用取其辛甘化阳之义，共为主药。以白芍之酸苦微寒，和营敛阴；以甘草之甘平调中益气，二药合用，取其酸甘化阴之义。且甘苦相辅，能缓脘腹之挛急而止痛。用生姜、大枣调和营卫，对于气虚、阳虚者可加黄芪以补之，诸药合用，能使阴阳平调，营卫协和，脾胃健运，气血得充，诸症自愈。

牡蛎散

牡蛎 黄芪 麻黄根 浮小麦

方解：本方是宋·《太平惠民和剂局方》立方。主治自汗、盗汗。由于卫气虚衰，不能外固，阴血不足，不能内守，故汗出。汗为心液，汗出过多，影响心气，治宜益气固表，敛阴止汗，气充表固，其汗自止。方中用牡蛎敛阴潜阳，收敛止汗，为主药；黄芪益气固表为辅药；浮小麦敛心阴，止虚汗；麻黄根专于止汗，二药协助黄芪、牡蛎共为益气固表，敛阴止汗之有效良方。如因阴虚火旺而致的盗汗，应以当归六黄汤，滋阴降火，兼固表止汗；如大汗淋漓不止之亡阳证，则应以参附汤回阳救逆，均非本方所宜。

芪附汤

黄芪 附子

方解：此方载于《魏氏家藏方》中。芪附汤有补气助阳，固

表止汗之作用。方中黄芪大补元气，生用能固表止汗；附子大辛大热温壮真阳；二药合用，大补大温，具有回阳益气，止汗固脱的功效。对于元气大亏，阳气暴脱，冷汗自出，危在旦夕的阴竭阳亡危证，可速用急救。

典型病例

程×× 男，68岁，退休工人，1970年4月4日就诊。

主诉：近一年多爱出汗，面浮，下肢微肿。

检查：患者体胖，体质素弱。脉浮大，舌淡苔白。

辨证：阳虚卫表不固。

治法：以益气补阳，固表止汗之法。

处方：

生黄芪10克 黑附子10克 油肉桂5克 白芍10克
麻黄根10克 五味子10克 炙甘草10克 煅龙骨20克
煅牡蛎30克 白术10克 生姜3片 大枣5枚

经过两个月的治疗，连续服药30剂，汗止面浮肢肿消失，体力恢复痊愈。

按：自汗症临床多见于阳虚证中。《素问·生气通天论》曰：“阳者，卫外而为固也。”阳虚则卫外不固，而汗液自出，以黄芪建中汤，牡蛎散加减治疗屡效不鲜。但亦有因营卫不和而自汗者则应和营卫治之。《伤寒论》曰：“病常自汗出者，此为营气和，营气和者外不谐，以卫气不共营气和谐，故尔。以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈。宜桂枝汤”。唐容川曰：“盖此是营卫自病不是外邪。”服此方后应微微见汗，则自汗必止。按照《伤寒论》中的服法不可过汗，过汗则伤阳。张令韶曰：“桂枝汤能和营卫而发汗，亦能和营卫而止汗”。至于自汗见于外感病时，非虚证也，临证不可不辨。

第九章 阴虚盗汗

证属阴虚火扰，日晡潮热，心烦颧赤，咽干口渴，舌红少苔，

脉细数，此系阴液被火蒸越，故盗汗。治宜清火育阴，使火不内扰，阴坚则汗不外泄，可用当归六黄汤加减。方中用当归、生地黄养血以增液；用黄芩、黄连、黄柏、泻心火以清热；同时加牡蛎以收涩敛汗；加浮小麦以止汗；标本兼顾，以期速效。

当归六黄汤

当归 黄连 黄芩 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芪

方解：此方是金·李东垣立方，载于《兰室秘藏》中。当归六黄汤有滋阴清热，固表止汗之作用。主治阴虚有热所引起的低烧盗汗，面赤口干，唇燥心烦等症。方中用当归、熟地黄、生地黄养血滋阴，使营血充足阴津内守为主药；黄连、黄芩、黄柏清热泻火以坚阴。热清则火不内扰，阴坚则汗不外泄，汗出乃腠里不固，故用黄芪益气实卫，以固卫表，合而成剂，有滋阴清热，固表止汗之功，对于治疗阴虚火扰，盗汗发热之症，最为有效。如酌加浮小麦、麻黄根止汗，则效果更妙。

典型病例

景××，女，47岁，北京市前进鞋厂工人，1977年5月12日就诊。

主诉：4、5月来，经常头晕，夜间盗汗，心中烦热。查：脉沉细微数，舌红少苔。

辨证：阴虚盗汗证。

治法：以滋阴补肾，敛汗之法。

处方：

熟地黄 15克 黄柏 10克 黄芩 10克 生地黄 15克
青蒿 10克 知母 10克 浮小麦 30克 当归 10克
赤芍 10克 生牡蛎 25克 甘草 10克 生黄芪 10克
连续服药六付，症状消失，痊愈。

按：《素问·宣明五气论》曰：“五脏化液，心为汗。”《素问·阴阳别论》曰：“阳加于阴谓之汗。”阴虚火旺，心液被蒸，不能自藏而外泄，故见睡中盗汗。宜用滋阴降火，止汗固表法。当归六黄汤为治疗虚火甚者，其中芩、连苦寒可清心肺之火，但用量不宜过大。阴虚盗汗潮热重者，常以知母、黄柏合用，再加龟

板、鳖甲，甚为有效。

第十章 厥 逆

中医对病人昏迷称之为“厥”，西医称之为“休克”，“厥”有虚实之分。在辨证分型上有闭证与脱证之别。闭证为实证，脱证为虚证。

闭证之主要病理因素为痰火内闭，湿浊之气蒙蔽清阳，属火、属热、属风、属痰。为热入心包或为肝风内忤，引起厥逆昏迷，四肢抽搐，热深厥亦深，邪热炽盛，可由半昏迷状态，很快进入深度昏迷。应急以清热涤痰开窍之剂抢救，可使用牛黄清心丸、安宫牛黄丸凉开之药。

脱证之主要病理因素，为真阳衰微、真阴耗尽，阴阳两竭纯属虚证。厥逆虚脱症见：人事不知，昏迷不醒，面色苍白，身出粘汗，四肢厥冷已过肘膝；或由失血过多，气随血亡，正气陷于虚竭，生命存亡危在旦夕，脉沉细欲绝或见结代。此为阴阳乖逆，脏气不续，气随血脱，气阴两竭之危证。急宜益气养阴，救逆固脱之法。气阴竭者，用独参汤；阴阳两竭者，用参附汤；并灸关元、气海两穴，以便回阳救逆；同时灌服温开之药，苏合香丸以急救复苏。

闭证与脱症极易出现真热假寒，或假热真寒的虚假现象，医者不可不慎。施治谬误，鲜不立即毙命。惟辨证准确，抢救及时可使昏迷缓解而复苏，救生命于瞬息，方能起死回生。

独参汤

上等人参

方解：本方是明·张景岳立方。对元气虚竭，冷汗自出，手足厥逆，气欲息，血将脱，阴竭阳亡之危证，有起死回生之功。用上等人参三十克或五十克，浓煎顿服，挽救生命于瞬息之间。人参有大补元气之作用，能回阳固脱，但用量必须加大，方可奏效。

参附汤

人参 熟附子

方解：此方是宋代陈自明所拟，载于《妇人大全良方》中。参附汤有回阳救逆，益气固脱之功。主治元气大亏，阳气暴脱，出现手足厥逆，身出冷汗，呼吸微弱，脉细欲绝之危象。阳气暴脱则不能温通四肢，故手足厥逆；阳气暴脱不能鼓动血脉，故脉细欲绝；由于元气大亏则阴液亦随阳气暴脱而外脱，故见冷汗自出。此时若不急用大温大补之峻药，不足以回阳救脱。方中以人参大补元气为主药；用熟附子温壮真阳，二药合用大补大温具有回阳救逆，益气固脱之功用。药味虽少，力专效著，对于阴竭阳亡虚脱之危证（休克）以及血脱阳亡者（大出血）均可用此方急救。

苏合香丸

苏合香 安息香 白檀香 诃子肉 丁香 沉香 荜拔
香附 犀角 朱砂 乳香 木香 冰片 麝香

方解：此方是宋·《太平惠民和剂局方》所立。主治中风昏迷，不省人事，寒证气闭，用此药温开之。此方取诸药之香以开寒闭，与牛黄清心丸开热闭相对。苏合香丸乃温开寒阻关窍之良药。方中虽用犀角，但寒因寒用以为响导，与牛黄清心丸中用肉桂无异。苏合香气味香窜能通脏腑诸窍，为芳香化浊，理气辟邪之良药；安息香辛香入心安神辟秽；檀香辛温利膈，理气去恶；丁香辛温纯阳而温胃；沉香理诸气而调中，又能辟邪恶之气；荜拔辛热温中下气；香附、木香皆辛香行气之要药；乳香香窜入心，辛温能通十二经；朱砂辟邪；冰片、麝香香窜能通诸窍。此方芳香温开，只宜用于寒证气闭之证，对于虚脱证之昏迷者不宜使用。

典型病例

李××，男，81岁，老艺人，1973年5月23日就诊。

既往病史：年老体衰，患有低血压症，血压经常在80/50—70/40毫米汞柱（10.7/6.67～9.33/5.33千帕）之间，心率迟缓，经常在48～54次/分之间，律不整，有时遗尿。

家属代诉：患者是夜昏迷沉睡，次日呼唤不应，呈昏迷状态，经抢救五天，未见苏醒。同年5月28日请中医会诊。

检查：患者仰卧呈深度昏迷睡状，呼之不应，面色苍白，四

肢软瘫而厥冷，凉过肘膝，两眼瞳孔未散，有反射，脉沉迟，舌淡苔白。

辨证：证属年老阳气虚衰，感受寒秽污浊之气而厥闭，时久有虚脱之危。

治法：先以芳香化浊温开之药，开其寒浊秽恶之闭。

苏合香丸四丸，即刻服二丸，晚间再服二丸，次日苏醒。继用汤剂，补中益气、回阳救逆之法治之。

处方：

人 参 6 克 当 归 10 克 白 术 10 克 白 芍 10 克
肉 桂 5 克 干 姜 10 克 生黄芪 30 克 黑附片 10 克
五味子 10 克 麦门冬 10 克 炙甘草 10 克
连服五剂，体力恢复痊愈。

按：闭与脱是临床上两种危险症候，乃是疾病趋于死亡边缘的危象，如果能及时处理，有很多病人是可以转危为安的。祖国医学对此证早有认识，很多有经验的中医多能处理得当，可以起死回生。

对闭与脱，关键是“掌握病机，当机立断，分秒必争，及时抢救”按照这十六字诀辨证施治，无不转危为安。兹将闭证与脱证的症状列表于下以资鉴别（见表2）。

表2 闭与脱症状鉴别表

	闭 证	脱 证
1	目 张 开	目 闭 合
2	牙关紧闭	口开齿松
3	两手握拳	两手撒开
4	面色青紫	面色晄白
5	呼吸急促	呼吸微弱
6	无 汗	汗流不止

各 论

第二篇 心 虚 论

《素问·六节藏象论》曰：“心者生之本，神之变也；其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳……。”

又《素问·灵兰秘典论》曰：“心者，君主之官，神明出焉。”

以上两论今考之谓：“心”主宰着人体各项机能的活动，如五脏六腑的生理、四肢百骸的活动、思维情志的变化等等，都是在“心”的功能支配下发挥其作用。

又《灵枢·本神篇》曰：“所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。”

这说明由于“心”接触外在一切事物，所产生思维作用，从“思”产生“忆”而到“意”，决而到“志”定，从“志”定而再复计度，深思远虑，最后决定很好的措施，这就叫“智”。这一系列的思维过程，说明“心”的活动，相当于现代医学的大脑中枢神经的思维活动。

虽然古今中外在民间习惯上无不以“良心”、“心眼好”、“心眼坏”等等来表明人的思维，但是从现代医学中的生理解剖学来看，则早已认识到人的思维是来源于大脑中枢神经系统。由于大脑皮层兴奋灶的产生和活动，从而产生思维、意识、智能、记忆和感情。古代医家将这种功能统归属于“心”的功能。

中医讲的“心”是将它当作大脑中枢神经系统来理解的，将这种神经系统的功能，理解为心经的功能。而且中医对心的功能

除以上所说外，还有心脏本身的生理功能，如“心主血”。《灵枢·本神论》曰：“心藏脉，脉舍神。”神是指“神气”之神，脉是指“脉管”，心脏和脉管相连。《素问·痿论》曰：“心主身之血脉。”《素问·五藏生成篇》曰：“心之合脉也，其荣色也，其主肾也。”其主肾也是因为心属火，肾属水，火受水之制约的意思。因此，心有着两种生理意义。《金匱要略》曰：“胸痹不得卧，心痛彻背者”所指的真心痛，即指心脏本身而言。心痛彻背为痹痛加剧的表现，即相当于现代医学的心绞痛。

根据脏腑辨证关系来看，以心为主体，它与肺、肾、肝、脾均有密切关系。脏与脏失调即可发生病变，如心营耗损，必致营血不足引起血不养肝；如心火炽盛，引动相火，必致肾阴耗损；心火与肾水应相交通，

由于水火不能相济，亦可出现心悸、健忘、

失眠等病理变化；如心火旺，则肺阴为火煎迫，是为火刑金；脾为阴脏，脾阳依赖君火与相火来腐化水谷，如脾肾水湿过盛，势必消耗心火，起到对“心”克制作用。

(见图 4)

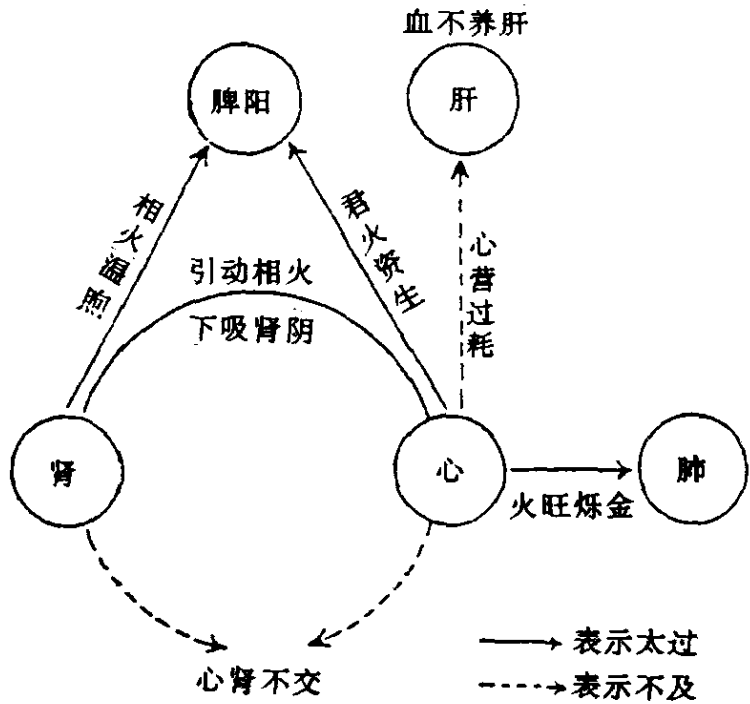


图 4 心病机理示意图

本书专论虚证，至于心火自炽、心火旺盛以及心气盛的癫狂等证，不在本书论述之内，故从略。

第一章 心 气 虚

此证多因长期忧愁，或持续精神紧张，以致心经受到损伤，心气虚弱从而引起精神萎靡，心跳气短，肢倦乏力，自汗出，四肢

清冷，面淡无华，食欲不振，脉细弱而迟。证属心气虚。应以补中益气、兴阳复脉之法。宜用炙甘草汤加减。方用党参、桂枝、麦门冬、阿胶、远志、菖蒲、干姜、茯神、炙甘草、大枣。

炙甘草汤

党参 生地黄 桂枝 麦门冬 麻仁 炙甘草 阿胶
生姜 大枣

方解：炙甘草汤又名复脉汤，是汉·张仲景立方，载于《伤寒论》中。此方能益心气，补心血，滋阴复脉，主治由于心气虚所引起的心悸气短，结代脉。本方重用炙甘草故名炙甘草汤，能益气补血复脉，为治疗心气虚所引起脉结代和心动悸的主要方剂。因其能复脉故又名复脉汤。心主血，血以养心，心脏的功能是靠心脏的阳气推动，心气虚，则营血运行迟缓，血行不畅，甚至动而中止复动，出现结代脉。同时还有心动悸和气短等症状。治宜益心气为主，兼补心血，养心阴，通心阳。此方兼而有之。用炙甘草甘温益气补中，化生气血，以复脉之本，是为主要药；党参、大枣补气益胃，以助气血生化之源；生地黄、阿胶、麦门冬、麻仁补心血，养心阴，以充养血脉；桂枝合炙甘草以兴心阳；合生姜以通血脉，使血行旺盛，共为辅佐。诸药合用，使心气复而心阳通，心阳足而血脉充，则心动悸，脉结代等症自除。本方为治疗心律不齐，期外收缩首选良方。仲景为后世留下此良方，至今奉行有效。

典型病例

李××，男，71岁，退休副食店售货员，1973年8月30日就诊。

主诉：胸闷、发紧、气短、乏力。

检查：脉迟无力，苔淡，心率41次/分，心律整，血压155/85毫米汞柱（20.7/11.3千帕）。

辨证：心气不足。

治法：以益气强心，活血通痹之法。

处方：

人参5克 当归10克 茯苓10克 桂枝10克

远志 10 克 菖蒲 10 克 附片 5 克 丹参 15 克

红花 10 克 五味子 10 克 炙甘草 10 克

方中附片自 5 克逐渐增至 20 克。

自 8 月 30 日至 11 月 27 日共服药 60 剂，症状消失，心率每分钟恢复至 70 次左右，痊愈。

第二章 心阳虚（胸痹）

心阳虚是指心的功能衰弱和温煦作用不足，较心气虚更为严重。二者皆由于久病体虚，老年脏气虚衰，或汗、下太过，耗伤阳气所致。

心阳虚所引起的疾病主要为胸痹证。由于胸中之阳气不足，不能推动全身营卫的运行，以致心动迟缓。病人多有肢冷畏寒的症状。心脏本身发生气滞血瘀，心肌血液运行阻滞，从而引起供血不足，出现缺血性心绞痛，此即所谓真心痛是也。《灵枢·厥病篇》曰：“真心痛，手足清至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。”以及“乍间乍盛，间歇发作”等，形象的描述心绞痛发作时四肢厥冷和“旦发夕死”的危险情景，如不及时抢救，即可发生暴死。同时提出用薤白治疗此病的方剂。出土汉简上也记载：对胸痹用人参、细辛、菖蒲等益气温通之药治疗。

一、胸痹（冠心病）脏腑辨证

胸痹证的发生，是由于心经与肺经出现气虚；脾阳与肾火的虚衰而出现阳虚；肝肾阴虚与心阴不足而造成的阴虚；气虚和阴虚又可导致肝阳亢盛。阳虚、气虚、阴虚表现动力不足，这三种任何一种或两种的虚衰，都可以造成心脏本身发生气滞血瘀的病理现象。阳亢是标肺气虚、脾肾阳虚是因、是本。最后导致心阴虚、心气不足发生气滞血瘀而产生胸痹痛。因此，冠心病、心绞痛是气滞血瘀的表现，而气滞血瘀则又是心、脾、肝、肺、肾等脏腑阴阳气血盛衰的结果。（见图 5）

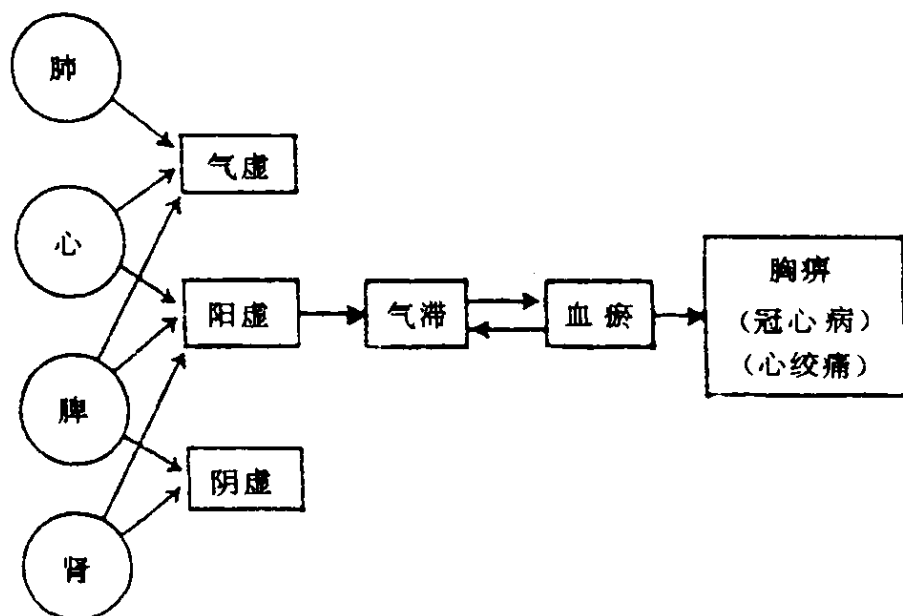


图 5 胸痹证脏腑辨证关系示意图

二、胸痹(冠心病) 辨证分型

(一) 血瘀型

临床以胸闷憋气，胸中刺痛，阵阵发作，疼痛时引肩掣背为主要症状。祖国医学对机体各种疼痛的发生，认为“不通则痛”。由于胸痹的发生皆为气滞血瘀，血脉不通，因此出现心前区疼痛，重则绞痛。又认为“寒则凝，温则行。”所以在治疗此证用活血化瘀，宣痹通阳之法，以血府逐瘀汤加减。方中用当归、丹参、红花、川芎、桂枝、远志、赤芍、党参、桃仁、桔梗、甘草等。

(二) 阳虚型

患者平时身体畏寒，发作时心悸骇怕，四肢厥冷，身出虚汗，面色苍白，气短乏力；脉沉细而迟，舌淡苔白，舌边有青色瘀血斑。证属：心阳不足。应以益气补阳，活血化瘀之法治之。宜用四逆汤加减；方用人参、赤芍、附子、干姜、当归、远志、桂枝、丹参、菖蒲、红花、三七、炙甘草等。

(三) 阴虚阳亢型

患者素日阴虚不能涵阳，阳失所养，则亢逆而上炎，营阴虚亏不能濡养心肌则出现胸闷，憋气或真心痛，同时伴有头晕、头

痛，烦躁不安，易于激动，面赤烦热，口干舌红苔黄，血压亦升高，此乃阴虚阳亢之象征。宜用滋阴降火之剂兼加活血化瘀之药，用大补阴丸、血府逐瘀汤加减。方中用知母、生地、玉竹、茯苓、泽泻、丹皮、红花、桃仁、桔梗、丹参、牛膝等。

（四）痰饮阻滞型

患者由于脾肾阳虚，不能蒸发散布水津，瘀留变为痰饮，弥留于胸中，侵及心脏，阻碍其气血之运行，于是出现真心痛，气短，胸闷，痞满等症状，为胸痹证。宜用通阳宣痹，导滞化痰之法。以瓜蒌薤白汤、二陈汤加减。方用全瓜蒌、薤白、清半夏、橘红、天南星、茯苓、桂枝、丹参、川芎、生姜等。

（五）虚脱型

心脏由于长期缺血，造成心肌坏死，发生梗塞，病人首先表现精神萎靡不振，继而发生意识模糊，面色苍白，心悸气促，身出冷汗，四肢厥逆，指端青紫，唇周发绀，津液短少，舌质紫暗；脉沉细、迟缓、结代。证属：阴竭阳绝虚脱之象。急以益气回阳，救逆固脱之法，佐以增液敛阴之药。宜用四逆汤和生脉散加减。方用人参、附子、干姜、肉桂、黄芪、五味子、当归、丹参、白芍、白术、茯苓、炙甘草，并用苏合香丸温通醒窍之药来抢救，希冀于顷刻。

按：阳能化气，气属于阳，气虚为轻，阳虚较重。冠心病阳虚者以补阳为主，兼补其气。阳不虚者其气亦虚，气虚必造成气滞，气滞则无力运行血液，必导致血液之瘀阻。故阳不虚者亦应补气以治其本。如阴虚阳亢者与痰饮阻滞者乃本虚标实之证，在急则治标的原则下应先治标为主，俟阳潜痰消之后再以益气滋阴之药治其本。治疗冠心病应辨证施治，何时治标，何时治本，或标本兼施，不可专用活血化瘀一法。气不足则血行缓慢，故导致心血不足，不能供养心脏，心肌缺血必出现真心痛。

血府逐瘀汤

当归 生地黄 桃仁 红花 枳壳 赤芍 桔梗 川芎
牛膝 柴胡 甘草

方解：此方是清·王清任所拟，载于《医林改错》中。本方

主治胸中气滞，血行瘀阻所致胸痛日久不愈，必须使用活血祛瘀之法治疗。方中以当归、桃仁、红花活血祛瘀为主药；川芎、赤芍协助主药以活血祛瘀，为辅药；生地黄配当归养血和血，使祛瘀而不伤阴血；牛膝祛瘀而通血脉；柴胡、枳壳、桔梗舒畅胸中气滞，使气行则血行，均为佐药；甘草协调诸药为使。组合而用，使血行瘀去，诸症可愈。

大补阴丸

方解见第一篇总论，第二章“阴虚”中。

瓜蒌薤白半夏汤

全瓜蒌 薤白 制半夏 白酒

方解：此方为汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中。主治胸中阳气不振之胸痹证。因为诸阳受气于胸中而转行于背，胸阳不振，津液不能输布，凝聚为痰，痰阻气机以致胸部隐痛或胸痛彻背；痰浊阻滞，肺气宣降失常，而症见咳唾，喘息，短气等症状，为胸中痰浊聚结之征象。治宜用通阳散结，行气化痰之药。方用全瓜蒌祛痰、散结、开胸，为主药；薤白通阳散结，行气止痛，为辅药；二药相配，一除痰结，一通气机，相辅相成，为治胸痹之主要药；以半夏燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，并借白酒上行之力，以加强诸药之作用。使胸中阳气宣通，痰浊得散，气机得畅，胸痹自除。

四逆汤

方解在第一篇总论第一章“阳虚”中。

二陈汤

制半夏 陈皮 茯苓 炙甘草

方解：此方是宋·太平惠民和剂局所拟。本方主治因饮食生冷，脾胃不和，健运失常，湿聚为痰，痰阻胸膈，气机不畅，以致痞满不舒；浊阴凝聚，清阳不升则头目眩晕；痰饮凌心则心悸不眠。此皆因痰湿为患也。治宜燥湿化痰，理气和中，使湿去痰消，气机通畅，脾得健运，诸症自解。方中用半夏燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，为主药，以陈皮理气化痰，使气顺痰降，气化痰消；痰由湿生，故以茯苓健脾利湿；以甘草和中健脾。综合

各药，此方具有燥湿化痰，理气和中之功效。

生脉散

人参 麦门冬 五味子

方解：此方是金·李东垣所拟，载于《内伤外感辨惑论》中。主治中气不足，津液耗伤等证，能益气生津，使元气振奋，津液增生。方用人参补肺益气而生津，为主药；麦门冬养阴清肺而生津；五味子敛肺止汗而生津。三药合用，一补、一清、一敛，具有益气敛汗，养阴生津之作用。立方简练而严紧，为益气强心，养阴生津之良方。

苏合香丸

方解在第一篇总论第十章“厥逆”中。

按：胸痹病似为现代医学冠心病之一种。由于心脏冠状动脉供血不足，心肌严重缺血，产生心绞痛即真心痛病。按照中医理论：气为血之帅，阳能化气，气属于阳之道理，气阳不足则血行迟缓，气虚较轻，阳虚为重。气阳虚亏无力运行血液，必导致血液之瘀阻或痰饮之阻滞，因之气虚、阳虚乃此病之根本，痰饮阻滞或血液瘀阻为标。临证时常出现本虚标实之象。在急则治标的原则下，可先治标。俟血行、痰消之后再以益气滋阴或益气补阳之法治其本，不可专用活血化瘀一法施治。

余在治疗心绞痛时用热黄酒送人参粉与三七粉，疼痛立止，效如桴鼓，即此理也。

典型病例

巩×× 男，54岁，张家口东方红机械厂副厂长。

既往史：患高血压、冠心病已有一年余，心绞痛反复发作，经中西医治疗无效，不能控制病情，故来京治疗。1977年12月5日就诊。

主诉：一年来胸闷憋气，左胸心前区时有刺痛感，时间短促并反射到左肩及后背，疼痛多在夜间，同时伴有心跳气短。过去曾服牛黄清心丸，服后疼痛加剧。

检查：患者身体较胖，体质中等。血压为160/100毫米汞柱(21.3/13.3千帕)，心率75次/分，偶见间歇；脉沉细，有时出现

结代脉；舌淡苔白。心电图：窦性心动过缓，V₄、V₅、ST段下降。

辨证：心阳不振，胸痹，真心痛病。

治法：以益气通阳，活血化瘀之法。

处方：

人 参 5 克 附 片 10 克 肉桂 5 克 茯 苓 10 克
白 术 10 克 丹 参 20 克 当归 10 克 五味子 10 克
干 姜 10 克 远 志 10 克 红花 10 克 菖 蒲 10 克
炙甘草 10 克 三七面 5 克（冲二次）

连续服用 15 剂疼痛停止，各种症状消失，恢复工作。嘱经常服用通脉片。并嘱身体应注意保暖。以后不能再服牛黄清心丸及大凉大寒之药。

按：治疗冠心病、心绞痛使用活血化瘀之通法，是可以收到较好之效果，但是如果虚象得不到纠正，疗效是不能巩固的。所以在使用通法治疗时，应加用补虚之药。即：以通为补，欲补先通，通补兼施，更重要的是以补为主。

心气虚与心阳虚都是心的生理功能失调所引起的疾病。心气虚是心的功能不足；心阳虚是心的功能衰弱和温煦作用不足，二者都有心悸气短，活动加重和自汗等表现。心阳虚较心气虚为重。（见表 3）。

表 3 心气虚与心阳虚的鉴别诊断

心 气 虚	心 阳 虚
面 淡 无 华	面 色 苍 白
口 唇 淡 红	口 唇 青 紫
气 短 乏 力	胸 闷 憋 气
无 心 前 区 痛	阵 发 性 刺 痛
自 汗 出	大 汗 淋 漓
精 神 萎 靡	神 志 模 糊
四 肢 清 冷	四 肢 厥 冷
脉 细 弱 而 迟	脉 结 代 或 微 细 欲 绝
舌 淡 苔 白	舌 淡 或 紫 暗 而 胖 嫩

第三章 心 阴 虚

汗为心之液，心阴者即津液也。古代医家认为津液是一种液体。《灵枢·决气篇》曰：“腠理发泄，汗出溱溱是谓津。”“谷入气满、淖泽注于骨、骨属屈伸泄泽、补益脑髓，皮肤润泽是谓液。”这对津液在机体内活动情况及作用形容十分透彻。它分布于周身各处，内至五脏六腑，外至皮肤、肌肉皆其所布。在生理机能上，饮食入胃经过消化、吸收精华通过血液运行，把营养物质送到全身各部，然后将多余的液体，随同废物，通过尿、大便、汗腺、泪排出体外。因此体液内除水份外还有大量营养成分在内；而水液之含量，机体本身是会维持平衡的；过多过少均由人体的调节机能来维持平衡，多则增加排泄，少则减少排泄，使人处于健康状态。但这种调节机能，又有一定限度的，患者由于长期失水，如自汗、盗汗、久泻，或高烧后大量损失津液，就会造成心阴虚损的现象。津液失，必伤元气，临床症见，心慌心悸，惶惶不安，五心烦热，少寐多梦。患者除消瘦、口渴、口干，重者眼窝凹陷外，同时自觉疲倦乏力，心跳气短等气虚现象，脉沉细或微数，舌红少苔。宜用天王补心丹加减。方中用生地黄、元参、天门冬、麦门冬，五味子、当归、党参、丹参、茯苓、远志、酸枣仁。有汗者可加生黄芪、生龙骨、生牡蛎、浮小麦等。

天王补心丹

生地黄 五味子 当归 天门冬 麦门冬 柏子仁 酸枣仁
太子参 茯苓 元参 丹参 远志 桔梗 朱砂

方解：此方载于《摄生秘剖》中。主治阴亏血少，阴虚阳亢所致的虚烦心悸，睡眠不安，精神疲倦，梦遗健忘，大便干燥，口舌生疮，虚热盗汗等症。此方以滋阴为主，治其本；以安神治其标。阴充神得所养则心自安。方中以生地黄、元参、天门冬、麦门冬甘寒之药滋补阴液，生津清火为主药；以丹参、当归补血养心；党参、茯苓益心气；柏子仁、远志、安心神；五味子、酸枣仁之酸温以敛心气，心平则神自安；桔梗载药上行；朱砂入心安神。诸药合用，共成滋阴安神之剂。

典型病例

王××，女，42岁，北京拉锁厂工人，1962年11月6日就诊。

主诉：患重感冒，持续高烧十余天，口干、口渴、心跳、气短、夜不入寐、身体消瘦，眼窝凹陷。

检查：脉沉细而数，舌绛无苔。

辨证：由于失汗过多，汗为心之液，为严重失水心阴虚损证。

治法：以滋阴增液、养血安神之法。

处方：

生地黄 15克 天门冬 10克 麦门冬 10克 石斛 20克
花粉 10克 元参 10克 五味子 10克 知母 10克
生甘草 10克 阿胶 10克 煅龙骨 20克 煅牡蛎 20克
大枣五枚

连服 15剂，症状消失，身体康复，恢复工作。

按：心阴虚与心血虚皆为阴血亏虚。阴乃津液，即现代医学的血浆，它可以通过血管壁渗透到血管以外，即渗透压的作用。并可蒸发到皮肤以外，即中医所讲“汗为心之液”。因此汗多可伤心阴，高烧可灼心阴。当阴虚液少时可生内热。如五心烦热，口干舌燥，咽干少津等症。津液与血混合一起，受君火的推动，运行全身，无处不至；受相火的温煦和蒸发，化气排汗。因此心阴经常损耗，它依赖中州脾胃化合水谷之精微来补充之。体内水液的调节是可维持平衡的。当津液损伤太过（大汗）或水液大量丢失（大泻）时可产生脱水现象，此乃阴之虚极也。必出现热象，此即阴虚生内热之热，乃阴虚也。治疗心阴虚必须用补其不足之阴，泻其有余之阳，古人称之为“补心体，泻心用”者，是也。

第四章 心 血 虚

心血虚即心血不足也。《素问·五脏生成篇》曰：“诸血者皆属于心”，《素问·阴阳应象大论》曰：“心生血”，《金匱·血痹虚

劳篇》曰：“男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者里虚也”。明·戴明思《秘传证治要诀》曰：“诸失血后，多令面黄，盖血为荣，面色红润者，血荣之也，血去则面色萎黄。”根据以上论述心血不足包括现代医学所说的贫血病。凡身体轻微的失血，自身机体是有代偿能力的，惟失血过多或反复长期失血不已，造成贫血现象。如咳血、吐血、便血、妇女月经过多，产后失血等。祖国医学在这方面早已积累了丰富的经验，疗效卓越。在治疗贫血时首先应辨认出血部位，和出血原因，给以止血治疗；止血后再用补血方法。清·唐容川《血证论》曰：“载气者血也、运血者气也。人之生全赖乎气，血脱而气不脱，虽危犹生，一线之气不绝则血可徐生，复还其故；血未伤而气先脱，虽安必死。”凡失血之后，其气必伤，气虚更不能摄血，血不循经，势必妄行；恶性循环病势日剧。临床症状：头晕、心悸、四肢无力、面色晄白，脉芤或涩或濡，舌淡无苔者宜四物汤加减：当归、熟地黄、杭白芍、酒川芎、白术、黄芪、党参、炙甘草、大枣。由于血虚火旺，手足心热盗汗者，加盐黄柏、盐知母。心为火脏，无血以养则火气冲动因而怔忡，俗称心跳，宜加麦门冬、朱莲心，或加朱砂。君火虚则悸，惊悸者惧怯之谓也。心为君火，君火宜明，明则不忧不惧，何悸之有？心火不足，则气虚而悸，血不养心则神浮越而惊悸，治宜人参归脾汤加减。方用党参、熟地黄、黄芪、桂枝、远志、茯神、杭白芍、当归、煅龙骨、龟板、鹿角胶、炙甘草，补中益气，养血而安神。

人参归脾汤

党参 白术 茯神 黄芪 龙眼肉 木香 当归 远志
酸枣仁 炙甘草

方解：本方原为宋·严用和立方，载于《济生方》中，后经宋·陈自明校正增当归、远志二味，成为上方。主治心脾两虚，气血不足所致心悸气短，健忘失眠，食少体倦，面色萎黄等症。方中以四君子汤补气健脾，使脾胃健运，则气血自生，气能统血，为主药；黄芪、当归为当归补血汤，以补气生血，使气固血充；龙眼肉、酸枣仁、远志养心安神；木香理气醒脾，使补而不滞；生

姜、大枣调和营卫。本方补气健脾之药较多，意在益气以生血，使气旺以摄血，故对心脾两虚，营血虚弱以及脾不统血诸症至为有效。

四物汤

方解：见第一篇虚证论第四章“血虚”中。

典型病例

杨××，女，34岁，北京第52中学教员，1978年10月30日就诊。

主诉：患贫血已三年，由于生育二胎大出血后引起贫血，经常头晕、疲倦无力、月经过多，有时失眠。

检查：面色黄白、唇淡无神，苔淡薄白，血红蛋白经常在7克左右。脉沉细而涩。

辨证：心血虚（贫血病）

治法：以调经养血、补心安神之法。

处方：

党参10克 白术10克 远志10克 川芎3克
龟板10克 白芍10克 当归15克 熟地黄10克
艾叶炭10克 鹿角胶10克 阿胶10克 炙甘草5克

经过半年治疗服药150剂，症状消失，血红蛋白升至13克左右。继服人参养荣丸，每日2丸，服用三个月，体力恢复，痊愈。

按：血虚气亦衰，血之生成，源于气化。因此，在治疗血虚时除用四物汤外重用补气之药，以促进血的滋生。川芎升浮之力甚强，上行至头，其性香窜辛散，能走泄真气，故用量不宜过大，多用伤人，慎之。

现代医学的贫血病，有缺铁性、营养性和再生障碍性的不同。中医所说之心血不足多指营养性质之贫血。

第五章 心阴心阳两虚

此证多因平素体质虚弱，兼为温邪灼伤津液；或产后失血过

多，气血双亏，心阴为之大伤，心阳为之耗尽，以致血脱阳亡，真阴濒绝，阴阳有睽离之势。症见：精神萎靡，昏睡无神，四肢厥逆，大汗淋漓，气息微弱，脉结代。成为阴竭阳亡之危证。即现代医学心力衰竭及休克前驱期，危在顷刻，应急救之。宜以参芪益气汤加减。方用人参、麦门冬、五味子、熟地黄、肉桂、附片、菖蒲、远志、茯苓、炙甘草、生姜、大枣。益气养阴，回阳固脱。

参芪益气汤

人参 黄芪 白术 五味子 生姜 陈皮 甘草 附子
麦门冬 大枣

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。主治气虚阳厥，手足厥冷，大汗淋漓，阴阳两虚之厥逆证。方中以人参大补元气，为主药；黄芪补益中气，升阳固卫；白术、甘草甘温益气，补脾益胃；脾胃为气血营卫生化之源，脾胃强健，则正气自充。麦门冬养阴生津；五味子生津止汗；脾虚多致气滞，故用陈皮理气化滞；附子温壮真阳；姜、枣同用以调和营卫。合而为剂，具有回阳、益气、止汗、固脱之作用。

典型病例

陆××，女，68岁，家庭妇女，住北京市东城区大学夹道14号。患者年老体弱，素有糖尿病。于1965年12月5日因感时邪而头痛、高烧、恶寒、恶心、不思饮食、四肢酸痛，经中西医药治疗一周，高烧逐渐消退，体温下降至35度。正气大衰，阴阳两伤，奄奄一息，危在顷刻。12月15日延余前往。

症见：目闭昏睡，呼叫似应似不应，不能回答问题，声音微弱，两目无神，呼吸短浅，口干少津，体温不升，手足厥逆，冷过肘膝，数日不食，每日给以牛乳充饥，小便少，大便数日未行，脉沉细而迟，有时出现结代脉，血压70/40毫米汞柱（9.33/5.33千帕）。

辨证：高烧伤阴，阳随阴脱，阴阳两伤，阴阳有离决之势，急给以参附汤回阳救逆固脱之剂，以挽救垂危之生命。

第一次处方：

人参10克 黑附片10克，微火久煎成浓汁，频频灌下。经

过一昼夜，次日阳回神智较前清醒，索要食物，给以糖粥，病情大有转机。

第二次处方：

人 参 6 克 麦门冬 10 克 远志 10 克 茯 苓 10 克
生黄芪 20 克 附 片 10 克 白术 10 克 油肉桂 10 克
五味子 10 克 炙甘草 10 克 生姜 3 片

按照上方连服 10 剂，坐床饮食，上肢已能活动，以上方加砂仁 3 克，陈皮 5 克又服 20 剂，经过一个月治疗和调养，痊愈。

按：心力衰竭患者，全身机能降低。由于病人心跳缓慢，心脏血液输出量的减少，各组织器官严重缺氧、缺血，尤其是脑部缺氧、缺血，使大脑皮层功能低下，可引起意识模糊，软弱无力，面色苍白，身出冷汗，血压下降，脉微细。如不及时抢救，短暂时间即可意识丧失，进入晕厥及休克，可因呼吸与心搏暴停而死亡。临床必须审慎处理。要求：一、诊断正确；二、掌握病机；三、处理得当，方可挽救生命。不然诊断错误，失去病机，处理不当，其后果则不堪设想。

第六章 心脾两虚

此证主要由于饮食不节，劳倦内伤，病后失养或失血之后，以致心脾两虚。心生血而藏神，肝藏血而主筋，脾统血而主运化。脾气充足则血自有生化之源，心神得养，血有所统；心血旺则脾气健运，何病之有？

若因思虑过度，耗伤心血或慢性出血，心血亏虚则影响脾的健运；若饮食不节，脾气受损，运化失职，血的化源不足可导致心血亏耗。血少不能上荣，故出现头晕目眩，心悸气短，四肢乏力，食欲不振，形体消瘦，面色苍白，唇甲色淡，脉虚无力，以及失眠等症。宜用人参归脾汤加减。方用党参、黄芪、当归、白术、阿胶、熟地黄、龙眼肉、茯神、远志、陈皮、炙甘草、煅龙骨、煅牡蛎、五味子等。益气健脾，养血安神之法治之。

人参归脾汤

方解见本篇第四章“心血虚”中。

典型病例

李××，女，29岁，崇文小学教员，1978年8月3日就诊。

主诉：产后月余，由于失血过多，以致出现头晕、心跳、气短、四肢乏力、失眠等症，现恶露已净，未哺乳。

检查：脉沉细、无力、舌淡白。

辨证：心脾两虚。

治法：以补心健脾，益气安神之法。

处方：

党参10克 当归10克 远志10克 菖蒲10克
龙眼肉10克 炒枣仁10克 白芍10克 白术10克
生姜3片 炙甘草10克 大枣5枚

连服15剂，症状消失，体力恢复而痊愈。

按：心脾两虚证为临床常见病。心血不足，心神失养则出现心悸气短，怔忡健忘，多梦失眠等。此证宜用心脾同治之法，

人参归脾汤方中用补气健脾之药较多，意在益气以生血，使气旺能摄血也。对于脾虚血少之出血证，如营养不良性贫血，血小板减少紫癜等可加阿胶、何首乌、鹿角胶等补血、止血之药。亦可获得较好疗效。

第七章 中风（脑血管意外）

中风是以猝然昏仆，不省人事，伴有口眼喎斜，语言不利，半身不遂；或不经昏仆而仅以喎僻不遂为主证的一种疾病。由于一侧枯萎不用又名偏枯。祖国医学对中风病的认识，千古以来，历代医家各有论述，意见颇不一致。尤其是近百年现代医学传入我国以后，结合西医病因、病理来研究，此病多属于脑血管发生意外而产生的，因此是属于中医所说的内风。外风的论点有待商榷。

《素问·风论》曰：“风中五脏六腑之俞，亦为脏腑之风，各

入其门户所中，则为偏风。”书中并无专篇详细叙述。汉·张仲景在《金匱要略》书中对中风之脉证及中经、中络、中脏、中腑虽有论述，但没有详尽的主治方药和治疗方法。唐·《千金要方》曰：“中风大法有四：一曰偏枯、二曰风痲、三曰风懿、四曰风痹。”进而述说症状，皆以大小续命汤为主治，混风痲于其中，以表散风寒为主要治法。明·张景岳对中风证提出正名，易中风为非风。《景岳全书·论正名》曰：“非风一证，即时人所谓中风证也。此证多见卒倒，卒倒多由昏愤，本皆内伤，积损颓败而然，原非外感风寒所致。而古今相传，咸以中风名之，其误甚矣。”又曰：“以厥为风，即名风，安得不从风治，既从风治，安得不用散风之药？以风药而散厥证，所散者非元气乎？因致真阴愈伤，真气愈失，是速其死矣。”所论甚为精辟。又明·薛立斋曰：“中风乃真水竭、真火虚、肝郁脾虚及诸虚所致。”清·徐灵胎、叶天士等各家，创虚风、暗风之学说，易古人之外风为内风，在学理和治疗上为之一新，这种论点是正确的。

由于中风病在中医学理和疾病名称上的不当，医者皆以祛风之药为主，千古以来不知枉杀多少人，至今贻害非浅。

中风病之发生病理虽较复杂，但归纳不外有六端：一虚（阴虚、气虚），二火（肝火、心火），三风（肝风、外风），四痰（风痰、湿痰），五气（气逆），六血（血瘀）。其中以肝肾阴虚为其根本。由于外邪侵袭而引起发作者称为外风，又称真中风，或真中。无外邪侵袭而发病者称为内风，又称类中风，或类中。从临床上来看，本病主要以内因引起发作者居多，外邪侵袭作为诱因发病者较少。内虚是主要条件，当外邪解除后，仍应以治本为主。

此病主要由于肝肾阴虚，木火上扰，血气并走于上，痰火上壅，肝阳化风，肝风内动，乃内风也。其根为下虚，上实为假象。在急则治标的原则下，宜清热涤痰，潜阳熄风清理之。下虚为肝肾不足，气血虚衰，乃真虚也。俟风熄痰降，病情稳定后，再滋补其下，为治本也。

至于病后半身不遂者，乃气血瘀滞，络脉痹阻，应以活血化瘀，疏通经络为主，不可妄用风药。

一、中 经 络

为中经中络，乃邪之浅也。由于肝肾阴虚，风阳内动，气逆血菴，症见头晕头痛，耳鸣目眩，腰酸腿软，突然发生口眼喎斜，舌强语蹇，半身不遂，舌红苔黄，脉弦细数。如神识不清者为阴虚阳亢。痰热内闭，属于本虚标实之证。应先给以醒窍熄风之剂，用镇肝熄风汤加减。方用橘络、清半夏、茯苓、菖蒲、麦门冬、龟板、生牡蛎、白芍、远志、生赭石、生龙骨、甘草、竹沥水等。并加服牛黄清心丸清热涤痰凉开之药。俟神志清醒，病情稳定后，余有半身不遂者，当治其本，此乃阴虚络阻也。应以益气养阴，活血通络之法，用六味地黄汤、通窍活血汤加减治之。方用熟地黄、山茱萸、当归、丹皮、泽泻、茯苓、赤芍、川芎、丹参、红花、桃仁、乌蛇、地龙、鸡血藤、桂枝、甘草等。

二、中 脏 腑

为中脏中腑，乃邪之深也。此乃危急重症，其主要表现是突然昏仆，不省人事厥逆之象。有闭证与脱证之别。闭证以邪实内闭为主，其证属实，急宜开闭祛邪；脱证以阳气欲脱为主，其证属虚，治疗急宜扶正。两者截然不同，治法迥异，必须详辨，才能正确进行临床救治。关于闭与脱之鉴别，已在第一篇《厥逆章》中详细论述。兹将热闭与寒闭分述如下：

（一）热闭

证见突然昏迷，不省人事，牙关紧闭，兼见颜面潮红，呼吸气粗，痰涎壅盛，口鼻气热，口臭身热，躁动不安，肢热指凉，或四肢抽搐，大便干燥，唇舌红，苔黄腻，脉弦数。乃风阳升动，气血上逆，挟痰挟火，上蔽清窍，痰热郁阻，风火内闭之征，属于热闭。治宜辛凉开窍，清肝熄风之法。用天麻钩藤汤加减，同时并灌服安宫牛黄丸以熄风醒窍豁痰解痉。方用天麻、钩藤、生地黄、白芍、茯神、菖蒲、天竺黄、竹茹、黄连、橘络、甘草、竹沥水、石决明等。有抽搐者加全蝎、僵蚕。

(二) 寒闭

证见突然昏迷，不省人事，牙关紧闭、兼见面白唇暗，痰壅气闭，静而不烦，四肢欠温，口鼻气冷，舌苔白腻，脉沉滑缓。此乃痰湿阻络，上壅清空，痰浊阻滞阳气，阳气不得温煦，湿痰闭阻之征，属于寒闭。治宜辛温开窍，豁痰熄风之法。用涤痰汤加减。方中用清半夏、茯苓、橘络、竹茹、菖蒲、枳实、僵蚕、干姜、甘草等。同时并灌服苏合香丸辛温开窍之药，以开寒闭。

热闭与寒闭的鉴别见表 4。

表 4 热闭与寒闭鉴别表

		热 闭	寒 闭
神 面 口 呼 四	智 色 鼻 吸 肢	昏迷、半昏迷 潮 红 气 热 痰涎壅盛 躁动不安，或抽搐	昏迷、半昏迷 青 白 气 冷 痰壅气闭 静 而 不 烦
体 温	躯 体	热	温
	四 肢	肢热、指冷	欠温、肢冷
舌 脉 辨 治 用	苔 象 证 法 药	赤、黄腻 弦数、洪数 痰火闭结 辛凉开窍、清肝熄风 安宫牛黄丸	淡红、白滑 沉迟、弦紧 寒浊内闭 辛温开窍、豁痰熄风 苏合香丸

三、后遗症—半身不遂

中风经过治疗之后，诸症逐渐平息。而遗有半身不遂者，治法如下：偏于阴虚有热者，治宜滋阴活血，化瘀通络之法，用通窍活血汤加减，方中用地龙、丹皮、红花、鸡血藤、乌蛇、黄连、苏木、桂枝等。活血化瘀，疏经通络。偏于气虚者，宜用补阳还五汤加减，方中用黄芪、党参、当归、赤芍、川芎、乌蛇、桂枝、地龙、红花、鸡血藤、桃仁，甘草等。以益气化瘀，疏通经络。阳虚者加桂、附，使气血充沛，瘀消络通，痿痹自除。

镇肝熄风汤

淮牛膝 生龙骨 生白芍 元参 代赭石 生龟板 天门冬
青蒿 生麦芽 川楝子 生牡蛎 甘草

方解：此方是张锡纯所拟，载于《医学衷中参西录》中。主治阴虚阳亢，肝风内动所致头晕目眩、目胀耳鸣、心中烦热、面色如醉，或肢体活动不利，或口眼喎斜，甚至昏迷不知人事，醒后肢体不能复原等。本方无论在中风前、中风时、或中风后，属于肝阳化风者均可使用，方中重用牛膝引血下行，并能滋养肝肾，代赭石降其上逆之气，并能平肝潜阳，为主药；龙骨、牡蛎、龟板潜阳降逆，柔肝熄风；元参、天门冬、白芍滋养阴液，柔润熄风，以制阳亢；青蒿、川楝子清泄肝阳之有余；青蒿与麦芽同用能舒畅肝气，有利于肝阳的平降；甘草和中，调和诸药，合而用之，成为镇肝熄风之良方。

六味地黄丸

熟地黄 山药 茯苓 丹皮 山茱萸 泽泻

方解：本方是宋·钱仲阳立方，载于《小儿药证直诀》中。为补阴之主要方剂，功效以滋补肝肾为主，并能培补脾阴，为三阴同补之方。阴虚则生内热，故见骨蒸潮热，手足心热；如虚火上炎，则见咽痛、牙痛；虚火内扰，阴不内守，故盗汗、遗精。腰为肾之府，肾主骨而生髓。如骨髓不充，则腰膝酸软无力；如脑髓不足，则头目眩晕，耳鸣耳聋；由于精亏虚，肾虚不固，故小便多而消渴。方中以熟地黄滋肾填精，为主药；以泽泻清泻肾火；丹皮清泄肝火；茯苓淡渗脾湿。六药合用，互相配合，补中有泻，寓泻于补，相辅相成，是通补开合之剂，滋补肝肾之良方。钱仲阳根据《金匱要略》中之金匱肾气丸修改，成为此方。流传至今，成为医治肝肾不足，滋肾阴，降虚火之不朽名方，迄今奉为典范。

天麻钩藤汤

天麻 钩藤 石决明 山栀子 黄芩 杜仲 川牛膝
益母草 茯苓 夜交藤 桑寄生

方解：此方载于《杂病证治新义》中。主治肝阳上亢，肝风内动所致的头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠以及半身不遂等。方中以钩藤清热凉肝，熄风止痉；天麻益气强阴，祛晕通络；

牛膝滋养肝肾，引血下行；夜交藤、杜仲补益肝肾，筋骨强壮；黄芩，栀子清除三焦郁热；桑寄生养血和营，活络通痹；茯苓益气建中，扶肝化湿；益母草消水行血，去瘀生新；石决明清热明目、镇肝定惊，诸药合用，对阴虚阳亢之头痛、头晕（高血压引起）以及脑血管意外后遗症的半身不遂，有熄风止痉，活血通络之功用。

涤痰汤

胆南星 清半夏 枳实 茯苓 橘红 人参 菖蒲 竹茹
甘草 生姜

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。主治中风不语，昏迷不醒，痰迷心窍。方中用胆南星、清热豁痰；菖蒲芳香开窍；清半夏开郁化痰；茯苓益气、健脾；橘红消痰除寒；竹茹清热除烦；枳实降气和中；人参补气益智；生姜、甘草和中，调和诸药。此方有清热熄风，开窍豁痰之功效。

通窍活血汤

赤芍 川芎 桃仁 红花 老葱 生姜 红枣 麝香

方解：此方是清·王清任所拟，载于《医林改错》中。主治阳气痹阻，气血逆行不畅。有化瘀通阳之功。方中用桃仁、红花活血祛瘀，为主药；川芎、赤芍协助主药以活血祛瘀为辅药；红枣益气补脾；生姜行阳散寒；老葱通上下之阳气，气通则血活；麝香的香窜，可通经络，开诸窍，本方在活血祛瘀之药中加上麝香，使药力更为加强。

补阳还五汤

黄芪 当归尾 赤芍 地龙 川芎 桃仁 红花

方解：此方是清·王清任拟方，载于《医林改错》中。主治中风后遗症：半身不遂，口眼喎斜，语言迟涩，口角流涎，大便干燥，小便频数，遗尿失禁。方中用黄芪大补元气，生长肌肉为主药；当归尾、川芎、赤芍活血和营；桃仁、红花、地龙化瘀通络。合而用之，可使气旺血行，瘀去络通，对辨证属于气虚血滞，脉络瘀阻所致的手足瘫痪、截瘫、或单侧下肢痿软等，均可使用。

典型病例

何××，男，53岁，健康里15号；油工。

1959年10月7日昨晚酒后入睡，半夜自觉左半身移动困难，呼叫家人帮助，今晨由家属背来就诊。

检查：体质稍胖，颜面微红，口微向左斜，左侧上下肢瘫痪，上下肢均不能抬举，握力为零，血压170/100毫米汞柱（22.7/13.3千帕），脉弦数，舌红苔黄。

辨证：中风证。（脑血栓形成。）

治法：先以清热化痰熄风之法。

第一次处方：

钩藤10克 菊花10克 橘络10克 清半夏10克
黄连5克 竹茹10克 生地黄20克 牛膝30克
茯苓20克 代赭石30克 白芍10克 生甘草3克

连服10剂，精神好转，痰火下降，血压130/90毫米汞柱（17.3/12.0千帕），左侧偏瘫未见好转，改用益气养阴，活血通络之法治之。

第二次处方：

太子参10克 黄连5克 乌蛇3克 地龙3克
生黄芪15克 生地黄20克 丹参20克 红花10克
鸡血藤20克 当归10克 赤芍10克 生甘草3克

经过四个月的治疗，服药90剂后，肢体活动恢复正常，生活自理，惟左侧功能稍低，又经过一年的锻炼和服用活络丹，遂彻底痊愈。至今七十余岁仍健在。

按：中风即脑血管发生意外。《素问·风论》曰：“风者善行数变。”说明中风病发病突然，又称卒中。余结合现代医学的病理、病因分析中风是属于内风，但不排除有由于外邪诱发而致病的因素。

另外：颜面神经麻痹单纯性口眼喎斜症，纯属外风，为风中于络所致，此病多发生在青少年人身上，其特点肢体并无瘫痪之发生。

又国内外对脑血管意外，传统称之为中风。余认为应尊重习俗仍以中风命名。

现代医学对脑血管意外病分以下几种：一、脑血管痉挛，是

由于一时性血压的增高，可引起短暂性卒中；亦可由于心力衰弱及血压降低而引起脑血液循环不全所产生。二、脑血栓形成主要因素为血管硬化或粥样硬化、管腔狭窄、血管四周之急性炎症或慢性炎症、以及红细胞增多等症。由于血流的缓慢，此病多发生在休息时或夜间。三、脑溢血是由于动脉硬化，粥样硬化；情绪突变，或血压突然上升，管壁破裂而出血。此病多发生在下午或晚间。此型较重。由于出血部位的不同，和出血的程度不同，决定对疾病的预后。四、脑血管栓塞，此病乃风湿性心炎所引起。炎症对心肌、心内膜、瓣膜的罹及，使组织增厚、充血、肿胀产生赘生物，由于赘生物的脱落，随血运行到脑微细血管中而发生栓塞，因此出现偏瘫。此症多发生在青少年身上。但发病无时间性。至于各种颅内肿、瘤亦可引起偏瘫，应当予以鉴别。

第八章 小 肠 虚

心与小肠相表里，心为火脏，它经常是处在旺盛兴奋活动中，但心经受损后，心火衰微，或小肠本身发生病理变化时，小肠的生理机能必然要受到影响，《灵枢·邪气藏腑病形篇》曰：“心疝引脐小腹鸣”，“寒气客于小肠，小肠不能聚，故后泄腹痛矣。”说明心功能低下或心经受到寒冷，心阳受到严重挫伤后，小肠也可以出现虚寒的现象。临床症状表现为：腹部胀气肠鸣漉漉，脐周围隐痛，易矢气，甚则泄泻，此皆寒气侵入小肠也。宜用温中散寒，理气拈痛之法。吴茱萸汤加减。方用：吴茱萸、干姜、乌药、当归、木香、官桂、炙甘草、大枣。

吴茱萸汤

吴茱萸 人参 生姜 大枣

方解：此方是汉·张仲景拟立，载于《伤寒论》中。主治寒邪犯胃，中阳不振，胃失和降，以致浊阴之气上逆，气机受阻。方中以吴茱萸温脾暖胃，散寒降浊；重用生姜，辛散寒邪，暖胃止呕；寒邪容易损伤人之正气，故用参、枣之甘缓，补脾胃以扶正。

仲圣立方搭配简练而严紧，实为良方也。

典型病例

阮××，男，75岁，退休工人，1977年12月29日就诊。

主诉：患冠心病，心绞痛已一年余；经治疗时好时犯，惟近日腹部胀气，小腹疼痛，经常矢气，大便微溏。

检查：脉沉迟，舌淡、苔白。

辨证：小肠虚寒症。

治法：温中散寒，理气止痛之法。

处方：

乌药10克 干姜10克 肉桂5克 白芍10克
当归10克 木香10克 附片10克 炙甘草5克
生姜3片 吴茱萸10克 大枣5枚

上药服15剂，腹痛止，大便正常。嘱经常服用附子理中丸，并避免受寒。

按：冠心病多发生在老年阳气虚衰之人。心阳虚则小肠必受之。因此患者表现：一、肠鸣音多而重，有时伴随腹胀。二、易矢气，而且量多。三、腹隐痛，得暖即止。四、易泄泻，得热即止。此皆由于心火衰微或心经受寒后，寒气客于小肠所致。心与小肠相表里，冠心病患者往往合并胃肠消化道症状，即此理也。

第三篇 肝 虚 论

《素问·阴阳应象大论》曰：“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天为元，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，元生神。神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝，在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒；风伤筋，燥胜风，酸伤筋，辛胜酸”。

《素问·六节藏象论》曰：“肝者罢极之本，魂之居也。其华在爪，其充在筋，以生血气。其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。”

肝素称其为“将军之官”，内寄相火，体阴用阳，属木应春，喜升主风，阳易亢动，常处于兴奋与亢盛之状态，有“肝无虚”之说，古籍极少论述肝虚之症候。

《素问·上古天真论》曰：“丈夫七八肝气衰，筋不能动。”《灵枢·天年论》曰：“五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始减，目始不明。”《灵枢·本神》曰：“肝气虚则恐，实则怒。”五脏均有气、血、虚、实之分，肝脏亦不例外。

肝藏血，以血为体，以气为用，血属阴，气属阳，肝的阳气是肝脏升发和疏泄的一种动力，肝的阴血是肝脏功能活动的物质基础，这种阴阳关系与其他各脏的阴阳关系是一样的，也是阴阳互根，相互为用。《素问·阴阳应象大论》曰：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”《医宗必读》曰：“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。”

近代，《中国医学大辞典》中曾提到肝虚、肝劳、肝虚汗、肝虚寒、肝虚热、肝气不足以及由于肝虚所引发的各种目疾等，但论述得不够详确。

张锡纯提出，治疗肝气虚弱之药使用黄芪加柴胡、川芎，以

升补肝气，使郁者可化，陷者可升。张锡纯用川芎是取李时珍“芎藭以补肝气”之义。《医学求是》曰：“若脾土得升，乙木因之以升。”重用黄芪性温而升，以补肝虚，亦既培土以补肝之义。

肝病可分为：肝气横逆、肝气犯胃、肝气郁结、肝阳上亢、肝气虚、肝血虚、肝阳虚、肝阴虚、水不涵木浮阳上越等，本书专论虚证前四种，属于实证的不在本书论述范围，故从略。（见图6）

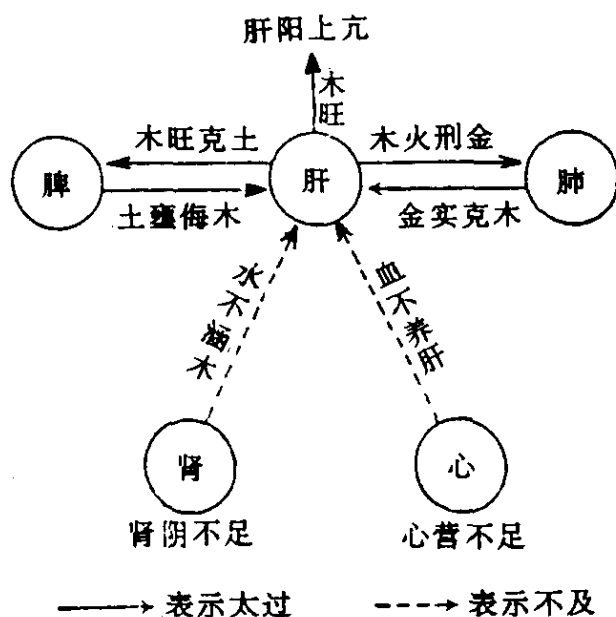


图6 肝病机理示意图

按：心为阳中之太阳，肝为阴中之少阳，均为牡脏。心与肝属于阳脏，人在正常情况下，阳表现为兴奋，不应有虚象出现，故有“心无虚，肝无虚”之说。如心经、肝经严重受损，至全身衰竭时可出现心力衰竭和肝昏迷，而造成死亡。

第一章 肝 气 虚

肝气虚乃肝脏本身机能的衰弱，它与肝的活动关系极大。肝主血液之贮藏和调节，又主全身肌筋的活动。精神、情志的调节，也与肝气有密切的关系。这种功能中医称为疏泄。

肝气虚就会表现出肝脏各功能活动的低下，临床症见：胸肋

满闷，四肢疲倦，懈怠乏力，易怒懒言，精神不畅，有时悲恐，常常太息，不思饮食，暖气腹胀，口苦咽干，视力减退，头痛昏重，脉沉细或弦数，舌苔白腻或黄腻，此乃肝气疏泄不畅，必将引起气血、精神、消化等功能的异常。

补益肝气宜用补肝散加减，方用黄芪、熟地、白术、山萸肉、当归、白芍、何首乌、枸杞子、柴胡、香附等。

补肝散

黄芪、熟地、山萸肉、当归、川芎、白术、五味子、酸枣仁、独活、木瓜。

方解：此方为明·滑伯仁所立，载于《医韵》中。主治肝气亏损而引起之头眩肋胀，腰腿酸痛，妇女月经不调等症。方中黄芪为主药，它能补肝脏升发之气，肝肾同源，以熟地、山萸肉、山药、五味子、培补肾气；当归、川芎补血，血充则肝自得其养，脾胃为气血生化之源，白术为补脾主要药，脾气充则饮食自倍，酸枣仁对脾胃虚弱，食欲不振有醒脾之作用，方中独活、木瓜对腰腿疼痛有去湿散寒利关节之作用，诸药合同对肝气虚亏肝脏机能减弱有恢复肝脏功能的作用。

典型病例

杨××，女，52岁，工人，1979年3月5日就诊。

主诉：一年前因过度愤怒而致胸腹胀满，食欲逐日减少，渐至不思饮食，经治，医皆给以舒肝理气斡伐之药，又兼不能饮食致使身体日渐羸瘦，四肢倦怠乏力，视力减退，精神不振，稍进食即感胀满难受，无法安眠，对治疗毫无信心，经友人介绍延余医治。

检查：面色微黄，四肢厥冷，脉沉细，舌淡苔白。

辨证：郁怒伤肝，久则气损，肝气虚证。

治法：大补肝气，以助疏泄之用。

处方：

黄 芪	20 克	党 参	20 克	当 归	10 克	白 芍	10 克
玉 竹	10 克	香 附	10 克	厚 朴	5 克	川 芎	5 克
砂 仁	5 克	桔 梗	10 克	枳 壳	5 克	甘 草	5 克

服药后矢气频作，胸腹胀满逐渐轻减，食欲恢复，治疗半个月后，体力康复，痊愈。

按：肝气虚与脾气虚之区别和联系。脾主运化，肝主疏泄，脾得肝之疏泄则运化健旺，肝得脾所转输之饮食精微的滋养，则肝气条达。清·唐容川曰：“木之性主于疏泄，食气入胃，全赖肝木之气以疏泄之，而水谷乃化；设肝之清阳不升，则不能疏泄水谷，渗泄中满之证在所不免。”说明肝对脾的作用，脾的运化除脾本身功能活动的作用外，肝的疏泄作用是非常重要的。

第二章 肝血虚（肝硬化）

现代医学所称之肝硬化，肝大与中医所论之血枯病、痞积病等相似。各家文献中记述着腹中有硬块，坚而不移，名曰积块、痞块或痞积。《素问·腹中篇》曰：“帝曰：有病胸胁支满者……何以得之。岐伯曰：病名血枯，此得之年少时，有所大脱血；若醉入房中，气竭肝伤，……”王冰注解：“醉则血脉盛，血脉盛则内热，因而入房髓液皆下，皆肾中气竭也。肝藏血以养人，血脱故伤肝也。”《难经》曰：“五脏之积，各有其石，脾之积，名曰痞气。在胃脘，覆大如盘，久不愈，令人四肢不收，发黄疸，……”《金匱要略》曰：“积者脏病也，终不移。”以上文献声动的形容有大的积块痞塞于上腹部正中胃脘处。

肾藏精，肝藏血，肝肾同源，如肝脏之中血已枯，肝失濡润必成硬化。

此病由肝气郁结，气滞血瘀，肝血虚亏，肝失所养，使肝质变硬，成为痞积之症。初期应以养正补虚为主，酌加理气活血，软坚化瘀之药，用四君子汤、四物汤、膈下逐瘀汤等方加减。方用党参、丹参、白术、茯苓、桃仁、当归、红花、香附、牡蛎、瓦楞子、鳖甲、赤芍、龟板、熟地黄、炙甘草等。

四君子汤

方解：见第一篇总论第三章“气虚”中。

四物汤

方解：见第一篇总论第四章“血虚”中。

膈下逐瘀汤

五灵脂 当归 川芎 桃仁 丹皮 赤芍 延胡索 乌药
香附 红花 枳壳 甘草

方解：此方是清·王清任所拟，载于《医林改错》中。本方有活血化瘀，理气止痛之功用。方中用当归、川芎、红花、桃仁、赤芍、延胡索、五灵脂等药，有活血、散血、行血、化瘀之功能，香附、枳壳、乌药等有理气、行气、通气之作用；甘草协和诸药。此方对于肝脾肿大以及少腹癥瘕等症均为有效。

典型病例

刘××，男，46岁，职员，1971年10月6日就诊。

主诉：患慢性肝炎已三年，近期右肋下不适感，胸肋胀闷隐痛，纳少神疲，食欲不振，大便不畅。

检查：面色晦暗，舌边青紫，苔薄黄，脉弦弱。超声波检查：肝上界在第五肋下界间，下界在肋下2.5厘米，剑突下3.5厘米，质较硬肝波为较密微小波，波形活跃。脾在左肋下1厘米。

化验：血色素9.5克%，红细胞310万/立方毫米，白细胞6000/立方毫米。肝功能谷丙转氨酶180单位，麝香草浊20单位，总蛋白5.5%，白蛋白2.7%，球蛋白2.8%。

X线检查：钡餐透视食道静脉曲张。

诊断：早期肝硬化。

辨证：肝血虚，肝血瘀阻痞积病。

治法：益气活血，化瘀消痞之法。

处方：

党参15克 丹参15克 鳖甲10克 牡蛎20克
桃仁15克 当归10克 瓦楞子20克 香附10克
红花10克 玉竹10克 茯苓15克 赤芍10克
郁金10克 柴胡3克 三棱10克 莪术10克
甘草5克

上方各药交替使用，每次处方用12味药治疗，服药200余剂，

治疗一年后连续复查，逐渐好转，1973年6月全面检查，身健精神旺盛，饮食正常，肝功能化验正常，钡餐透视食道静脉曲张消失，肝脾均已正常，痊愈恢复正常工作。

按：肝硬化是一种影响全身的慢性疾病，不少病例是由于长期酗酒或传染性肝炎的失治，发展为门脉性肝硬化，坏死性肝硬化，胆汁性肝硬化或酒精中毒性肝硬化。现代医学认为是肝细胞变性，坏死，纤维组织增生，肝组织结构紊乱，可使肝脏变硬，故名肝硬化。因此，在患急慢性肝炎时应抓紧调理，酗酒者应禁酒。使肝功恢复，甚为重要，如果缠绵日久，肝血枯竭，肝体大部分硬化，将危及生命。

第三章 肝阳虚（臌胀）

中医文献中的肝胃病、积聚、臌胀，与现代医学之慢性肝炎、肝硬化、肝腹水等相同。慢性肝炎发展至肝硬化乃由于浊邪侵入肝脏，长期滞留，肝体（肝细胞）硬坏，损耗肝气、肝阴，造成气血瘀阻，使肝体变硬。气阴长久虚损必伤及肝阳，肝阳虚则水不能化，泛滥外溢，滞留腹腔之中，造成腹水征。此即肝硬化、肝腹水之发病机理，由肝硬化发展至肝腹水乃肝阳虚极之候也。成为重症，中医谓之臌胀，严重威胁生命。

《灵枢·本神篇》曰：“肝藏血。”肝为人体之血库，血又赖气以行，如肝失调达，或饮食不节，或嗜酒过度，以及感染蛊毒经久不愈，肝必内伤，郁滞不畅，久则气滞血凝，脉络瘀积，死血内着，而少新鲜血液之濡养，血枯伤肝，因之攻肋作痛，成为硬化积癖之症，至此肝亦失其功能矣。

《金匱要略》曰：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”脾病则不能制水，运化失调，水不能下泄，且脾恶湿，湿气内着，必出现腹水征象。大腹胀满，动则气逆。清·程仲龄《医学心悟》曰：“先腹水后四肢肿者，胀也。”患者胸部、面部或其他部位皮肤往往发现蜘蛛网状，扩张的蜘蛛痣和肝掌等，这便是肝硬化的特殊

病征。在祖国医学文献中也有此症状的描述，明·秦景明《症因脉治》曰：“血鼓腹胀之症，腹胀不减，肚大青筋，腿足或见血缕，小便反利，大便或黑，在上则漱口多忘，血在下则小腹痛，血鼓腹胀之症也。”清·唐宗海《血证论》曰：“血鼓之症，胁满小腹胀，满身上有血丝缕，烦躁漱水，小便赤，大便黑，腹上青筋是也。”清·喻嘉言《寓意草》曰：“面色痿黄，有蟹爪纹路。”说明祖国医学对肝病可出现蜘蛛痣，早有认识。

肝硬化的末期，一般症状均显著恶化。精神的变化有神志恍惚，谵妄甚至狂躁，逐渐转入昏迷。现代医学称之为肝昏迷。祖国医学亦有这方面的记载：《医钞类编》曰：“烦躁漱水，迷妄惊狂，痛闷喘恶，虚汗厥逆，小便多大便血，瘀蓄死血，而腹胀皮上见青紫筋。”这段记载即是肝昏迷的早期症状。以上为肝硬化、肝腹水、肝昏迷病情逐渐发展，逐渐恶化的过程。

肝气虚乃肝阳虚之始，肝阳虚乃肝气虚之渐。虚久气机升降枢机失利，水湿元阳不化，浊阴阻滞中焦，腹胁胀满连及少腹，水肿如鼓，名为肝腹水。中医称之为水鼓或臌胀。甚者漫延四肢水肿，男性睾丸亦水肿如斗，四肢冷过肘膝，形削羸瘦，面色黧黑，口干苦，尿少色黄，或如浓茶，大便少而干燥，舌质胖或瘦，色暗有紫斑。乃肝阳虚极，已呈危候，预后不良。治疗时不可擅用攻下药或体外排水法。如不及时扶正补阳，反用大攻大泻之药投之，虽暂时奏效，但继而腹水又升，三次逐水未有不毙命者，应慎之。

关于放水法，祖国医学亦有记载。《千金方》曰：“凡水病忌腹上出水，水出者月死，大忌之。”清·俞东扶《古今医案》曰：“今有专门治肿胀者，用铜管子，从脐下刺入，出水如射，倾刻盈缶，腹胀即消。以此水露一夜，明晨观之。浮面者是清水，中央者是淡血，沉底者是脂膏。盖病者，清浊不分，气血皆变为水，决而去之，去水即去其气血也。虽一时暂快，或半月或一月，肿胀仍作，再针之亦死，不针亦死矣。”因此消腹水之方法，只宜温煦脾肾阳气，使阳气充沛，自然蒸化寒水，腹水逐渐自行消退。宜用参芪益气汤、真武汤加减。方用附子、干姜、肉桂、茯苓、熟

地黄、白术、党参、生黄芪，温阳利水，经过百日治疗，渐渐阳气充沛，阴水自能逐渐消退，不可操之过急。

至于肝硬化的肝昏迷，则已是接近死亡之征兆，预后多为不良。昏迷的前期，出现骚动、烦躁、谵妄、昏厥，以及伴有牙关紧闭，喉中有痰等，真寒假热和真虚假实的“闭证”现象，不可认为是痰火厥闭，妄用牛黄、安宫凉开之药，而犯虚虚、寒寒之害，乃促其早亡。此时应以苏合香丸温开之药救之。如病人渐渐深度昏厥，大汗出，四肢厥逆，阴阳有离绝之势，急以参附汤灌救，另外以生附子面用热水调敷两足心，并以热水袋熨敷，以济回阳，冀希一万。

参芪益气汤

方解：见第二篇心虚篇第五章“心阴心阳两虚”中。

真武汤

熟附子 白术 茯苓 白芍 生姜

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《伤寒论》中。肾为水脏，又有命门相火，以资化气行水。若肾中真阳衰微，则气不化水，必见恶寒而小便不利，水湿内停；水溢于表，则四肢沉痛，下肢浮肿；甚至肿过肘膝，出现腹水鼓症。此病皆因阳虚不能化水所致。治水必先治肾。故以温阳利水为主。方中以附子之辛热温壮肾中之阳气，以散在里之寒水；水虽在于肾，而制水则在于脾。故以白术和茯苓健脾以利水除湿；生姜通阳以祛寒；以白芍之酸寒能制约附子和生姜之辛燥。此方能温阳利水，适用于阳虚，寒湿内盛，肢体浮肿之证。立方之简，意义之奥，千古不泯。

典型病例

邓××，男，61岁，崇文区利民食堂工人。

患者自1977年4月以来，自觉腹部逐渐膨隆，腹壁静脉曲张，有移动性浊音，下肢可凹性浮肿（++），血压170/90毫米汞柱（22.7/12.0千帕），肝在肋下1.5厘米；尿常规：蛋白（+），白细胞0~1个，红细胞（+++），食道钡剂透视未见异常，血小板124000万/立方毫米，白细胞计数4700/立方毫米，非蛋白氮（NPN）32毫克%，血沉28立方毫米/小时，肝功能试验：谷氨酸

-丙酮酸转氨酶 (G. P. T.) 70 单位，麝香草酚浊度试验 (T. T. T.) 9 单位，白蛋白 2.12 克%/球蛋白 3.84 克%；胆固醇 113 毫克%；诊断为肝硬变腹水，经过一年余的治疗均未见效。1978 年 5 月 13 日来中医科就诊。

检查：慢性病容，面黄消瘦，双下肢浮肿（+++），心率 108 次/分，律整。血压 120/90 毫米汞柱（16.0/12.0 千帕），双肺听诊音（-），腹部膨隆，叩诊有移动性浊音，腹围 92 公分，肝脾因严重腹水触及不清，腹部静脉曲张，舌质淡嫩，苔白滑，脉沉弱。

辨证：脾肾阳虚，水鼓症。

治法：以健脾利湿，补肾助阳之法。

第一次处方：

太子参 15 克 生黄芪 20 克 当 归 10 克 附 片 5 克
猪 苓 15 克 茯 苓 20 克 黑白丑 10 克 白 术 10 克
肉 桂 5 克 莱菔子 10 克 干 姜 10 克 甘 草 5 克
上药连续服用 42 剂。

继诊：腹围缩小至 86 公分，腹部自觉稍软。仍以上法，停用黑白丑、猪苓逐水药。

第二次处方：

太子参 15 克 生黄芪 20 克 附 片 10 克 白 术 10 克
云茯苓 20 克 桂 枝 5 克 炮 姜 10 克 肉苁蓉 10 克
甘 草 5 克

每日服 1 剂，连服药 54 剂，至 1978 年 8 月 30 日腹水基本消失。

再诊：精神好转，腹软，腹水征（+），腹围 70 公分，肝上界第五肋间，右肋下 1.5 公分，脾大在左肋下 2 公分，硬无压痛，双下肢浮肿消失。肝失濡养，肝质变硬，改用健脾养肝，活血化瘀，消症软坚之剂。

第三次处方：

太子参 12 克 何首乌 15 克 茯 苓 20 克 丹 参 20 克
肉 桂 5 克 附 片 10 克 干 姜 10 克 红 花 10 克

桃 仁 10 克 莪 术 10 克 当 归 10 克 甘 草 3 克

连续服用 130 剂，腹水完全消失。肝脏缩小至右肋下 0.5 公分，质软无压痛，检查肝功结果如下：

1978 年 10 月 20 日，肝功能试验，谷氨酸-丙酮酸转氨酶（G. P. T.）20 单位，麝香草酚浊度试验（T. T. T.）7 单位，白蛋白 3.6 克%/球蛋白 3.5 克%。

1979 年 2 月 9 日，肝功能试验，谷氨酸-丙酮酸转氨酶（G. P. T.）30 单位，麝香草酚浊度试验（T. T. T.）11 单位，白蛋白 3.88 克%/球蛋白 3.02 克%。

1979 年 3 月 30 日，肝功能试验，谷氨酸-丙酮酸转氨酶（G. P. T.）55 单位，麝香草酚浊度试验（T. T. T.）7 单位，白蛋白 4.05 克%/球蛋白 3.0 克%。

腹水完全消失后，肝功试验指标正常，球蛋白、白蛋白亦恢复正常，改服参苓白术丸、金匱肾气丸，补肾强身片一个月。1979 年 3 月份恢复工作。

患者自 1978 年 5 月至 1979 年 3 月，经过九个月的治疗，共服汤剂 226 剂，完全痊愈。嘱继续再服用金匱肾气丸、补中益气丸 3 个月，1980 年 5 月随访，患者已完全恢复健康，早已停药。

按：从本例肝硬化腹水治疗的全过程来看，以肝阳虚极，脾阳不振，命门火衰，三焦气化失利，土虚不能制水，水反克土而出现阴盛阳衰的病理机制。根据“治病必求其本”的原则，所以以补虚扶正，温肾助阳为其主要治疗方法，而逐水攻邪乃权变之计。肝硬化出现肝腹水乃晚期恶化的表现，施治不当鲜有得救者。

本例患者初就诊时，以脾肾阳虚，腹水鼓胀为其主要症候。肾为先天之根，脾为后天之本，脾肾之阳气，互相资助，温煦肢体，运化水谷精微，脾肾在输布水液方面起着协同作用。余根据腹水发生的病理实质，在整个治疗过程中都是使用真武汤、参芪益气汤加减来益肾助阳，健脾利水。在腹水消退后明显肝脾肿大，则使用丹参、桃仁、红花、莪术等活血化瘀之药，果然奏效。

在治疗过程中，抓紧时机，适当逐水，在腹水消减一半时，将二丑、猪苓等逐水药物停用，免伤正气，同时加重健脾助阳药物

的用量，扶正固本，以保持在腹水消退后不致反复，使邪去而不伤正。

对厥逆症，在第一篇《厥逆章》已有论述。在第二篇《中风章》对闭证区分有寒闭与热闭。在本章提出肝昏迷属于寒闭、虚脱之证，不可妄用牛黄、安宫等药。使医者在临床对昏迷病人严加鉴别，以免枉杀生灵。

第四章 肝阴虚证

肝开窍于目，由于肝气郁结、肝阴不足，神水淤滞，不能畅流，以致目胀、目痛，甚至头痛，视力下降，头痛剧烈时兼有恶心呕吐。其重要体征为瞳孔散大，眼球变硬，眼压增高，为绿内障眼病，乃肝血虚亏所致，应以养血补肝为主，治宜补肝丸加减。方用：茺蔚子、菟丝子、生地黄、当归、枸杞子、女贞子、淮山药、地骨皮、青箱子、五味子、柏子仁、白芍、川芎等药。

补肝丸

茺蔚子 青箱子 枸杞子 五味子 杏仁 决明子 菟丝子
淮山药 地骨皮 茯苓 柏子仁 人参 细辛 防风 大黄
生地黄 黄芩 车前子 黄连 甘草

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。主治由于肝肾两虚所引起之目光昏暗，视物不清，目胀目痛，耳聋耳鸣等症。方中用人参、茯苓、甘草补中益气；生地黄、淮山药、枸杞子、菟丝子、柏子仁滋补肝肾；地骨皮清泻肝肾之虚热；青箱子、决明子以清肝明目；茺蔚子以活血明目；五味子以补虚明目；此五子皆有明目之功。用黄连、黄芩泻肝胆热；杏仁泻肺润燥；防风、细辛宣散风湿；车前子去湿热以明目，此方以补肝肾为主，并以参、苓、草、培土养肝为佐；同时使用活血、泻火、润肺、祛风、利湿等药为辅；搭配严紧，相得益彰。

典型病例

陈××，男，65岁，退休工人，1960年10月3日就诊。

主诉：患青光眼已有五年。经常头痛目胀，有时双目胀痛，左

侧为重，视物不清，脉弦数，舌红苔白微黄。经眼科检查眼压：左 35、右 32 毫米汞柱。诊断为青光眼。

辨证：肝肾不足，虚火上炎，目失濡养成为绿内障之内障眼。用丸药缓缓调治。

治法：补肝益肾，养血明目之法。

处方：

沙苑子 100 克 当 归 100 克

熟地黄 100 克 生地黄 100 克

枸杞子 100 克 川 芎 50 克

赤 芍 50 克 菊 花 50 克

五味子 100 克 蜜蒙花 50 克

石 斛 100 克 黄 柏 30 克

决明子 100 克 丹 皮 50 克

泽 泻 50 克 何首乌 100 克

菟丝子 100 克 女贞子 100 克

柏子仁 100 克 羚 羊 10 克

共研细末，炼蜜为丸，重 9 克，早晚各 2 丸。经过一年治疗，连续服药五料，症状消失，眼压正常，视力恢复而痊愈。

按：绿内障相当于现代医学所称的青光眼，此证为最严重的眼病，若迁延失治，可导致失明，故不可掉以轻心，要认真及时治疗。现代医学认为：青光眼可分为原发，继发，先天。其主要病因病理为房水的产生过多，或排泄发生障碍，致使眼压持续增高。现代医学对此病治疗原则：1、抑制或减少房水的产生；2、减少眼内容物体积；3、减少房水外排阻力。通过上述方法的治疗，一般可以改善症状，但较难根治，有待中西医同道共同研究突破此病。

第五章 水不涵木浮阳上越

肝阳依赖肾水的涵养，如肾水亏耗，水不涵木必致浮阳上越。

《素问·生气通天论》曰：“阴平阳秘，精神乃治。”此即水火既济之道理也。

凡情绪经常抑郁，则伤脾肾，或过度激动则伤肝，均易动怒。脾肾越虚，肝火越旺，则更易动怒。此证属于虚中有实，与肝胆郁热型的易怒不同。在早期高血压病患者中，此型较为多见。但亦有血压不高者临床表现为情绪易于激动，遇事敏感，性情急躁，言语粗暴。自觉头晕头痛，耳鸣心跳，胸闷气短，多汗，激动时更为明显，头晕多于头痛，记忆力逐渐减退，注意力不集中；有时失眠多表现为入睡难，有时彻夜不眠，但次日仍可以勉强坚持工作。

根据病因症状分析，此型患者属于上实下虚，治宜清上实下，应用滋阴补肾，清热降火之剂，以补为主，以清为辅，用杞菊地黄汤加减治之。方用生地黄、熟地黄、丹皮、泽泻、茯苓、枸杞子、菊花、山茱萸、山药、女贞子、鳖甲、龟板、煅牡蛎、煅龙骨，使肾水充足，肝火平定，症状自可控制。

有高血压病者，应在此方基础酌加牛膝、磁石、生石决明等镇坠之药，引火下行。

杞菊地黄汤（丸）

熟地黄 山药 茯苓 丹皮 泽泻 山茱萸 枸杞子
菊花

为清·董西园立方，载于《医级》中。董西园在六味地黄丸的基础上，增加枸杞子和菊花，名为杞菊地黄丸。用菊花以明目而祛眩晕；用枸杞子补肝而滋肾阴。六味地黄丸本为滋补肝肾之良方，加此二味，对于肝肾不足所引起的头晕、目眩、视物不清、眼睛涩痛以及夜盲症等更为有效。

典型病例

王××，男，45岁，崇文区财政局职员1962年7月5日就诊。

主诉：近半年来经常头晕头胀，有时头痛，耳鸣心烦，容易动怒，不能坚持工作。

检查：血压178/105毫米汞柱（23.7/14.0千帕），脉弦微数，舌红苔薄黄。

辨证：肾水不足，肝阳上亢，为水不涵木之证。

治法：以益肾滋阴，潜阳镇逆之法。

处方：

钩 藤 10 克 菊 花 10 克 白 芍 10 克 白 蒺 藜 10 克
茯 苓 10 克 枸 杞 子 10 克 代 赭 石 30 克 牛 膝 20 克
麦 门 冬 10 克 生 地 黄 15 克 生 石 决 明 30 克

经过二个月治疗，共服药 30 剂，血压下降为 125/80 毫米汞柱（16.7/10.7 千帕），症状消失，恢复工作；嘱经常服用杞菊地黄丸，以巩固疗效。

按：高血压为临床常见病之一，须辨虚实，根据中西医结合研究，可分为四种类型，兹列表介绍如下：

表 5 高血压病临床症状及分型

分	型	症 状
阳 亢	肝 胆 郁 热 型	形体肥胖，头胀头痛痰涎壅盛，口干舌燥，脉弦数。
阴 虚 阳 亢	肝 热 肾 虚 型	头晕头痛，耳鸣心跳，胸闷气短，多汗，易激动，失眠，脉弦细微数。
阴 虚	肝 血 虚 型	头晕、眼花、耳鸣，腰酸、腿软，夜尿频，足根痛，脉沉细。
阳 虚	心 肾 阳 虚 型	胸闷心疼，气短，肢冷腰酸，阳萎，脉沉弦而迟无力。

肝热肾虚和肝肾阴虚两型高血压病属于虚证。至于肝胆郁热型，乃痰火实热之疾，纯属阳证，非本书论述范围，故从略。尚有心肾阳虚型高血压病患者，多合并冠心病，已在心虚论中论述。

第六章 胆虚不眠症

胆为中正之官，肝胆相表里，胆喜宁谧而恶烦扰，喜柔和而恶壅郁，若大病、久病之后，胸膈余热未尽，必伤少阳之和气，因

而虚烦惊怯，夜不成眠，或梦寐不祥，甚则盗汗不止，气短乏力，乃胆经虚热所致，宜用温胆汤与酸枣仁汤加减治之。方中用酸枣仁、知母、茯苓、川芎、清半夏、橘红、竹茹、枳实、丹参、黄连、莲子心、甘草、生姜、大枣等，清肝胆之虚热，化痰以除烦，养血以安神。

酸枣仁汤

酸枣仁 茯苓 知母 川芎 甘草

方解：本方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中。主治：肝血不足，胆经虚热，阴虚阳亢，虚火内动，上扰于心，故见虚烦不眠。方中用酸枣仁养肝安神，为主药；川芎调血，协助酸枣仁以养血，为辅药；茯苓宁心，协助酸枣仁以安神，知母清热除烦，共为佐药；以甘草之甘平，和中缓急。诸药合用，有养血安神，清热除烦之功效。

温胆汤

半夏 陈皮 竹茹 枳实 茯苓 甘草 生姜 大枣

方解：此方是唐·孙思邈立方，载于《千金要方》中。本方有清胆和胃，除痰止呕之作用。主治胆经虚热，痰火上扰，出现虚烦不眠，胸闷痞满，呕逆口苦等症。方中用半夏、陈皮燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，为主药；茯苓益气健脾，淡渗利湿；竹茹清热凉胃，止呕除烦；枳实宽中下气，消食化痰，使气顺则痰降，气化则痰消；生姜和胃；大枣建中；名为温胆，实则清胆和胃，燥湿化痰之剂。

典型病例

王××，女，35岁，96中学教员，1961年6月15日就诊。

主诉：产后已两个多月，在产时曾大出血，进行过人工补血；现经常烦躁不眠，心悸气短，夜间盗汗；查：脉沉细，舌红苔薄白。

辨证：由于伤血过多，肝血虚损，肝虚则真阴不足，肝虚则胆亦虚，故虚烦不眠。

治法：用滋阴养血，清肝胆虚热而安神。

处方：

酸枣仁 10 克 橘 红 10 克 当 归 10 克 丹 皮 10 克
莲子心 10 克 山茱萸 10 克 竹 茹 10 克 茯 神 10 克
白 芍 10 克 清半夏 10 克 甘 草 5 克 生 姜 3 片
经过半个月治疗，服药 12 剂，症状消失，痊愈。

按：脏腑学说认为，肝与胆相表里，相互依存。在病理方面，肝有病影响胆，而胆有病必累及肝，故肝虚胆亦虚，于是出现虚烦不眠等症。因此治疗此证的原则，是以滋肝阴，养肝血为主，佐以清热化痰安神之品，标本兼顾，搭配严紧，每获捷效。

第四篇 脾 虚 论

《素问·金匱真言论》曰：“阴中之至阴，脾也。”《素问·阴阳应象大论》曰：“中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。脾主口，其在天为湿，在地为土，在体为肉，在脏为脾，在色为黄，在音为宫，在声为歌，在变为哕，在窍为口，在味为甘，在志为思。思伤脾，怒胜思，湿伤肉，风胜湿，甘伤肉，酸胜甘。”《素问·至真要大论》曰：“诸湿肿满皆属于脾。”《灵枢·五味篇》曰：“胃者，五脏六腑之海也，水谷皆入于胃，五脏六腑皆禀气于胃。”以上经文说明“脾”的生理功能和致病的特点。脾与胃相表里。中医所论：脾胃即指整个消化系统而言。脾喜燥恶湿，湿盛则困脾。胃的主要功能是纳受水谷，脾的主要功能是运和化，运者输也，化者消化也。消化依靠脾阳，脾阳又是依赖命门相火的作用。脾将五谷消化后所产生的精微输送到全身，脾和胃两者互相配合，又各有特性，起相反相成作用。脾为湿土，胃为燥土，脾气主升，胃气主降，这一升一降产生互相制约，形成对立的统一。如脾过湿，胃过燥，或脾过升，或胃过降，都会成为致病的因素。

脾胃在全身的重要性有两方面：一方面是由于脾胃不健，使身体抵抗力减低，所谓：“邪之所凑，其气必虚。”另一方面脾胃虚弱可以发生血虚、气虚，并从而生湿、生痰。气是无形的，在人体内无处不至，各脏腑机能的正常活动都是以“气”为动力。脾胃的失调就会影响食物纳摄和运化，水谷之气不足，久之会出现面色苍白，嗜卧懒言，疲倦乏力等气虚的症状，在临床上首先使用健脾补气之药。宜用四君子汤，用人参（或党参）、白术、茯苓、甘草等健脾之药，也是补气之剂，所以说补气离不开健脾，健脾离不开补气。

以脾为主体，与肝、肺、肾及命门等都有密切关系。如由于

脾土虚，可以导致肺金弱，脾土能生肺金，肺为脾之子，肺有病必累及母。因此在治疗肺虚之时使用补脾的方法，谓之“培土生金。”在第五篇肺虚论中详述之。

脾与肾的关系：肾属水，脾属土，土能克水，这种克法，当肾经虚弱之时，脾并不乘虚来克，相反表现在脾土虚弱之时，土无力制水，肾水就泛滥，四肢浮肿，以及出现腹部水肿现象，形成反克，这时常用健脾之法来治水，脾健运就能治水，水就不会泛滥无度。

由于命门火衰，火不生土，可以引起脾阳不振，此时可使用补火之法以生土。火不生土会出现厌食、怕冷等症状。

脾与肝的关系：肝属木，脾属土，肝木克脾土，在临床上是常见的。脾胃稍一虚弱，肝即乘之。《金匱要略》曰：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”所以肝病应补脾。又由于脾气不舒，可引起肝气之郁结；由于肝气郁结，反过来而克脾土，说明肝与脾的关系是何等密切？（见图 7）

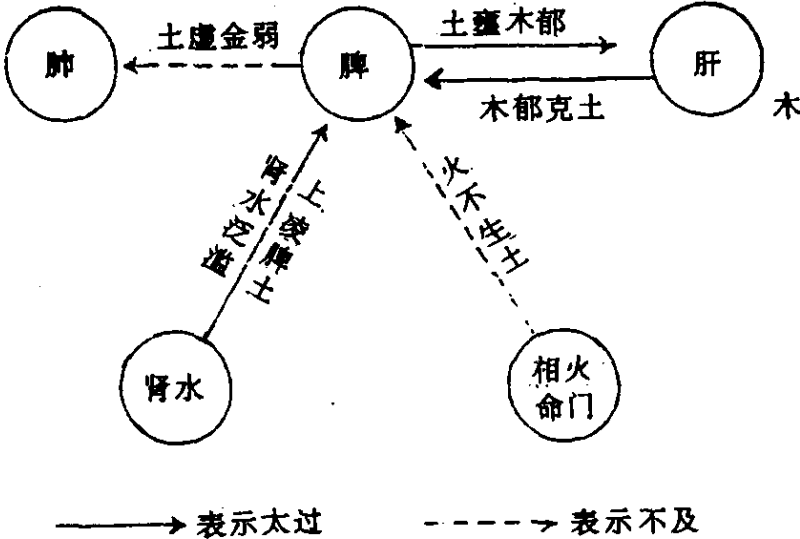


图 7 脾病机制示意图

按：脾虚病人都有不同程度的胃分泌功能紊乱，主要表现为胃蛋白酶和胃酸降低。“脾虚”的机制又与唾液腺、胃肠、胰、肝的功能障碍有密切关系。生理学说明，胃纳脾输的功能包括三大营养物质水与电解质的消化，吸收以及合成分解和排泄。

我国古代哲学家老子曾高度概括地说：“万物负阴而抱阳，冲

气以为和。”气附于阴的为阴气，气附于阳的为阳气。气不是指物质，而是指“气机”而言，气机是动态的，是指事物运动的内在原因。气对人体还有着重要的调控作用。这一观点是祖国医学整体观念的核心。

第一章 脾 阳 虚

此证由于脾阳不振，气不化水，水湿泛滥。脾主四肢，故见全身浮肿，面色苍白，腹部膨隆如鼓，四肢不温，畏寒，身重，食欲不振，喜热饮，小便少，色清白，脉沉细，舌苔薄白，《素问·至真要大论》曰“诸湿肿满皆属于脾。”脾阳虚弱，运化失常，乃土不制水也。水湿滞留于肌肤经脉之间则水肿身重，水湿不化则小便不利，成为阴水症。治以温脾助阳，行气利水之法。宜用实脾饮加减：姜厚朴、白术、苍术、茯苓、大腹皮、干姜、炮姜、草果仁、木香、熟附子、桑白皮、桂枝、党参、炙黄芪、甘草。使脾健阳充而水自消。

实脾饮

姜厚朴 白术 木瓜 木香 干姜 草果仁 大腹皮
熟附子 茯苓 炮姜 炙甘草 大枣 生姜

方解：此方是宋·严用和撰拟，载于《济生方》中。为治疗脾虚水肿之主方。由于脾虚不能制水，水妄行于肌肤，则身重浮肿。方中用白术、甘草、生姜、大枣以实脾；脾寒则不能化水，水停肠胃之中则懒食不饮，二便不实，故用干姜、炮姜、附子、草果仁以温之；更佐大腹皮、茯苓、厚朴、木香、木瓜以导水利气。气者水之母也。土者水之防也。气行则水行，土实则水治。故名实脾饮。

典型病例

丛××，男，49岁，废品公司工人。

自1960年9月开始下肢出现浮肿现象，逐渐加重至11月间经过治疗半个月无效。1960年11月25日就诊。

检查：颜面轻度浮肿，下肢浮肿已过膝，腹部膨隆，无压痛，有水波感，为腹水征，肝脾未扪及，阴囊水肿（睾丸水肿如球8×8厘米）。心肺正常，心率52次/分，心律整，心音低，血压106/80毫米汞柱（14.1/10.7千帕）。两脉沉细而迟。尿常规阴性。肝功能试验：谷氨酸-丙酮酸转氨酶（G. P. T.）正常。麝香草酚浊度试验（T. T. T.）正常。白蛋白2.62克%/球蛋白4.21克%。

辨证：脾阳虚衰，运化失常阴水证。

治法：以温脾助阳，行气利水之法。

处方：

党参10克 炙黄芪15克 云茯苓15克 何首乌10克
附片5克 肉桂10克 熟地黄10克 车前子10克
白术10克 干姜10克 炙甘草5克 大枣5枚

连服40剂，浮肿消失，继续给药，以巩固疗效，早服补中益气丸，晚服桂附地黄丸，连服一个月痊愈。追访二年未复发。

按：由于脾阳虚所造成的水肿，称为阴水。阴水者纯为阳虚土败，土不制水而然。经曰：“湿胜则地泥，故土旺则运行而清浊分”。治疗此病宜温阳化水，首选方剂为实脾饮。但不可拘泥原方，应随症加减化裁。

第二章 脾 阴 虚

脾阳主温运，脾阴主融化，脾阳、脾阴互相协调才能完成对饮食的消化与吸收全部过程。因此，脾阴与脾阳是有同等的重要意义。若外因六淫之邪，损伤脾胃之阴，或五脏虚损，气阴不足，亦影响脾阴之充沛。因为五脏的津液相通，所以五脏之亏虚，气血津液之不足皆能导致脾阴之虚亏，而脾阴虚亏又可导致心阴、肺阴、肝阴、肾阴之不足，出现各脏阴虚的见症，故脾病则五脏不安，百病生矣。

脾阴虚症见：倦怠乏力，食欲不振，食后胀满，水谷不消，腹中轻度灼痛，有时轻度呕逆及口干渴，大便不畅，舌质红而不绛，

脉细数，乃脾阴虚亏之象。治宜甘平濡润，扶脾养阴之法。以滋脾饮（自拟方）治之。方中用沙参、山药、茯苓、石斛、白芍、莲子肉、麦门冬、陈皮、白扁豆、炒山楂、炒谷芽、炙甘草。兼气虚者加太子参。若大便燥结者加火麻仁。

滋脾饮 （自拟方）

沙参 山药 茯苓 石斛 麦门冬 白芍 莲子肉 陈皮
白扁豆 炒山楂 炒谷芽 炙甘草

方解：此方根据《温病条辨》中之益胃汤化裁而立。主治由于脾虚血亏，脾阴不足所致食欲不振，食后胀满，水谷不消等症。有滋润脾阴，健脾消导之功。方中以沙参为君，有“补五脏之阴”和“补阴而制阳”的作用；用麦门冬之甘润助沙参之力；山药味甘健脾为臣，能益气健脾；用白扁豆补五脏和中调脾助山药之力；以茯苓、莲子肉为佐，益气健脾；以石斛为使，能补脾阴而除虚热；以白芍养阴和营；以陈皮调中快膈；以炒山楂、炒谷芽健脾消食；炙甘草补脾胃之不足，能协和诸药，合而用之，有益气扶脾，濡润养阴之功效。

典型病例

黄×× 男 46岁 北京染料厂工人 1971年10月4日就诊：

主诉：上腹部经常隐痛已有1年余，食后胃部胀满，食量逐渐减少，西医诊断为“慢性胃炎”曾服中药100余剂无效，观其处方皆香燥理气之药。现症状：自觉胃中嘈杂，灼热隐痛，轻度呕逆，口渴咽燥，不思饮食。

检查：神清，肌肉消瘦，舌红少苔而不绛，脉弦细而数。

辨证：脾阴不足，消化不良之证。

治法：以甘平濡润，扶脾养阴之法。

处方：

沙参 15克 山药 15克 茯苓 10克 石斛 10克
白芍 10克 莲子肉 10克 白扁豆 10克 麦门冬 10克
陈皮 5克 炒山楂 10克 炒谷芽 10克 炙甘草 3克
连服15剂，症状消失而痊愈。

按：脾阴虚是脾胃虚弱病之一，过去有侧重脾阳，忽略脾阴之偏见。《素问·生气通天论》曰：“脾气不濡，胃气乃厚。”此段经文乃指脾阴虚失润则胃必壅滞厚重也。对脾阴虚证，明、清以来各家已有论述。如明·缪希雍曰：“胃气弱则不能纳，脾阴亏则不能消，世人徒知香燥温补为治脾之法，而不知甘凉滋润之药有益于脾也。”叶天士虽然提出在治疗温病时应注重滋养脾胃之阴，他认为温病“存得一分阴液，便留得一分生机”的理论，制定出养胃汤，这是脾胃学说的重大进步。在胃阴不足的治疗时，他使用甘凉救阴之药。但叶天士对脾阴虚与胃阴虚在治疗上混淆不清。清末唐容川曰：“调治脾胃须分阴阳，李东垣重脾胃但知宜补脾阳，而不知滋养脾阴，脾阳不足水谷不化；脾阴不足，水谷仍不化。”惟李东垣与唐容川对脾阴虚一证未详述，使这一重要理论长期无人论述，成为空白。1982年《虚证论》问世后，全国著名中医任应秋教授阅后对此书十分赞许，他认为《脾阴虚》一章弥补了中医理论的空白，实为中医界一大贡献，乃补前贤之所未备也。

第三章 脾胃虚寒

此证多由体质素弱，中阳不振，过食生冷或为寒邪所侵而致。中阳受损，运化无权，寒湿停留，上逆则吐，下趋则泄，阳虚寒凝则脘腹疼痛。阳气不达则四肢厥冷。虚阳外越则冷汗出。症见：面色苍白，上腹部疼痛，喜按，口不渴，有时呕吐，腹部疼痛，大便溏泄，小便清长，脉沉细而迟，舌淡苔白，此为中州虚寒停饮之象。治以温中散寒，补脾益胃，宜用吴茱萸汤加减，方用吴茱萸、党参、干姜、大枣、白术、肉豆蔻、厚朴、白芍、炙甘草。

吴茱萸汤

方解见第二篇心虚论第八章“小肠虚”中。

典型病例

南××，女，40岁，北京市高营小学教员，1977年10月4日就诊。

主诉：患胃痛已三年，泛酸暖气，痛时进食则安。身体消瘦，经胃部钡餐造影为胃小弯溃疡。脉沉细，舌淡苔白。

证属：脾胃虚寒之胃脘痛。

治法：以理气温中，散寒止痛之法，配制丸药调理之。

处方：

海螵蛸 60 克 荜 拔 15 克 茯 苓 60 克 槟 榔 30 克
五灵脂 30 克 元 胡 15 克 陈 皮 30 克 白 芩 30 克
川楝子 15 克 香 附 30 克 白 术 15 克 良 姜 15 克
法半夏 15 克 苍 术 15 克 草 薢 15 克 甘 草 15 克
焦三仙 60 克

共研细末炼蜜为丸，重 9 克，早晚饭后各 1 丸。连服一个多月，胃痛消失，饮食正常，体力恢复；随访二年未复发，身体健康。

按：脾胃虚寒证是临床常见病，多发病之一。其病因主要由于中阳不振或过食生冷为寒邪所侵，寒从内生。对于腹痛应详辨属寒、属热、属虚、属实。不可妄下诊断。虚寒之胃痛多见面色苍白，唇舌色淡，语声低微，畏寒喜暖，小便清长，大便溏薄，腹痛喜按，手足不温，喜热饮，得食稍安，脉沉迟无力。疼痛时发时止，秋冬季节易于发病。治疗此证应与实证、热证严格鉴别。如新发病，上腹疼痛剧烈应考虑急腹症——胃穿孔，急性胰腺炎，以及急性阑尾炎或阑尾穿孔等病，临证不可不慎。

第四章 胃经虚热

此证由于温病热邪不解，阳明热盛，胃阴受伤，以及大汗热劫胃阴，损伤津液。致使胃中虚热，气逆干呕，咽干舌燥，口渴引饮，舌光红少津。得食后则烦热愈增，乃伤胃阴也。治以甘凉救阴之法。宜用益胃汤、增液汤加减治之。方用生地、沙参、玉竹、麦门冬、元参、知母、花粉、石斛、黄芩、葛根、生甘草。清胃热而养胃阴。

益胃汤

沙参 麦门冬 细生地 玉竹 冰糖

方解：此方是清·吴鞠通所拟，载于《温病条辨》中。为治疗热病后期，由于邪热羁留，灼伤胃津，阴液受损所引起之胃中虚热，口渴引饮等症。此方可清热除烦，益胃生津。方中用麦门冬甘寒泻热除烦，止渴生津；沙参泻肺火，可补五脏之阴；玉竹补中益气，止渴除烦；生地甘寒滋阴清燥，凉血生津；冰糖助脾除热，润燥止渴。诸药合用，有养胃生津，清热润燥之功用。成为温热病后期恢复津液之良方。

增液汤

元参 麦门冬 生地黄

方解：本方是清·吴鞠通立方，载于《温病条辨》中。主治阳明虚热，津液不足，咽干口渴，大便秘结，属于阴亏液耗，所谓“液干多而热结少”者。用增液汤以养阴润燥，大便自畅。方中用：元参养阴生津、清热润燥为主药；麦门冬滋液润燥；生地黄养阴清热；本方甘寒滋润，有增液清热，养胃生津之功效，治疗津液不足之证，至为有效。

典型病例

李××，男，42岁，干部，1977年10月8日就诊。

主诉：患重感冒高烧七天，经中西医结合治疗，身烧已退，惟汗出过多。劫持胃阴，以致出现烦躁呕逆，口渴引饮，咽干唇燥，舌红少苔舌起芒刺。脉细而微数。

证属：胃经虚热，胃阴亏损证。

治法：以清热养阴，生津止渴之法。

处方：

麦门冬 10克 肥知母 10克 沙参 10克 天花粉 10克
石斛 10克 葛根 10克 玉竹 10克 元参 10克
竹茹 10克 甘草 5克 竹叶 10克

连服9剂，热清津生，症状消失而痊愈。

按：本症多发于温热病之后期，由于邪热久羁，灼伤胃阴；或因汗、吐、下后，导致胃阴耗损。阴液即耗，当复其阴。不然阴

亏燥必生变，则见身热、干咳等症，不可不慎。

用甘寒清养胃阴之法，以培补后天之本，乃遵叶氏养胃之说，并从鞠通之法。

第五章 湿伤脾胃

此证由于脾土虚弱，过食生冷，脾失健运，脾阳不能腐化水谷，以致水湿停滞中焦，阳气受遏，清气不能升，浊气不能降，气机升降失常，导致上吐下泻，寒气偏胜，故下利清稀而不臭。胃肠气滞则腹痛，湿注肠间则肠鸣。脉濡，舌苔白腻，为寒湿凝滞中焦之证。宜用温中散寒，芳香化浊之法。治以藿香正气散加减，方用苏叶、藿香、苍术、茯苓、厚朴、法半夏、陈皮、大腹皮、干姜、桔梗、白蔻、甘草、焦三仙等。

藿香正气散

藿香 苏叶 白芷 大腹皮 茯苓 白术 陈皮 厚朴
桔梗 炙甘草 生姜 大枣 半夏曲

方解：此方是宋·太平惠民和剂局之方剂。由于湿伤脾胃，以致脾为湿困，运化失常。症见：脘腹胀满，恶心呕吐。方以藿香芳香化浊，理气和中；佐以厚朴、大腹皮去湿消滞；半夏曲、陈皮理气和胃，降逆止呕；桔梗宣肺利膈，湿滞是由于脾不健运，脾运湿自化。故用茯苓、白术、甘草、大枣益气健脾，以助运化。如受寒邪，方中有苏叶、白芷，以解表散寒。此方表证里证皆可加减使用。有芳香化浊，调和脾胃，温中散寒，消胀化湿之功效。

典型病例

陆××，男，40岁，玉田县农民，1970年1月22日就诊。

主诉：五个多月来每天腹痛便泄，日泄五、六次，食欲不振，日渐消瘦，影响睡眠，医治无效，来京就医。诊两脉沉细而缓，舌淡苔薄白，检查大便常规阴性。

辨证：患者自秋后发病，乃湿伤脾胃，脾运不健，中焦阻滞，影响饮食。

治法：以芳香化浊，温中散寒之法治之。

处方：

藿香 10 克 苍术 10 克 陈皮炭 15 克 良姜 5 克
茯苓 10 克 吴茱萸 5 克 草果仁 5 克 焦神曲 10 克
炙甘草 10 克

服药 3 剂大见效，上方减良姜加法半夏 10 克，又服 3 剂痊愈。
嘱每日服参苓白术丸 2 次观察一年未复发，恢复劳动。

按：湿伤脾胃之证，多发于长夏季节。湿是一种重浊腻滞之邪，病易缠绵，常反复发作，湿阻中焦，伤及脾胃。以脘腹痞闷，不思饮食，食后恶心欲吐，尿少便溏，舌苔白厚腻为特征。在治疗湿症时，应慢慢调治，如抽丝剥茧，不可操之过急。此证治法：宜用芳香化湿，理气和中之药，以解湿邪而复正气。

第六章 湿困脾阳（阴黄证）

证属湿郁脾胃，脾阳不振，运化失常，因之胆液不循常道而外溢。症见身目发黄，肤色晦暗，神疲畏寒，四肢不温，食少脘闷，或觉腹胀，大便溏软；舌质淡，苔白腻或白滑。脉沉细或沉迟。为阳虚湿浊不化，湿困脾阳。证属阴黄。治以温化湿寒，健脾和胃之法，宜用茵陈附子干姜汤加减。方用茵陈、白术、附子、干姜、茯苓、泽泻、炙甘草。

茵陈附子干姜汤

茵陈 附子 干姜 草豆蔻 白术 枳实
半夏 泽泻 茯苓 橘红 生姜

方解：此方是元·罗天益撰拟，载于《卫生宝鉴》中。治疗脾家湿寒之阴黄症。由于湿多热少或过服寒凉通下之药，损伤脾阳，以致出现黄疸。症见肢重身寒，目肤色黄，腹满蜷卧，自汗自利，小便短少，渴不欲饮。方以附子、干姜之辛甘大热，散其脾寒；生姜之辛温散其表寒；半夏、陈皮理气和胃；白术、草蔻以健脾；枳实通之；泽泻泻之。更以茵陈退黄疸。此方为医治阴

黄之良法也。

典型病例

佟××，男，62岁，北京化工二厂职员，1978年10月5日就诊。

患者素嗜饮茶，近日自觉疲倦乏力，下肢浮肿，巩膜黄染，皮肤色暗，食少脘闷，腹胀便溏，肢冷畏寒，脉沉滑，舌淡苔白。经医院检查，肝功试验：谷氨酸-丙酮酸转氨酶（G. P. T.）300单位，麝香草酚浊度试验（T. T. T.）正常，澳抗（—）。

辨证：为湿困脾阳，成为阴黄症。

治法：以温化湿寒，健脾和胃之法。

处方：

茵陈20克 藿香10克 苍术10克 干姜10克
泽泻5克 茯苓10克 神曲10克 陈皮10克
官桂5克 吴茱萸5克 川厚朴5克 生甘草5克
生姜3片

经服药30剂，黄退肝功正常，嘱服参苓白术丸一个月，再复查肝功仍正常乃痊愈。随访二年未复发。

按：祖国医学对“黄疸病”的治疗早在两千年前，后汉张仲景在《金匱要略》中即有所论述，它和现代医学的黄疸型肝炎的症状和体征基本一致，在中西两法治疗中取得异曲同工之效。惟中医治疗此证要按辨证论治的原则区别为阳黄还是阴黄。阳黄者应以清热化湿去黄为治；而阴黄者应以温化寒湿去黄为法。惟本论专论虚证，阳黄纯为湿热，因此从略。

第七章 脾虚久泻

此证为脾胃虚弱，健运失常，饮食不化。脾为后天之本，脾虚不能运化水谷，气血化源不足，以致面色萎黄，食后脘闷，水谷不化，腹痛肠鸣，隐痛喜按，大便溏稀，日三五次，脉濡，舌淡，苔白滑，宜用补气健脾和胃渗湿之法。以参苓白术散加减。方

用党参、白术、茯苓、苍术、陈皮炭、姜炭、白扁豆、白蔻仁、山药、桔梗、建莲肉、炙甘草

参苓白术散

党参 茯苓 白术 山 药 白扁豆 桔 梗
砂仁 陈皮 大枣 建莲肉 薏苡仁 炙甘草

方解：此方是宋·《太平惠民和剂局方》之方剂。主治脾胃虚弱，饮食不消，多困少气，或吐或泻，四肢无力，胸脘满闷，食欲不振，大便不实或久泻等，乃消化功能减退之病。方中用党参、茯苓、白术、甘草有补气健脾的作用；而薏苡仁、山药、建莲肉、白扁豆除健脾外亦有渗湿的功能；陈皮、桔梗、砂仁有和胃醒脾之功用，并有帮助消化的能力。此方不寒不热，性味和平，为补脾健胃之良方。

典型病例

孙××，女，45岁，电珠厂工人，1977年12月5日就诊。

主诉：半年来肠鸣腹痛，大便稀，日泻2至3次，食欲不振，喜温恶寒。

检查：面色㿠白，脉沉细，舌淡苔白。大便检查为阴性。

辨证：脾胃虚寒之久泻证。

治法：以温中散寒，和胃止泻之法。

处方：

党 参 10 克 白扁豆 10 克 白 术 10 克 苍 术 10 克
陈皮炭 10 克 吴茱萸 5 克 姜 炭 10 克 茯 苓 10 克
肉豆蔻 5 克 炙甘草 5 克 苏 梗 5 克

连服15剂，腹痛消失，饮食增加，便泻停止。嘱：服参苓白术丸一个月，以便巩固疗效，随访一年未复发，痊愈。

按：长期慢性腹泻，如大便检查未见脓细胞、红细胞者，多为脾虚运化功能减弱所致，治疗原则应以健脾化湿为主。

如久泻出现脱肛者可酌加生黄芪、乌梅炭、升麻等，益气升清，提高疗效。

第八章 脾肾虚寒（五更泻）

拂晓以前腹痛做泻，泻后乏力。又名鸡鸣泻，为肾阳不振，命门火衰所致。症见：腹痛肠鸣，腹冷喜暖，四肢逆冷，食少面黄，体倦神疲；脉沉细，舌淡苔白。证属脾肾阳虚之象。治以温补脾肾，固肠止泻之法。宜用四神丸（汤）加减。方用破故纸、吴茱萸、肉豆蔻、茯苓、白术、干姜、菟丝子、五味子、炙甘草。气虚者加党参、黄芪；久泻滑脱者加乌梅炭、石榴皮、诃子肉。

四神丸

破故纸 五味子 肉豆蔻 吴茱萸 生姜 红枣

方解：此方是明·王肯堂立方，载于《证治准绳》书中。主治脾肾虚寒、鸡鸣泻。症见：黎明前泄泻，不思饮食，食不消化，少腹隐痛，腰酸肢冷，神疲乏力。乃命门火衰，肾阳不能上温脾土。以致运化功能减弱，下利完谷不化。方中用破故纸善补命门之火，以温养脾阳，为主药；辅以肉豆蔻暖脾涩肠；以吴茱萸温中祛寒为佐；五味子酸敛固涩；以大枣补脾养胃；以生姜温胃散寒。各药合用，成为温肾暖脾，固肠止泻之良方。

典型病例

李××，男，66岁，退休职员，1979年11月5日就诊。

患者体质较弱，大便溏稀，每日晨起即泻，有时下午或晚间再泻一二次，泻前肠鸣腹痛，泻后即止，整日疲倦乏力，面黄食少，肢冷喜暖，腹部有时隐痛，脉沉细，舌淡苔白。

辨证：乃脾肾阳虚，鸡鸣泻病。

治法：以温补脾肾，固肠止泻之法。

处方：

党参 10克 白术 10克 破故纸 10克 肉豆蔻 5克
干姜 10克 乌梅炭 10克 吴茱萸 10克 菟丝子 10克
炙甘草 5克

经服药21剂后大便正常，日1次，腹痛消失。痊愈。嘱经常服用四神丸以巩固疗效。随访二年未见复发。

按：五更泻也是慢性腹泻之一，是以黎明前腹痛肠鸣，起床

即泻为主要症状。泻后周身乏力，重则腰膝冷痛，阳痿遗精，舌质淡边有齿痕。此为命门相火虚衰，脾阳不振所致，以补命门之火为主，兼顾脾阳，使脾有运化之力。老年体衰者使用附子、肉桂温助元阳；更加生黄芪以升提助气；使肾阳充盈，脾运恢复，泄泻自止，体力自复。

第九章 食伤脾胃

胃主受纳，脾主运化，若脾胃虚弱，水谷入胃而无克化之能力，停积不化，自觉中脘痞闷，上腹胀满，大便发干，或不消化状。证属脾胃虚弱，食滞不化，脾虚当补，食滞宜消，根据“脾升则健，胃降则和”的道理，宜用升清降浊之法，使气机通畅则中焦痞满可消。以补为主，寓消于补之中，消补兼施之法。化滞以人参健脾丸、加味保和丸同用。汤剂可用党参、苍术、白术、槟榔、砂仁、陈皮、茯苓、焦三仙、木香、莱菔子、甘草等，补中健脾，消导化滞。

人参健脾丸

人参 枳壳 山药 薏苡仁 白术 青皮 神曲 砂仁
木香 莲子肉 山楂 芡实 当归 谷芽 陈皮 白扁豆
甘草

方解：此方是明·张景岳立方，载于《景岳全书》中。主治由于脾胃虚弱引起精神倦怠，呕吐，倒饱嘈杂，食物不消，脾虚久泻，面黄肌瘦。方用人参、白术、甘草，山药、白扁豆、莲子肉、薏苡仁、芡实健脾利湿；以枳壳、陈皮、青皮、砂仁理气燥湿，调中导滞；以山楂、神曲、谷芽化滞消食；用当归补血以养脾。此方为补脾健胃，消导化滞之良方。

加味保和丸

山楂肉 法半夏 神曲 云茯苓 炒麦芽 炒白术 枳壳
香附 厚朴 陈皮

方解：此方是明·龚信所撰拟，载于《古今医鉴》中。主治

脾胃不和，蕴湿积食所引起的胸膈痞满，噯气吞酸，胃脘疼痛，以及各种食积。方中用厚朴、枳壳、陈皮、香附、半夏宽中降气，平胃利膈，以神曲、山楂、麦芽消导化滞；以茯苓、白术健胃补脾。此方为治疗各种食积之良药，有消食化水之功用。

典型病例

刘××，女，66岁，退休工人，1979年2月20日就诊。

患者年老体弱，春节期间饮食厚味，消化乏能，以致腹脘痞闷，饮食乏味，食不消化，噯气打呃，大便呈不消化状，脉沉缓，舌淡苔黄腻。

辨证：食伤脾胃，消化不良。

治法：以益气健脾，消导化滞之法。

处方：

党参10克 苏梗5克 陈皮炭10克 藿香10克
厚朴3克 草果仁5克 苍术10克 枳壳5克
白术10克 茯苓10克 槟榔5克 焦三仙30克

服药9剂，脘痞消失，食欲正常。嘱经常服用人参健脾丸，以健脾运而助消化。病即痊愈。

按：食伤脾胃之证为临床多见病，此证以胃脘胀闷，不思饮食为主症。食滞不消是标，其本为脾胃虚弱。治疗此证多以标本兼治为立法。宗汉·张仲景所立枳术丸，只以两味药立方，一味白术健脾益胃，一味枳实化滞下气，消痞除满，寓消于补，标本兼治，立方有法，药简意赅，吾辈对待药方，应视为是法。如人参健脾丸即从枳术丸发展而来，不论如何变化，不外消补二字。

第十章 中气下陷

此证多由身体虚损，中气下陷，导致胃腑肌肉松弛，收缩能力减弱，或牵引其它脏器的肌肉松弛、乏力，使脏器下垂。主要是胃体的下垂，严重的可至脐以下。有的肝脏下垂，肾脏下垂和子宫下垂。胃下垂的病人平卧时，在脐下用手可以摸到胃体。在

食后，正常人为上腹部胀满，而胃下垂的病人则在食后脐部出现膨隆胀满的感觉，同时疼痛下坠。一般病人体型瘦高，身体较弱，面色清瘦，经常有胃脘隐痛、胀饱噎气、厌食等症状。有时有呕吐，脉沉细，舌淡苔薄白。经治疗症状可以缓解，因无过多的病痛，一般病程较长，有多达 10 年以上病史。证属中气下陷，脾胃虚寒。治宜益气升提，温中收敛之法。用补中益气汤、吴茱萸汤加减。方用党参、黄芪、白术、吴茱萸、良姜、当归、升麻、柴胡、肉桂、乌梅、诃子肉、炙甘草。

补中益气汤

黄芪 党参 白术 当归 陈皮 升麻 柴胡 炙甘草

方解：此方是元·李东垣所拟，载于《脾胃论》中。主治由于脾胃虚弱，气虚下陷所引起的胃下垂、脱肛、子宫脱垂等病。此方能调补脾胃，升阳益气，鼓舞脾胃清阳之气，使精微输布，则气血自充，诸症自除。方中以黄芪补中益气，升阳固表为主药；党参、白术、炙甘草甘温益气，补脾益胃；脾胃乃气血营卫生化之源，脾胃强健，则正气自充。陈皮理气化滞；用升麻、柴胡协同参、芪升举清阳，使下陷之气得以升提。血生于气，气虚则血弱，故用当归补血和营。诸药合用，具有补中益气，升阳固表之作用。使脾胃健壮，中气充足，则气陷得升矣。

吴茱萸汤

方解：见第二篇心虚论第八章《小肠虚》中。

典型病例

张××，男，42岁，外贸部职员，1969年10月4日就诊。

主诉：五、六年来胃脘经常疼痛，胀饱，食后脐以下胀痛。

查：体型瘦长，面色晄白，脉沉细缓，舌淡苔薄白。在积水潭医院检查：胃部透视为胃下垂。

辨证：脾胃虚寒，中气下陷。久病必虚，虚多兼寒。证属中气下陷，脏腑韧带松弛，胃下垂，病程愈长愈难医治。应以益气温提之法，必须长期坚持服药，医治方可奏效。

治法：以补脾益气，温中升提收敛之法。

处方：

党 参 15 克 生黄芪 15 克 白 术 10 克 乌 梅 5 克
诃子肉 10 克 肉 蔻 5 克 升 麻 2 克 干 姜 10 克
肉 桂 3 克 当 归 10 克 炙甘草 10 克 大枣五枚

经过一年的治疗，服药 200 余剂，症状消失。经医院检查胃体已提升至脐上，饮食增加，体质恢复，基本痊愈。

按：中气乃指脾胃之气，即所谓之正气，各种脏器皆赖以承之，今升降之机失常，正气虚衰不能举器，脏器势必下沉。出现胃下垂、肝下垂、肾下垂、子宫下垂以及直肠下垂之脱肛等症。祖国医学对上述几个病在病理、病因上是相同的，都是由于中气下陷所致，因此可以采取“异病同治”之法。

第五篇 肺 虚 论

《素问·阴阳应象大论》曰：“西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺主皮毛，皮毛生肾，肺主鼻，其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在音为商，在声为哭，在变动为咳，在窍为鼻，在味为辛，在志为忧，忧伤肺，喜胜忧，热伤皮毛，寒胜热，辛伤皮毛，苦胜辛。”《素问·六节藏象论》曰：“肺者，气之本，魄之处也。其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。”《素问·至真要大论》曰：“诸气愤郁皆属于肺。”《灵枢·脉度篇》曰：“肺通气于鼻，肺和则鼻能知香臭矣。”从以上几段经文来看，说明肺的生理功能和病理变化。

肺主气有两方面含义：一、司呼吸之气。吸入自然清新之气，呼出体内之浊气，吐故纳新，为人体气体交换之场所。二、主一身之气。即肺与宗气生成有关，宗气上出喉咙，司呼吸贯心脉以行气血，从而使宗气、气血输布全身，营养各组织器官，维持其正常功能活动。

肺主周身皮毛，开窍于鼻。皮毛是指皮肤和毛孔，它有调节人体温度的作用。毛孔的扩张和收缩与肺的呼吸有密切关系，如肺虚时则腠理不密，皮毛不固，容易出汗，并易发生感冒。

肺主肃降，有通调水道，宣散水气之作用。肺气肃降，才能使水道通调，下达膀胱。如肺气上逆，水必随之上行，则出现面目浮肿等症状，所以有“肺为水之上源”的说法。肺可以宣散水气，通过全身皮肤汗腺，适当的蒸发汗液，保持皮肤的湿度。

肺司声音，声音的发生与肺有关，如肺气不足，则发音低微。久嗽伤肺，气阴两伤，可以出现失音，称之为“金破不鸣”。

肺属金，心包属火，火本克金，今肺受邪反传心包，故曰逆传心包。肺金为脾土之子，肺病及于脾，是子病犯母；反之脾土能生肺金，脾气虚则肺金更弱。由于肝气亢盛而横逆，因之肺气

喘急，乃木叩金鸣；也可由于肝火亢盛，逆行肺络，而致络血。肾为肺之子，由于肺气虚损，导致肾气衰弱，是为母损及子；同样，也可因肾气衰弱，而导致肺虚，即水冷金寒，是为子克母也。因此治肺必当补脾肾，脾与肾对肺有直接母子相生相克制化的关系。脾旺肾充则肺疾易除，肺虚易解，即此理也。（见图 8）

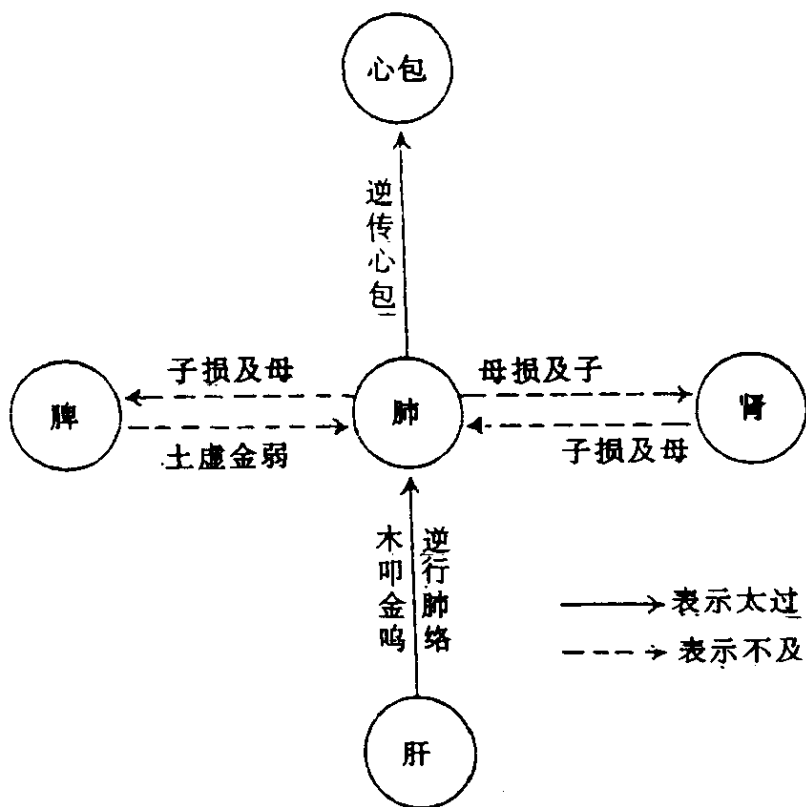


图 8 肺病机理示意图

第一章 肺 气 虚

肺为气之主，肺气虚乏则气无所主，故喘促，短气息急，不能相续，提之若不能上，咽之若不能下，语言无力，咳声低微，卫外不固，自汗畏风，痰少不爽；甚则心悸，肢冷，脉沉细无力，舌淡，此为肺气虚损不足之象。宜以补肺汤加减治之。方用党参、炙黄芪、桑白皮、熟地黄、紫菀、五味子、款冬花、百合、枇杷叶、白术、炙甘草。补益肺气，固表止喘。凡阳气不足者可加远志、桂

枝。

补肺汤

人参（党参） 白术 茯苓 阿胶 五味子 薏苡米
紫苏梗 桑白皮 法半夏 川贝母 杏仁 米壳 百合
款冬花 甘草

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》内。主治肺气虚损，咳嗽声重，上气喘急，胸满气逆，坐卧不宁。方用人参（党参）、白术、茯苓、甘草、薏苡米可益气健脾，培土以生金；用款冬花可消痰除烦，降气止咳；用百合、阿胶可补益肺气，养血滋阴；用苏梗散寒宣肺，下气定喘；用五味子退热敛汗，止嗽定喘；用半夏、陈皮、川贝母除湿化痰，降气定喘；用桑白皮清泄肺火，下气行水；用杏仁清肺润燥，降气化痰；用米壳收涩敛肺，止咳定喘。

典型病例

龚××，男，72岁，人民银行退休职员，1977年9月6日就诊。

症状：年老体弱，肺气虚损，行动气短，心跳，言语无力，咳嗽声小，易汗，脉弦细，舌淡苔白。

辨证：肺气虚损。

治法：益气补肺，固表止汗之法。

处方：

党参10克 生黄芪10克 桑白皮10克 白术10克
五味子10克 茯苓10克 紫菀10克 生龙骨10克
熟地黄10克 款冬花10克 百合20克 炙甘草5克

经过两个月治疗，共服药50剂，汗止喘停，体力恢复。嘱长期服用人参保肺丸、利肺片，（内含蛤蚧、冬虫草）。虽然年已过古稀，但经过治疗，加之做太极拳一类的体育锻炼，体质较以前甚有改善。

按：肺司呼吸，人之于气如鱼之于水，须臾不能离也。肺为肾之母，母病则子无以为养，肺病日久而虚喘乃母病及子。人之呼吸在肺，其根在肾，虚则气不能达于丹田，动则气喘，少气，气

短，即所谓肾不纳气也。因此在治疗肺虚喘时，应加补肾之药，以固其本。如补肺汤中之熟地黄、五味子即此意也。又《本草备要》曰：“气不归元则喘，用龙骨能收敛浮越之正气。”

第二章 肺虚感寒

肺为娇脏，为阳中之太阴，既恶热又恶寒。故《素问·宣明五气论》曰：“形寒饮冷则伤肺。”此证为肺气素虚，兼受重寒，寒邪郁于肺，不得发越，以致咳嗽喘满，不能平卧，胸中胀闷，痰液稀薄，有泡沫，身躯怕冷，每遇寒冷则咳嗽、气喘加重；脉紧，苔白滑。此证为肺虚寒邪郁于肺。治宜用小青龙汤加减。方用人参、白术、麻黄、细辛、干姜、桂枝、半夏、五味子、杏仁、莱菔子、甘草。此方能补中益气，温肺散寒，止咳平喘。此症最忌苦寒之药，免致虚虚、寒寒之误。

小青龙汤

麻黄 白芍 桂枝 干姜 半夏 细辛 五味子 炙甘草。

方解：此方是汉·张仲景立方，载《伤寒论》中。主治肺虚中寒，寒邪郁于肺，以致咳嗽喘急，肺胀胸满；甚则喘息不得平卧，面目浮肿，此象为内饮外寒，郁结不解。方中用麻黄、桂枝发汗解表，宣肺定喘；白芍配桂枝以调和营卫；干姜、细辛内以温化水饮，外以辛散风寒；半夏燥湿化痰，蠲饮降浊；五味子敛肺止咳；炙甘草缓烈药之性。诸药合用，配伍极为严密，千年以来为医家所遵行。

典型病例

母××，女，50岁，第四服装厂工人，1977年11月15日就诊。

主诉：患慢性气管炎，肺气肿已有十年之久，经常咳嗽气喘，时好时犯，遇寒即发。近日感寒凉，咳嗽气喘，胸闷憋气，不能卧寐，夜更甚，肢体畏寒；患者素喜饮茶，有湿盛停饮之象；脉紧，舌淡苔白。

辨证：肺虚停饮，风寒郁于肺。

治法：解表散寒，化饮定喘之法。

处方：

苏子 10 克 麻黄 3 克 杏仁 5 克 太子参 15 克
法半夏 10 克 细辛 2 克 白术 10 克 莱菔子 10 克
五味子 5 克 干姜 10 克 桂枝 10 克 炙甘草 5 克
生姜 3 片

连服 15 剂，症状基本消失，惟有轻度咳嗽。嘱经常服用参苏理肺丸和利肺片（内含蛤蚧及冬虫草）。经冬未犯。

按：此证因肺气虚，内有水饮，一旦感受寒邪，每致表寒引动内饮，寒痰阻肺，咳嗽，痰白清稀有泡沫，喘息胸满，甚则不得平卧，面浮肢肿。当此内饮外寒，郁结不解之际，单纯解表则水饮不化，单纯化饮则外邪不解，惟有以解表与化饮配合，才能使外邪得解，里饮蠲化，一举而表里均治。

第三章 肺 阴 虚

肺为娇藏，为火所迫，损伤肺阴，失其清肃。久之，肺必枯燥。症见：咳嗽无痰，或痰少而粘，或咯痰带血。日晡潮热，午夜盗汗，烦躁失眠，脉细数。舌质红少苔。宜用滋肺阴，润肺燥之法。以养阴清肺汤加减。方用生地黄、元参、麦门冬、丹皮、白芍、川贝母、薄荷、紫菀、枇杷叶、杏仁、甘草。以清肺祛火，滋阴润燥，可恢复肺之清肃。

养阴清肺汤

生地黄 麦门冬 元参 贝母 丹皮 薄荷 白芍 生甘草

方解：此方是清·郑梅涧立方，载于《重楼玉钥》中。主治：养阴清肺，凉血解毒，肺燥伤阴，津液不足等症。方中用生地黄、元参养阴凉血，清热解毒为主药；以麦门冬、白芍助生地黄、元参养阴之力；以丹皮助生地黄、元参凉血解毒；以贝母润肺止咳，化痰清热；以生甘草泻火解毒；薄荷宣肺利咽。此方以甘寒滋润

药物为主，配伍成方，具有养阴清肺，凉血解毒的疗效。

典型病例

孙×，男，45岁，京剧演员，1970年1月5日就诊。

主诉：连日因排练和演出较为劳累，感觉咽干喉痛，烦躁口渴，请求治疗。

检查：咽赤不肿，脉弦数，舌红少津。

辨证：肺经虚热。

治法：养阴清肺，润燥生津之法。

处方：

生地黄 15克 沙参 10克 知母 10克 枇杷叶 10克

元参 15克 杏仁 5克 川贝母 10克 白芍 10克

紫菀 10克 苦桔梗 10克 麦门冬 10克 甘草 5克

服药6剂，诸症大减。嘱继服养阴清肺膏，每日3次，连服4天痊愈。

按：肺为娇脏，喜润恶燥，如燥火炽盛，为火所迫则肺失清肃，津液损伤，出现咽喉肿痛，口中燥渴，乃肺虚热之象，只宜用甘寒滋润之药，以生肺津而润肺燥。苦寒之药虽能清火，但有燥湿之作用，不可遽用，反伤其津。

第四章 肺虚失音

失音之症分为两大类：第一类：为风寒或风热侵袭入肺，肺失清肃，因而引起咳嗽，声音嘶哑，咽赤口干，脉浮数或浮紧，舌红苔白。此类应以清肺散风寒开音之法，此类病症属表、属实、属热以及病程短等特点，易于辨认。因本论专述虚证，故从简。

第二类：为内伤肺虚，气阴两伤而引起的失音或声音嘶哑。此类多有慢性疾病，如肺癆、肺痿等病。肺主气，司呼吸，声音发于肺，肺脉通于喉，气出于肺过喉而发音。肾为肺之母，气之根又在肾，若命门火衰，肾阴不足，虚火烁金，不能济子，此乃肺肾虚损，气阴两伤导致声音嘶哑。应以滋肾阴补肺气之法，使肺

气充，肾阴足，则音自出。宜用百合固金汤、诃子散加减。方用百合、太子参、熟地黄、山茱萸、枇杷叶、紫菀、川贝母、杏仁、诃子肉、桔梗、甘草。

百合固金汤

百合 白芍 当归 川贝母 生地黄 熟地黄 麦门冬
元参 桔梗 生甘草

方解：此方是清·汪切庵所拟，载于《医方集解》中。主治肺伤咽痛，咳嗽血痰等症，肺主气，百脉皆朝于肺，气之为病，非实而不顺，受邪之后虚而不足。百合能治邪气之实，能补正气之虚。肺痿症阴虚火旺，口燥咽干，以元参为主药；协同生地黄，熟地黄，麦门冬、知母滋阴降火；以桔梗开咽利膈；以当归、白芍和血敛阴；以生甘草补脾和中。此方为治疗肺经虚热，咳嗽血痰的有效良方。

诃子散

诃子 桔梗 甘草

方解：此方是清·刘河间立方，主治失音不出。方中以诃子清肺行气，开音止渴，敛肺降火为主药；以桔梗泻肺开胸，清利咽喉。生甘草与凉药同用，则可清泻邪热，并有解毒作用。明代王肯堂将甘草、桔梗合用名为甘桔汤，可以治疗毒热上攻所引起的咽喉肿痛，痰嗽失音。后人刘河间在此方的基础上再加诃子一味药，名为诃子散，效力更佳，是医治失音证的有效良方。

典型病例

张××，女，23岁，山西农民，1975年10月8日就诊。

病况：1975年起患浸润性肺结核自山西省来京治疗。除在结核病院治疗外，感觉声音嘶哑，已有1个月余。有轻度咳嗽，痰少，下午低烧；脉细数，舌红少津。

辨证：为火灼金，肺阴虚损，气阴两伤之失音症。

治法：以益气清肺、滋阴润燥之法。

处方：

太子参 10克 麦门冬 10克 杏仁 5克 川贝母 10克
百 合 15克 桔 梗 10克 枇杷叶 10克 紫 菀 10克

生地黄 20 克 诃子肉 10 克 生甘草 5 克 款冬花 10 克
经治疗两个月，服药 50 剂，低热退，声音嘶哑消失。

按：失音之证当分虚、实，临证早期发病，多为风寒侵肺，寒闭肺中所致，同时风寒化热可出现口干舌燥，咽喉肿痛等伤阴症状。但气未损，肾未伤不可遽用补肾、补气之药而犯实实之过。只宜使用麦门冬、天门冬、知母、花粉等清热育阴药并酌加表散药。本章所述之肺虚失音，肾经损伤较重或属老年肾阳虚，或肾阴虚，以及精气不充，肾阴阳两虚之证，乃子病及母也。此时宜重用补气、补肾之药。

第五章 肺 痿

《素问·痿论》曰：“肺者，藏之长也，为心之盖也，发为肺痿。”肺居心之上，五脏之长，又称华盖。心脏之血流入于肺，携氧运行全身。心与肺有密切的连带关系。

《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上气病篇》曰：“寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病。”此证形成的主要原因，乃肺有燥热，灼伤津液；或肺气虚冷，气不化津，津液不布，肺失濡养，肺叶日渐枯痿而成。临床可分为虚热肺痿和虚寒肺痿两种。

肺痿多由肺部疾患长期不愈转化而成。如《证治汇补》曰：“久咳肺虚，寒热往来，皮毛枯燥，声音不清，或嗽血丝，口中有浊唾涎沫，脉数而虚，为肺痿之病。”如肺癰、肺癆、久嗽、哮喘等病日久灼伤肺阴，正气渐虚均可形成肺痿。应辨虚热、虚寒之异，以免诊治贻误。

一、虚 热 型

久嗽伤阴，肺阴消灼，或肺癰热毒熏蒸伤阴，或消渴津液耗伤，或热病邪热伤津。以上各种原因，不外损伤肺、胃之阴，胃

津不能上输，上焦生热，以致肺燥津枯，热燥日益耗阴，故阴难复，肺失清肃，宣降失司，津液不布，则咳而口吐涎沫，虚热肺痿乃成。症见：形体消瘦，皮毛干枯。口干咽燥，咳吐涎沫、其质粘稠，舌红而干，脉虚数，乃阴枯热灼之征。治宜清热润肺，滋阴生津之法。用麦门冬汤加减，方用人参、麦门冬、天门冬、五味子、茯苓、百合、枇杷叶、杏仁、川贝母、石斛、生地黄、沙参、玉竹、甘草。

麦门冬汤

人参 麦门冬 半夏 粳米 生甘草 大枣

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中，仲景以此方治疗虚热型之肺痿。方中重用麦门冬以清胃中虚热而生胃津，为主药；辅以人参、甘草、大枣、粳米以益胃气而生胃液，胃阴充足，则津液自能上输于肺，使肺得所养；佐以半夏开通胃气，下气降逆，化其痰涎；其中甘草生用，并能清热而利咽喉。各药合用，使胃得其润，肺得以滋，虚火得降，咽喉得利，咳嗽气逆自愈。

典型病例

王××，男，29岁，北京市器件三厂工人，1968年6月5日就诊。

病史：患肺结核已休养6个月，住结核病医院，用抗结核药物治疗。出院后继续在家休养，现咳唾涎沫有时带血，下午低烧，夜间盗汗，烦躁不眠，请求用中药协助治疗。

检查：患者颧红，舌绛，两脉细数。

辨证：肺经虚热，阴津损伤，为肺痿证。

治法：以清肺降火，生津润燥之法。

处方：

生地黄 20克 紫菀 10克 苦桔梗 10克 百合 20克
麦门冬 10克 玉竹 10克 川贝母 10克 元参 10克
枇杷叶 10克 沙参 10克 赤芍 10克 生甘草 5克

经过3个月的中西医结合治疗，共服汤药60剂，症状逐渐减轻，以至消失。在10月间复查，结核病灶已吸收，痊愈。

二、虚寒型

虚热肺痿日久，阴伤及阳；或大病、久病之后，耗气伤阳，阳虚生寒，导致肺虚有寒，气不化津，津液不布，津反为涎；肺气虚冷，不能温摄津液，肺失濡养，痿弱不用，此属虚寒肺痿。症见：头晕短气，形寒畏冷，神疲乏力，饮食减少，口不渴，吐涎沫，其质清稀量多，小便数或遗尿，舌质淡，脉虚弱，乃肺痿气虚有寒之征。治宜益气温肺散寒之法。用甘草干姜汤加减，方用甘草、干姜、人参、白术、茯苓、黄芪、山药、莲肉、桔梗、五味子等。

甘草干姜汤

甘草 干姜

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中，仲景以此方治疗虚寒型之肺痿。方中以甘草为主药；用量倍于干姜，甘草入脾益肺，取甘守津回之意；干姜温肺脾，使气能化津，水谷归于正化，则吐沫自止。如增加人参、白术、大枣、茯苓等药，则效果更佳。

典型病例

吴××，男 72 岁，退休职员，1972 年 11 月 5 日就诊。

主诉：有肺结核病史，近期自觉头晕气短，身疲乏力，形寒畏冷，动则作喘，饮食减少，大便溏稀。

检查：患者面白清瘦，两脉沉细，舌淡苔白，X 线片右肺陈旧性钙化灶两处。

辨证：肺经虚寒。

治法：益气温肺散寒之法。

处方：

人 参 5 克 紫 苑 10 克 干 姜 10 克 肉 桂 6 克
百 合 20 克 五味子 10 克 百 部 10 克 黄 芪 20 克
沙 参 10 克 茯 苓 20 克 款 冬 10 克 炙甘草 10 克
服 20 剂，精神气力大增，继服洋参保肺丸一个月痊愈。

按：肺痿证部分病例与现代医学之肺结核相似，由于结核菌

之邪久羁于肺，使气阴两伤，应以驱邪为主，兼扶正气。20年代以前，此病死亡率较高，而且多发生在青年人身上。由于抗结核菌药物的出现，大大提高此病的治愈率。但肺脏受邪热的侵袭，羁留日久，必然灼伤津液，则应给以中药益气养阴之品，起到扶正作用。如中西药合用可减轻病人痛苦，缩短疗程，提高疗效，使病人早日获得痊愈。

第六章 肺 虚 喘

气喘之病最为危险，应辨虚实。实喘者为邪气实也；虚喘者无邪，乃元气虚也。实喘者气长而有余，虚喘者气短而不续，实喘有胸胀气粗，声高息涌之状；虚喘者有心慌气怯，声低息短，惶惶然气欲断之感，稍行动则气喘不止。肺为气之主，肾为气之根。因之虚喘有肺虚作喘，和肾元亏损、肾不纳气作喘两种。

肺虚则气失所主，故短气喘促，言语无力，咳声低弱，肺主皮毛，肺气虚弱则外卫不固，故自汗畏风；肺阴虚则咽喉不利，口干面红，脉弱，舌质淡红。此乃气阴两虚之征。宜用生脉散加减。方用人参、麦门冬、五味子、沙参、茯苓、杏仁、枇杷叶、紫菀、百合、款冬花、炙甘草。

若年老体弱，大病及大汗之后，或产后失血过多，肾元虚亏，症见：呼吸短气，出多入少，喘促不得卧，心慌不宁，自汗出，小便失禁，脉浮大，按之空虚见芤脉者，乃元气大虚而无根，命门火衰，真阳不足，肾不纳气之故也。宜用桂附地黄汤加减治之。方用肉桂、黑附子、茯苓、山药、牛膝、山茱萸、枸杞子、人参，生黄芪、炙甘草，重用熟地黄以引火归元，气纳丹田，其喘自止。

至于由肾水不足，虚火上炎而喘者，应以知柏地黄汤加减治之。方用知母、黄柏、熟地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、煅牡蛎、煅龙骨、牛膝、五味子等壮水之药，以制虚火。

生脉散

方解：见第二篇心虚论第二章“心阳虚”中。

桂附地黄丸

熟地黄 丹皮 茯苓 山药 山茱萸 泽泻 肉桂 附子

方解：此方以汉·张仲景的金匱肾气丸为基础，经后人修改，将桂枝易肉桂，得出此方。方中以附子、肉桂壮命门之火；熟地黄、山茱萸滋补肝肾，养血增精；茯苓、山药健脾渗湿、丹皮、泽泻清泻肝肾虚火，为温补肾阳之主药。

知柏地黄汤

知母 黄柏 熟地黄 丹皮 山药 茯苓 山茱萸 泽泻

方解：此方载于清·《医宗金鉴》内。本方以滋阴降火为主，主治阴虚内热，虚火上炎出现的骨蒸潮热，手足心热，舌燥喉痛，虚火牙痛，头晕耳鸣，耳聋等症。方中以熟地黄为滋肾补精的主药；以山茱萸养肝涩精；山药补脾固精；茯苓淡渗脾湿，以助山药之健运；知母与黄柏泻相火补肾水。此方为滋补肝肾，清泻虚火的有效良方。

典型病例

于××，男，82岁，退休职员。年老体弱，已逾八旬，素有慢性咳喘病史，动则气喘，遇寒尤甚。1979年11月5日经友人邀至老人家中诊治。

检查：精神尚可，面色微黄，体瘦目陷，动则气喘，自觉胸中发憋，短气不续，出多入少。下肢浮肿，嗜睡，能吃流食，脉弦细而迟，舌淡苔白。

辨证：年老体弱，肺气虚衰，真阳不足，肾不纳气，肺肾两虚之证。

治法：益气建中，补肾助阳之法。

处方：

党参 20克 生黄芪 20克 炒白术 10克 肉桂 5克
熟地黄 30克 制附片 5克 牛膝 10克 枸杞子 10克
炙甘草 5克 陈皮 3克 生姜 3片 大枣 5枚

经过三个月的治疗，共服药70余剂，体力恢复，生活已能自理；嘱早服桂附地黄丸1丸，晚服人参鹿茸丸1丸，巩固疗效。

按：明·张景岳曰：“气喘之病，最为危候，治失其要，鲜不

误人，欲辨之者，亦惟二证而已。所谓二证者，一曰实喘，一曰虚喘也。”《灵枢·经脉篇》曰：“虚喘者，肾元亏损，肾气不纳而上出于肺，肺为气街不能自主，故出多入少而喘也；其卧时愈甚者，因卧则肺叶向脊上阻碍气道也。”

治疗喘病首辨虚实。实喘者为有邪，乃邪气实也；虚喘者为无邪，乃肺气虚也。肾为肺之子，若肺虚必影响其子。肺虚作喘为吸气长而呼气短，当以补肺为主，兼补其子。肺主气，气之根在于丹田、气海。若肾虚无根，肾不纳气必出现吸气短而呼气长，上下不相续，其病则深，势剧重危，当速救其根，应以补肾为主，兼治其肺。后者多发于老年命门火衰之人，临床应审慎辨治。

第七章 大肠虚寒泻

《难经·五十难》曰：“大肠泄者，食已窘迫，大便色白，肠鸣切痛”。此症为大肠虚寒。每日溏泻无度，完谷不化，便泻色淡而不臭，肠鸣，少腹痛而喜按，不能久立，口渴唇干，目急善惊，脉沉缓，苔白滑，为肠中寒也。大肠恶寒而喜温，偶有湿寒，即腹痛泄泻。故治肠应温，宜用温中散寒之剂，以附子理中汤加减治之。方用人参、黑附子、干姜、苍术、白术、甘草、陈皮炭、木香、藿香梗、苏梗、肉豆蔻温中散寒，助阳化湿。

附子理中汤

方解：见第一篇总论第七章“虚寒”中。

典型病例

刘××，女，72岁，健康西里18号，家庭妇女，1969年4月3日就诊。

病况：年老气虚便泻已有2个月，腹痛即泻，大便溏稀，恶寒喜暖，腹痛肠鸣，检查：大便常规为阴性，脉沉细缓。

辨证：大肠虚寒泻。

治法：温中散寒，止泻固肠之法。

处方：

党参10克 白术10克 姜炭10克 陈皮炭10克

藿香梗 10 克 苏 梗 10 克 肉豆蔻 5 克 黑附片 5 克
茯 苓 10 克 肉 桂 5 克 炙甘草 5 克 大 枣 3 枚
生姜 3 片

连续服药 15 剂，症状消失，痊愈。嘱经常服用附子理中丸，勿食凉食，勿受凉，数年未复发。

按：泄泻病之发生，有因饮食生冷过度，肠自身受寒而泄泻者；有因肾阳虚衰，命火不足，脾失温煦，运化失常，而致泄泻者；有因肺经虚寒所致而泄泻者。肺与大肠相表里，如肺实热，热邪壅肺，热伤津则大便必燥结；肺虚寒则大便必溏稀。因此医治泄泻病时应对肺之寒、热、虚、实进行辨证，亦可专治肺而不治肠，待肺病去，则大便自正常，即此理也。

第八章 肠 虚 不 固

大肠的功能主要是传导，与肺相表里。它将小肠消化吸收后传导下来的糟粕中的水分吸收，使之形成粪便。脾、胃、肠等脏腑共同完成食物在人体内消化、吸收、排泄的全过程，最后经肛门排出体外。如肠虚不固，腹痛肠鸣，喜按喜暖，四肢不温，神疲乏力，大便溏稀，日泻二、三次或四、五次不等，脉细无力，舌淡苔白，泄泻日久不愈，乃大肠虚弱，气不能固摄所致。宜用真人养脏汤加减治之。方用人参、白术、当归、白芍、肉桂、肉豆蔻、诃子肉、木香、生黄芪、姜炭、吴茱萸、扁豆、甘草等，补虚温中，涩肠固脱。

真人养脏汤

党参 白术 肉豆蔻 肉桂 诃子肉 米壳 白芍 当归
木香 炙甘草

方解：此方是《宋·太平惠民和剂局方》立方。主治泻痢日久，脾虚肾寒，肠失固摄之症。功能补虚温中，涩肠固脱。方中党参、白术益气补脾；诃子肉、米壳涩肠固脱；肉豆蔻、肉桂温脾止泻；木香调气舒脾，使补涩之药不致发滞；当归、白芍和血

养营；炙甘草益气和中，调和诸药。合用能温中涩肠，可养已伤之脏气，故曰“养脏”。

典型病例

张××，女，30岁，崇文区财政局职员，1977年10月19日就诊。

病史：患慢性肠炎已两年余，经常腹痛，大便时好时坏，日泻3~4次，脉沉细、舌淡，苔白滑。

辨证：大肠虚弱之久泻证。

治法：以补虚温中，涩肠止泻之法。

处方：

党参10克 诃子肉10克 扁豆10克 乌梅炭10克
白术10克 木香5克 肉豆蔻5克 官桂10克
姜炭10克 当归10克 吴茱萸10克 炙甘草5克
连续服用26剂。痊愈。

按：本章与第七章大肠虚寒证之病因相同，但其特点乃泄泻日久，大肠功能减低，水液吸收减少，肛门固摄失司，因此治疗此证以补虚涩肠，温中养脏为主。

第九章 脱 肛

直肠脱垂，俗称脱肛。初期排便完毕，可以自行还纳；逐渐必须用手托回；病情增重不仅在排便时脱出，在腹压增加的任何情况下，如咳嗽、打喷嚏、用力、走路等随时都可以使直肠脱出。脱出的直肠因受外界刺激而充血，水肿，甚至磨破溃疡而出血，以致复回困难。此症多因中气下陷所致。凡老人气血已衰，小儿气血未壮以及久泻用力太过，因之大肠脱出。肺与大肠相表里，肺虚气弱则脱肛。治宜大补气血，升提涩脱之法，用十全大补汤加减。方用人参、熟地黄、生黄芪、白术、当归、肉桂、白芍、川芎、茯苓、炙甘草、升麻、柴胡。另外每次大便后应用温水洗净，将五倍子面放在干净布上，敷在肛门头，将肛门纳入体内。

十全大补汤

党参 白术 茯苓 当归 熟地黄 川芎 白芍 黄芪
肉桂 生姜 大枣 炙甘草

方解：此方是金·李东垣立方，载于《医学发明》中，主治由于大病后失调，或失血过多，气随血去，气血两虚，偏于阳虚有寒者。方中用黄芪、党参、白术、茯苓、炙甘草益气建中；用当归、熟地黄、川芎、白芍补益营血；以肉桂助阳；以生姜、大枣调和营卫；使气血互相生长，是大补气血兼补阳的良方。

典型病例

史××，男，78岁，崇文区中二条19号，1975年3月15日就诊。

症状：大便以后直肠自肛门脱出，不能自回，已有四个月之久。患者年老体弱气虚。脉沉细、舌淡，苔白。

辨证：肺气虚损，直肠脱垂症。

治法：益气补肺，升提固脱之法。

处方：

党参10克 熟地黄10克 川芎5克 生黄芪15克
当归10克 白芍10克 白术10克 肉桂5克
升麻2克 柴胡3克 炙甘草5克 大枣5枚

经过两个月治疗，连服30剂，基本痊愈。嘱继服补中益气丸三个月，完全痊愈。

按：脱肛之症多因中气下陷所致。凡老人气血已衰，小儿气血未壮，产妇临产用力太过，久痢患者，均可产生脱肛。肺与大肠相表里，肺热则肛闭，肺虚则肛脱。治法宜用升补，不宜用降气之药。脱肛有虚热，肛门红肿疼痛者，补中益气汤内可加槐花、槐角、黄连，并以朴硝煎汤薰洗；肿痛甚者，熊胆磨水涂敷之。

第六篇 肾 虚 论

《素问·六节藏象论》曰：“肾者主蛰。封藏之本，精之处也。其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。”《素问·阴阳应象大论》曰：“北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝。肾主耳，其在天为寒，在地为水，在体为骨，在藏为肾……在志为恐，恐伤肾。”

古代医家认为“肾为先天之本，脾为后天之源。”说明肾在人体中的重要性。肾有肾阳和肾阴之分。肾阳者即命门火也，肾阴者即肾水也；有水无火，水安能气化？而肾虚又分肾阳虚、肾阴虚、肾阴阳两虚以及肝肾两虚等症。

此病多因年老或大病、久病、产后以及房劳过度等，所致肾经虚损，出现腰疼、肢软、梦遗滑精、阳痿早泄、下痿等症。

根据近年中西医工作者临床总结，认为一部分神经衰弱主要是由于肾虚所造成。即内抑制能力减低的结果。大脑皮层内抑制能力强时，能对过于兴奋的事物和感觉都有控制能力。反之，当内抑制能力减弱到不能控制大脑产生的兴奋灶时，则出现易怒、易悲、思想狭隘、想入非非、遇事不冷静等兴奋过于增强的表现。这种兴奋灶的增强，常常是中医所说的肝旺、心火妄动等。这是脏与脏之间失衡的现象，也就是神经衰弱病的兴奋衰弱型。在中医则定为肝热肾虚型和心肾不交型。古代医家认为“心无虚，肾无实”，是有道理的。也就是说，肾经在神经方面专司“抑制”功能，因此，肾经常常处在疲劳虚惫的状态中。古代医家谈到虚证时，多数是指肾虚而言，而这些病，多数有全身症状，如头晕、耳鸣、腰疼、肢倦、心跳、气短、失眠、多梦、阳痿、早泄、梦遗、滑精等一系列神经症状，这就是肾阴虚的表现。但肾脏本身在泌尿过程中发生障碍时，而出现下肢浮肿的慢性肾炎、尿毒症以及浮肿病等，则又属于肾阳虚的范畴。

肾与各脏之关系：肾又分命门火与肾水，由于肾水不足不能涵养肝木，可导致肝阳亢盛；水不上升不能与心火相济表现为心肾不交；肾阴不足导致肺阴不足，反之肺阴不足也能导致肾阴不足。致于命门相火的虚衰在人体更为重要。火不生土可使脾阳不足；土不制水可出现水肿；如伴有呕吐、恶心、食欲不振时，乃为水反侮土；命门火衰，阴寒内盛，可出现厥逆。真元下竭，阳上浮可导致阳脱。因此肾经的充实，才能保持人体各脏的平衡，避免失调。它在维护人体健康方面起着极为重要的作用。（见图 9）

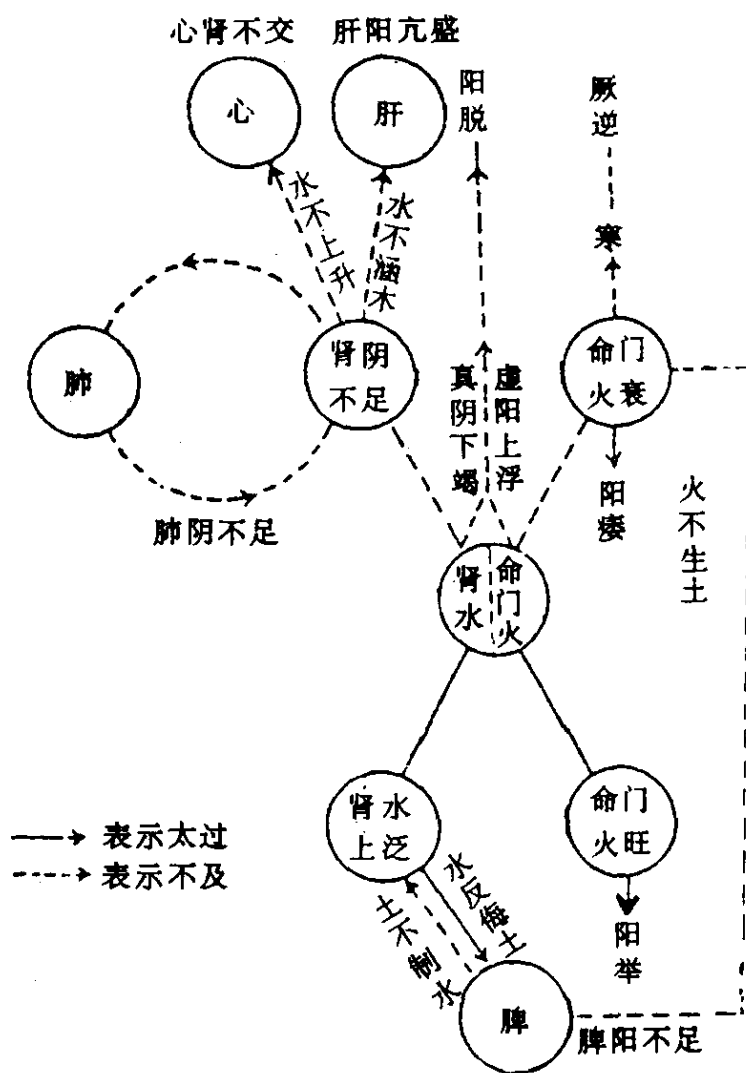


图 9 肾病机理示意图

按：中医认为肾为先天之本，主生长、发育和衰老的全过程。衰老与肾虚有着密切的关系。按照西医生理病理推断，肾阴、肾阳与植物神经系统的交感神经和副交感神经系统同为既对立又统一的两方面，它们都有调整和控制机体各个器官组织的功能。例

如肾阴虚临床可见五心烦热，口干咽燥，便秘，舌红，脉细数等症状，这与交感神经的活动偏亢相似，而肾阳虚出现的畏寒肢冷，便溏，脉迟缓等症状，又和副交感神经机能偏亢或交感神经机能减退相似。

第一章 肾 阳 虚

此病多因年老体弱，大病之后，或慢性肾炎、糖尿病等长期肾病在身，因而导致肾阳虚损，不能温暖下焦。故症见腰膝酸软，腹以下有冷感。下肢软弱，虚喘，耳鸣，梦遗滑精、阳痿早泄，溺后余沥，小便频数；肾阳为调节水液之动力，肾阳不足，甚则不能制水，阳不能化气行水，而出现水肿、足肿、小腿肿、大腿肿，蔓延至少腹、睾丸水肿。此为肾阳不足，不能化水所致，必须用温补肾阳之药，用金匱肾气丸加减。方用：熟地黄、淮山药、茯苓、泽泻、肉桂、附片。有水肿者加牛膝、车前子，名为济生肾气丸也。

金匱肾气丸

熟地黄 山药 山茱萸 泽泻 丹皮 炮附子 桂枝 茯苓

方解：此方是汉·张仲景方，载于《金匱要略》中。主治肾阳不足，以及消渴等证。肾主水，肾阳为调节水液之枢机。肾阳不足，不能化水，则小便不利，甚则水肿；如不能固摄水液，则小便反多，或失禁，故治法以温补肾阳为主。张景岳曰：“故善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助，而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升，而泉源不竭。”所以补阳之中，多兼补阴，同时补阳之药每多辛燥，易伤肾阴。因此必须阴阳兼顾，即甘温补肾阳之药与甘润补肾阴之药同用，方能阴阳相互为用。方中以附子、桂枝温补肾阳，为主药；以六味地黄丸滋补肾阴，为辅佐药。诸药合用，使阴阳协调，肾气充足，虚损可除，腰痛可止。

典型病例

林××，男，54岁，永外收购站工人，1972年3月11日就诊。

主诉：患慢性肾炎已一年多，腰酸痛，下肢浮肿，时好时犯，时轻时重。

检查：尿蛋白（++++），红细胞3~5个，有颗粒管型，血压135/85毫米汞柱（18.0/11.3千帕），脉沉缓，舌淡苔白。

诊断：慢性肾炎，阳虚型。

辨证：水为至阴，其本在肾。肾阳虚，则水不能化，溢而为肿，宜补火壮肾，治其本；利水消肿，治其标，标本并施。

处方：

熟地黄10克 附片10克 肉桂5克 山茱萸10克
山药10克 茯苓10克 白术10克 牛膝10克
党参10克 泽泻5克 川断10克 桑寄生10克

上药连服30剂，管型消失，尿蛋白（±），红细胞1~3个。嘱服金匱肾气丸3个月，复查尿阴性，彻底痊愈。随访3年未见复发。

按：肾阳者命门火也。是人身热能的源泉，一切生理活动的动力。肾阳虚即人身热能不足，各脏腑正常生理活动皆低下。同时，肾阳可温煦水液而化为气，对水液的排出起调节作用。肾阳虚也就是对水液的代谢将会失常。临床病人出现全身性水肿，同时可出现血尿、蛋白尿、管型以及尿比重失常等，甚至贫血。

治疗慢性肾炎应以补肾利水之法，首选方剂金匱肾气丸为主，可随证加减。如血中非蛋白氮不高而有浮肿者，可多食母鸡、花生、黄豆等高蛋白饮食补充蛋白质；如血中非蛋白氮高而有浮肿者，应忌高蛋白饮食。临证不可不知。

第二章 肾 阴 虚

此证多因大病、久病伤肾，或房事不节，或热病耗伤津血，或过服温燥劫阴之药，以致肾阴受损，虚则生内热。因之五心烦热，

虚烦不眠，夜梦惊恐，阴虚阳动，津液外泄而为盗汗。“肾主骨，腰为肾之府”。肾虚则腰酸腿软，相火妄动而遗精，面色憔悴，舌红咽干，脉细数，此为阴虚火亢之相。用育阴清热之剂。六味地黄汤、黄连阿胶汤加减合用。方用生地黄、熟地黄、丹皮、泽泻、山药、茯苓、山茱萸、黄连、阿胶、枸杞子、鸡子黄、夜交藤、煅牡蛎等。壮水之主，以制阳光。

六味地黄汤（丸）

方解：见第二篇心虚论第七章“中风”中。

黄连阿胶汤

黄连 白芍 阿胶 鸡子黄 黄芩

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《伤寒论》中。主治血少火旺，心烦难寐。方中以黄芩、黄连之苦寒而清气血之热；以阿胶之甘温滋补营血；白芍之酸收以交阴阳，白芍与黄连合用有酸苦涌泄之效；阿胶与黄连合用滋补而不膩；黄芩、黄连得阿胶、鸡子黄能清热而不燥，乃清热滋液之良方，最为完备。

典型病例

朱××，男，39岁，北京模具厂工人，1969年3月7日就诊。

主诉：半年来有时头晕，烦躁不安，手足心热，夜寐不眠，盗汗。

检查：面色晄白，两颧微红，脉细数，舌红。

辨证：阴虚生内热，水不能制火，虚火必旺，以致神不内守。

治法：以滋补肾水，降火安神之法。

处方：

熟地黄 10克 龟板 10克 煅牡蛎 20克 丹皮 10克
枸杞子 10克 黄柏 5克 山茱萸 10克 茯苓 10克
浮小麦 30克 知母 10克 煅龙骨 20克 泽泻 5克

经过两个月治疗，共服药 40 余剂，症状消失，痊愈。

按：阴与阳应保持相对的平衡与稳定。阴阳互相对立，又相互依存。阴虚阳必盛，阴阳失去平衡，于是出现低热，五心烦热，盗汗等症。对于阴虚低热诸症，避用苦寒之药；更忌用发汗之药。应以滋补肾阴之法，首选方剂为六味地黄丸，黄连阿胶汤或大补

阴丸。三方加减合用，不治热则热自退矣，所谓壮水之主，以制阳光也。依此施治，屡用屡验。

第三章 消 渴 病

一、上 消

上消即肺消也。消之属上焦者，有寒热之别。《素问·气厥论》曰：“心移寒于肺，肺消，消者饮一溲二，死不治。”肺主气，能调节水液，蒸发如雾，皆赖心火之温煦。若心火不足，不能温肺，而反移之以寒，则肺气枯索，是以饮一溲二也。心火不足已成危绝之证，故死不治。

《素问·气厥论》曰：“心移热于肺，传为鬲消。”属于热者多见舌上赤裂，咽如火烧，口大渴，急思饮，食量减少，大便如常，小便消利。由于肺喜润恶燥，心复以热移之，则炽灼愈燥。因而鬲上焦烦，饮水自救，饮多而易消也。此证属热渴者居多，此热乃虚热也。宜用门冬饮、玉女煎加减。方用太子参、知母、麦门冬、玉竹、石斛、元参、生地黄、葛根、生石膏、沙参、枇杷叶、牛膝、甘草、竹叶等。以清肺降火，生津止渴。

门冬饮

麦门冬 五味子 茯神 生地黄 人参 天花粉 葛根
知母 甘草 竹叶

方解：本方是金·刘完素所拟，载于《宣明论方》中。主治胃有虚热，津液不足，虚火上炎所致之肺消证。方中用麦门冬清胃中虚热而生津，为主药；辅以人参、甘草益胃气而生胃津，胃阴充足则津液自能上输于肺，使肺得所养；生地黄滋阴补肾，清热养阴；石斛、五味子滋补阴液而除虚热；生石膏、知母清热泻火，生津止渴；葛根升发脾胃清阳之气；天花粉生津解渴，泻火润燥；茯神开心益智，生津止渴；竹叶清热降火，止渴除烦。诸药合用，有清虚热，除烦渴，生津液，治消渴之功效，为治疗肺消之良方。

玉女煎

生石膏 知母 麦门冬 熟地黄 牛膝

方解：此方是明·张景岳撰拟，载于《景岳全书》中。为治疗阴虚胃热，烦热口渴之良方。烦热为胃火有余，口渴为阴津不足。方中用生石膏、知母清热降火，生津止渴；用麦门冬、熟地黄以养阴滋液，补肾润燥，用牛膝导热引血下行，以降上炎之火。此方为清火与滋阴并用；以清火为主，以滋阴为辅。两种药合用，是清火而又壮水之有效佳方。

典型病例

贾××，女，28岁，器件二厂工人，1970年8月1日就诊。

主诉：半年来咽干灼热如焚，口渴引饮，易饥，食量增加，月经先期。

检查：脉弦数，舌赤裂。查尿糖定性（—），血糖定量95毫克%。

辨证：肺胃郁热，津阴虚损，上消病。

治法：以清肺养阴，生津止渴之法。

处方：

生石膏 30克 知母 10克 沙参 10克 麦门冬 10克
黄芩 10克 元参 10克 天花粉 10克 葛根 10克
石斛 10克 生地黄 20克 甘草 5克 竹叶 10克

连续服用15剂，食量减少至正常，口渴大减，继服养阴清肺膏，六味地黄丸。观察二个月，病情稳定。痊愈。

二、中 消

消之属于中焦者。《灵枢·经脉篇》曰：“胃足阳明之脉，气盛则身以前皆热，其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄。”《金匱·消渴小便不利淋病脉证篇》曰：“趺阳脉数，胃中有热，即消谷引食，大便必坚，小便即数。”此证由于阳盛阴衰，脾胃蕴热所致。临床多见口渴而饮水不绝，善饥而瘦，其症在胃，其根在肾。治以清热养阴益肾之法。宜用竹叶石膏汤、玉泉丸加减治之。方用生石膏、玉竹、知母、麦门冬、天花粉、葛根、石斛、乌梅、茯

苓、生黄芪、党参、泽兰叶、熟地黄、生甘草、竹叶等。

竹叶石膏汤

竹叶 生石膏 清半夏 粳米 人参 麦门冬 甘草

方解：此方是汉·张仲景所拟，载于《伤寒论》中。本方即白虎汤去知母。加竹叶、人参、麦门冬所组成。主治热病后期气阴已伤，以及胃火灼热，胃津耗伤，口渴引饮，寓清于补。方中以人参、麦门冬、粳米、甘草益气养阴，生津止渴；又以生石膏清阳明之热；以竹叶泻上焦之烦热；以半夏降逆止呕。仲景之法清中有补，寓补于清，方简意深，为治疗胃热之良方。

玉泉丸

天花粉 人参 茯苓 乌梅 麦门冬 葛根 黄芪 甘草

方解：本方是清·沈金鳌所拟，载于《沈氏尊生》中。主治消渴病之中消者，能清胃中之虚热，生胃中之阴津，有益气止渴之功用。方中用人参、黄芪、茯苓、甘草益气健脾；葛根升阳益胃生津止渴；麦门冬清虚热而生胃津；乌梅生津止渴；天花粉酸能生津，甘不伤胃，有降火解渴之作用。诸药合成，对于胃热之中消症，有清热滋润，生津止渴之功效，为医治消渴病之良方。

典型病例

张××，女，47岁，三里河35号家庭妇女，1973年5月5日就诊。

主诉：口干口渴，思饮，每日大量饮水。

检查：尿糖定性（++++）。血糖定量285毫克%。脉沉细，舌淡苔薄白。

诊断：消渴病（糖尿病）

辨证：肝肾虚惫，胃阴耗竭，引水自救。

治法：以补气益肾，生津止渴之法。

处方：

生黄芪10克 枸杞子10克 生地黄10克 太子参10克
旱莲草10克 石斛10克 麦门冬10克 女贞子10克
元参10克 天花粉10克 何首乌10克 甘草5克

经过一年治疗，共服药300付，病情好转；尿糖定性空腹时

为阴性，食后仍有少量糖排出，又继服玉泉丸以图巩固。

三、下 消

下消者乃病在下焦，亦称肾消。证见：尿如膏油，而色黧黑，形削肢瘦，精神疲惫，烦躁引饮，小便频多，日夜无度，饮一溲二，此乃真阳不足，火亏于下，肾气不固，摄纳无权所致，治宜温补命门之火。以桂附地黄汤、缩泉丸加减。方用党参、生黄芪、肉桂、附片、巴戟天、肉苁蓉、益智仁、沙苑子、金樱子、熟地黄、山茱萸、茯苓、五味子等。

桂附地黄汤

方解：见第五篇肺虚论第六章“肺虚喘”中。

缩泉丸

益智仁 乌药

方解：本方为宋·陈自明立方，载于《妇人大全良方》中。主治由于肾虚不摄所引起的小便频数，遗尿，或遗精；方中以益智仁补命门之不足，固涩精气，缩小便；乌药辛温香窜，下通肾经，温散膀胱冷气，能治小便频数。二药合用，有温肾祛寒，固涩小便之功，为止遗涩精之良方。

按：此证有虚实之分，临床应认真辨证，本方适用于肾亏下元虚损，不能固摄者；如膀胱湿热，小便涩滞，尿频尿痛，则仍应用清热利尿之药，治法各异，实应审慎辨之。

典型病例

关××，男，70岁，退休京剧演员，1975年3月5日就诊。

主诉：近数月来口干渴，善饮多食，小便频数，日夜无度，饮一溲二，显著消瘦，体重下降，腰酸腿软，四肢冷感，精神疲倦而嗜睡。

检查：尿常规（一） 尿糖定性（一） 脉弦细而迟，舌淡苔白。

诊断：下消证。

辨证：肾阳不足，不能温暖下焦；肾气虚惫，不能固摄水液，以致小便频数，成为下消证。

治法：以温补肾阳，益气固摄之法。

处方：

党参10克 熟地黄10克 沙苑子10克 附片5克
山茱萸10克 菟丝子10克 杜仲10克 益智仁10克
枸杞子10克 肉桂5克 巴戟天10克 桑寄生10克

经过半年治疗，共服药120剂，小便频多基本控制，口渴大减，精神恢复，嘱继服桂附地黄丸三个月，痊愈。

按：消渴病分上、中、下三消。清·程钟龄《医学心悟》曰：“渴而多饮为上消，消谷善饥为中消，渴而小便如膏者为下消。”三消之病其标有三，其本则一，即肾也。因此，补肾是治疗消渴病之基本大法。但应辨别为肾阴虚抑肾阳虚？阴虚之消宜补水；阳虚之消宜补火。临床观察：在消渴病患者的尿中，并不完全含糖，血糖含量也不高。因此说消渴病不完全是糖尿病。

《金匱要略》曰：“趺阳脉浮而数，浮即为气，数即消谷而大坚，气盛则溲数，溲数即坚，坚数相搏，即为消渴。”又曰：“趺阳脉数，胃中有热，即消谷引食，大便必坚，小便则数。”张仲景以趺阳脉数，表示胃中热，热则消谷多食，气虚重则溲数，溲数则水液损失，水液损失则大便干燥。消渴病一切症状的发生都基源于热。所谓胃热者，即指由某种原因引起机能的亢进。如，植物神经功能紊乱等。即《内经》所说“亢则害”的意思。症状中脉数，心动过速、多饮、多食、多尿、消瘦等，都表示基础代谢率的增高，消耗过甚；因此，对这种热有的不应当认为是实热，而应视为虚热，愈虚则愈热，愈热则愈虚。喻嘉言曰：“上消渴之病，始于胃而极于肺肾。”说明此病初见胃热烦渴，尚能引饮自救，继则上灼肺津，下劫肾液，乃至脏腑肌肤俱形枯槁；也就是说，消渴病完全由于代谢过盛，乃至病情加重，转变为险象。临床不可不慎。

第四章 不寐证

不寐病与现代医学的神经衰弱相类似，以失眠为主，并伴有头晕，头痛，心跳，气短，乏力等症状。这种病多发生在青年人或中年人身上，是临床常见病之一。

神经衰弱病，顾名思义属于虚证，一般多与肾经有关，在本篇序论中已经论述到是由于肾虚造成的病理机制。从临床经验中，也认识到此病与本人性格，幼年教养，家庭情况，学校生活，社会生活，职业生活，婚姻状况，工作状况有着密切关系。所以治疗时应从病人精神、生活和情绪等方面着手，以改善病人对客观的认识，排除病因，使病人精神愉快，为治疗此病的重要方法。

从中医分型来看，其中以肾虚肝热，肾阴不足和肾阳不足者为多，肝胆郁热型、肝血不和型、心脾不足型者较少，因此一并在本篇介绍。

兹将中医分型及治疗方法，分述如下：

一、肝胆郁热型

暴怒伤肝，肝火炽盛上攻头脑，形成肝阳上冲，胆气上溢。肝藏血，血液流行全赖气之引导。今其气逆，肝火犯于上，气必失衡，肝胆相表里，肝风内忤，表里俱热，证属实热。

临床症状：经常出现头晕目眩，伴有剧烈头痛或偏头痛，或目系抽痛，或痛时不能转侧和侧视，或为颜面痛、牙痛等。发作次数不定，可一天数次或好几天，坏几天，亦可周期性发作，在工作紧张忙乱的情况下，头痛发作越为频繁，因而引起患者精神紧张，情绪焦虑，同时伴有恶心口苦，急躁心悸，失眠，多为入睡难。

根据病因症状，此型属于肝胆实热之象，治宜镇肝清热之法。用龙胆泻肝丸加减治之。

此型属于实热之症，用清泻镇静之药见效较快，疗程也短。此种类型临床所见不多，当郁热清泻以后，症状消失，病即痊愈。

龙胆泻肝丸

龙胆草 黄 芩 梔 子 泽 泻 木 通 车前子
生甘草 当 归 生地黄 柴 胡

方解：此方为清代汪讵庵所拟，载于《医方集解》中。主治肝胆实火上扰，症见头痛，头晕，肋痛口苦，耳目作痛等症。方用龙胆草大苦大寒，上清肝胆实火，下泻下焦湿热，为主药；梔子、黄芩具有苦寒泻火之功为辅药；泽泻，木通，车前子清热利湿，使湿热从水道排除；肝热易伤阴血，用生地、当归、养血滋阴；柴胡引诸药入肝胆；甘草调和诸药。

典型病例

周×× 男 28岁 职员 1978年4月8日就诊。

主诉：近一个月来，头晕、头痛、心烦、易怒、口苦恶心、失眠不易入睡。

检查：脉弦数，舌苔黄。

辨证：肝胆郁热。

治法：清热平肝、泻火安神之法。

处方：

龙胆草 10克 黄柏 10克 勾 藤 10克 茯 苓 20克
生地黄 20克 白芍 12克 梔 子 10克 泽 泻 10克
当 归 10克 柴胡 5克 生龙骨 20克 生牡蛎 20克

连服一个月，头晕痛消失，心烦去，精神好转已能眠，嘱常服龙胆泻肝丸，知柏地黄丸以巩固疗效。

二、肝热肾虚型

肝乃阴中之阳，必赖肾水之涵养，如肾水亏耗，必致浮阳上越，水不涵木。

凡情绪过度的抑郁，或过度紧张激动，均易动怒，所谓：肝火旺盛，触事即怒，也就是肝之志为怒的表现，此症属于虚中有实。

此型较为多见，临床症状多为情绪易于激动，敏感，急躁，言语粗暴，屑小之事即冲动，自觉头晕、头痛、耳鸣、心跳、胸闷，气短、多汗，激动时更为明显。头晕多于头痛，记忆力逐渐减退，

注意力不易集中，失眠表现多为入睡难，有时整夜不眠。脉弦数，或弦缓无力。有时血压亦可偏高。

根据病因症状，此种类型属于上实下虚，治宜清上实下，应以清热平肝，滋阴降火之法，用杞菊地黄丸。如果肝热较甚可上午服用龙胆泻肝丸，晚间服用六味地黄丸。

龙胆泻肝丸

方解：见本篇第一章“不寐证”中。

六味地黄丸

方解：见第二篇心虚论第七章“中风”中。

杞菊地黄丸

方解：见第三篇肝虚篇第五章“水不涵木浮阳上越”中
典型病例

黄××，男，36岁，模具厂工人，1962年12月5日就诊。

主诉：经常头晕头痛，烦躁易怒，记忆力减退，失眠已有半年之久。查：左脉关弦，右脉尺弱，舌红苔微黄。

辨证：肾阴不足，不能养肝，肝火炽盛，易怒不眠。经神经科诊断为神经衰弱病之兴奋衰弱型。

治法：以清热平肝，益肾滋阴之法。

处方：

生地黄 10克 元 参 10克 枸杞子 10克 丹 皮 10克
泽 泻 10克 菊 花 10克 山萸肉 10克 茯 苓 10克
女贞子 10克 石决明 30克 白 芍 10克 甘 草 5克

治疗3个月，服药50剂，症状消失，痊愈。嘱经常服用六味地黄丸，以巩固疗效。

三、肝血不和型

肝喜条达，肝气抑郁不舒，肝火内生，久之肝血受燔，肝血暗损，血虚肝失濡养。肝主筋，赖血以养，血虚筋不得荣养，手颤筋惕，此症属于血虚气实，即虚中有实之证，常见于妇女。

临床症状为经常出现头晕和耳鸣，耳聋，心悸，气短，有寒热往来，或劳热现象，其热按之在肌肉之下，骨节之上，每日寅

卯时尤甚，妇女多在经期前后病情增重，月经紊乱，赤白带下，情绪不好时全身或一部分肌肉筋惕，情绪不稳时常低落，易悲观失望，遇事伤感，对周围事物过度敏感，过分注意生活小节，好猜忌多疑，甚则想入非非。

根据病因和症状此型由于营血虚热造成肝血不和。治宜清虚热，和肝血之法，用逍遥散加减。

肝热肾虚型和肝血不和型较为难治，此两型既有实，又有虚，虚中有实，实中有虚，即容易兴奋，也容易疲惫。症状变化多端，辨证较难，容易混淆，而在治疗上也不易收效。尤以肝血不和型辨证来分析，既属于虚证，但虚不受补，必须用养血滋阴，调气和肝之药随症施治方能奏效。

逍遥散

柴胡 当归 白芍 白术 茯苓 煨姜 薄荷 炙甘草

方解：此方是宋·《太平惠民和剂局方》撰立。主治由于肝郁血虚，肝血不和所致，头痛眩晕，咽干口燥，寒热往来，疲倦食少，怔忡不宁，失眠多梦等症。血虚则见头痛眩晕，肝郁则寒热往来。肝郁不能疏泄脾土，以致脾失健运，故症见疲乏食少。同时脾虚失运，又不能化生营血以养肝，导致肝血愈虚。本方以舒肝为主，并且养营血而健脾土，以达到养肝补脾的目的。方中以柴胡疏肝解郁为主药；用当归、白芍补血和营以养肝阴为辅药；以茯苓、白术、甘草补中健脾；煨姜和中，与当归、白芍同用并能调和气血；以薄荷增强柴胡疏肝解郁的作用。诸药合用，成为舒肝理脾，和营养血之良方。

典型病例

钱××，女，29岁，一〇九中教员，1962年9月1日就诊。

主诉：经常头晕，耳鸣，心悸气短，时冷时热，烦躁失眠，月经不调。查：脉细微数，舌红少苔。

辨证：血有虚热以致肝血不和，造成心、肝、肾之失调，累及冲任致使月经不调。神经科诊断为神经衰弱病之兴奋衰弱型。

治法：以调肝和血为主要治法。

处方：

柴 胡 5 克 薄荷 3 克 栀子 3 克 当归 10 克
白 术 10 克 香附 10 克 青皮 3 克 白芍 15 克
生地黄 10 克 川芎 5 克 甘草 5 克

经过两个月治疗，共服药 50 剂，症状消失而痊愈。

四、肾阴不足型

肾阴从广义讲包括有肾水、肾精与津液，在某些条件下津液亏耗后形成肾阴相对的不足，命门火炽。《内经》云：“精藏于肾而主于心，精生于气而役于神。神动于中，精驰于下”。则出现肾阴虚弱。此型男子较多。

其主要症状为头晕，耳鸣，咽干，口渴等阴虚液少之象。有时下午低烧，男子梦遗滑精，常因恐惧遗精而不敢入睡，睡则多梦，夜间盗汗，日间精神不振，口干引饮，头昏眼花，记忆力减退，精神不集中，腰酸腿痛，体倦乏力。脉沉细或细数无力，舌红无苔。

此型属于肾水不足，应用滋阴补肾，益水固精之法，用六味地黄丸、锁阳固精丸等药治之。

六味地黄丸

方解：见第二篇心虚论第七章“中风”中。

金锁固精丸

沙苑子 芡实 莲须 龙骨 牡蛎

方解：此方为清·汪切庵立方，载于《医方集解》中。主治精关不固，遗精滑泄，腰酸耳鸣，四肢无力等症。方中用沙苑子补肾益精为主药；莲须，芡实固肾涩精；龙骨，牡蛎潜阳涩精。诸药合用，成为专治遗精，滑精，精关不固之良方，有固肾涩精之功用。

典型病例

刘××，男，31岁，26中学教员，1970年4月4日就诊。

主诉：头晕耳鸣，咽干口渴，惊惧失眠，梦遗滑精，记忆力减退，查：脉沉数，舌红少苔。

辨证：肾阴不足，肾经虚弱以致心肾不足，精关不固，经神

经科检查为神经衰弱病之抑制型。

治法：益肾补阴，安神固精之法。

处方：

熟地黄 10 克 淮山药 10 克 芡实 10 克 丹皮 10 克
泽泻 5 克 女贞子 10 克 元参 10 克 煅龙骨 30 克
煅牡蛎 30 克 莲子心 3 克 柏子仁 10 克 甘草 5 克

经过两个月治疗，服药 40 剂，症状消失，痊愈。嘱经常服用六味地黄丸，以巩固疗效。

五、肾阳不足型

肾阳者乃人身命门真火之所在，生命之根本。心火为君火，肾火为相火，乃脏腑之化源。《景岳全书》曰：“心赖之则君火以明，肺赖之则治节以行，脾胃赖之则仓廩富而运化行，肝胆赖之则资谋虑之本，膀胱赖之则三焦气化，大小肠赖之则传导乃分。”因此肾阳不足，命门火衰，为水病及子，肝肾俱伤，危害全身而成衰弱现象。

其主要症状为头目昏沉，记忆力衰退，精神萎靡不振，表现体力衰弱现象，工作能力减低，倦怠无力，不能坚持日常工作，心跳缓慢，气短乏力，对外界事物不感兴趣，嗜睡，在任何情况下都能睡，但睡不深，有时偶然失眠，表现呆板，言语迟缓，腰酸腿痛，四肢无力，自汗、盗汗，肢冷，食欲不振，男子性欲减退，阳萎早泄，女子闭经。脉沉细弱无力，舌淡。

此证属于命门火衰，元阳不足之虚象，治宜益气壮火，温暖元阳之法。用参茸卫生丸、桂附地黄丸等药治之。

桂附地黄丸

方解：见第五篇肺虚论第六章“肺虚喘”中。

参茸卫生丸

人参 鹿茸 巴戟肉 党参 何首乌 白芍 苍术 黑附子
乳香 杜仲炭 熟地 香附 莲子肉 牡蛎 山萸肉 肉桂
远志 枸杞子 茯苓 复盆子 于术 没药 桑寄生 黄芪
龙眼肉 当归 红枣 肉苁蓉 琥珀 麦门冬 川断 生地

酸枣仁 沉香 广木香 陈皮 甘草 破故纸 山药 牛膝
砂仁 锁阳 白术 龙骨

方解：此方为明·林道飞立方，载于《济世良方》书中。主治气血不足，阴阳两虚所致身体虚弱，腰酸腿软，四肢无力，健忘失眠，头晕目眩，阴虚盗汗，须发早白，肾寒精冷，梦遗滑精等症。方中以人参、党参、白术、于术、苍术、莲子肉、山药、黄芪、茯苓、甘草、红枣益气健脾；鹿茸、附子、肉桂、锁阳、肉苁蓉、巴戟肉温暖元阳，以补命门之火；枸杞子、复盆子、生地黄、熟地黄、山萸肉、破故纸、杜仲、川续断、桑寄生、麦门冬、何首乌、牛膝补肾养肝，益精强阳；香附、砂仁、陈皮、木香、沉香理气开胃，调气和中；乳香、没药活血通滞；当归、白芍养血和阴；酸枣仁、远志、龙眼肉、琥珀补心宁神；龙骨、牡蛎益肾固精。诸药合成，能补阳益阴，气血双补。对年老久病，肾阳不足，命门火衰，所致之病均为有效。

典型病例

王××，男，44岁，女，15中教员，1962年10月4日就诊。

主诉：近一个月头目昏沉，气短乏力，记忆力减退，精神不振，晚间下肢浮肿，嗜睡。查：脉沉迟，舌淡苔白。

辨证：肾阳不足，命门火衰之症，神经科诊断为神经衰弱抑制型。

治法：以补肾助阳，益气强心之剂。

处方：

熟地黄 10克	淮山药 10克	枸杞子 10克	附片 5克
肉桂 5克	干姜 5克	山茱萸 10克	当归 10克
党参 10克	茯苓 10克	白芍 10克	甘草 5克

经过两个月治疗，服药45剂，症状消失，痊愈。嘱服桂附地黄丸，以巩固疗效。

六、心脾不足型

此型患者多因思虑疲劳过度。《灵枢·本神篇》曰：“心忧惕思虑则伤脾，脾忧愁不解则伤意。”又曰：“心生血，脾统血”。心

脾既伤则失其职。血虚则无华，而不红润。唇舌淡白，脾虚运化不健，饮食少思，脾主肌肉，则形体消瘦，脾主四肢，则体倦无力，心脾为生命之根，心脾气郁，郁则火生，久久不解，渐耗五阴，此型属于气血两虚不足之症。

患者精神不振，困倦无力，自觉容易疲劳，对日常工作感到吃力，记忆力差，经常头晕，间或头微痛，遇紧张事物甚至晕倒，四肢厥冷，面色晄白，手足汗出，嗜睡梦多，容易惊醒，自汗盗汗，心悸气短，手颤和阵发性手指痉挛，情绪不稳，精神紧张，有时口吃，口不应心，而不华泽呈贫血貌，（但血色素不低），妇女月经不调，脉沉弱，沉细或沉缓。

此型属于心脾虚弱不足之证，治宜益气健脾，养心宁神之法。用人参归脾丸、参苓白术丸、天王补心丹等药治之。

关于肾阴不足、肾阳不足与心脾不足三种类型，只要用补阴、补阳和补心脾之法来治疗，虽然疗程较长，但效果是稳步的，可靠的，治疗过程也是比较顺利。无特殊致病因素当可痊愈，远期疗效亦可以巩固。

人参归脾丸

方解：见第二篇心虚论第四章“心血虚”中。

参苓白术散

方解：见第四篇脾虚论第七章“脾虚久泻”中。

天王补心丹

方解：见第二篇心虚论第三章“心阴虚”中。

典型病例

张××，女，42岁，大石桥小学教员，1964年8月2日就诊。

主诉：经常头晕，心跳气短，自汗盗汗，记忆力减退，少食嗜睡，疲倦不能坚持工作，月经后期。查：脉沉细，舌淡苔白。

辨证：劳伤营血，以致心脾两虚。神经科诊断神经衰弱病之精神衰弱抑制型。

处方：

党参 10 克 黄芪 10 克 当归 10 克 白 术 10 克
白芍 10 克 陈皮 10 克 桂枝 10 克 熟地黄 10 克

菖蒲 10 克 远志 10 克 干姜 5 克 甘草 5 克

经过三个月治疗，共服药 70 剂，症状消失痊愈。嘱经常服用人参归脾丸，以巩固疗效。

按：祖国医学所论之不寐症，相当于现代医学之神经衰弱病及更年期综合征等。余治疗此症时，根据中医辨证论治的特点，认为此病有虚、有实。如气郁化火，扰动心神；阴虚火旺，心肾不交；思虑劳倦，内伤心脾，均可影响心神而致不寐。原因虽多，总与心脾肝肾及阴血不足有关。血之来源，是水谷之精微所化，上奉于心，则心得所养。受藏于肝，则肝体柔和；统摄于脾，则生化不息。气血调节有度，化而为精，内藏于肾，肾精上承于心，心气下交于肾，则神安志宁。若暴怒、思虑、忧郁、劳倦等，伤及诸脏，精血暗耗，必成顽固性的不寐症。可见不寐之症，属于虚者为多。

根据中医分型来看，除少数肝胆郁热型；大病久病，伤及心脾之心脾不足型；以及妇女更年期或室女阴阳违和的肝血不和型以外；其余肝热肾虚型、肾阴不足型均与肾经有关，其中以肾阴不足或由于肾阴不足所引起的肝热肾虚型临床较为多见。因此在治疗神经衰弱病多以补肾阴为主要治疗方法。但不可忽视其它类型之辨证。

第五章 肝肾虚损（下痿）

痿，属于肝肾不足也。此证乃骨痿不能立行，筋弱不能自收持，腰脊酸软，足膝痿弱不用，下肢寒凉痿软，逐渐加重。脉沉细，舌淡润。用虎潜丸、神龟滋阴丸加减。方用龟板、熟地黄、锁阳、淫羊藿、枸杞子、肉苁蓉、牛膝、当归、白芍、灵仙。滋补肝肾，强壮筋骨，以利腰膝。

虎潜丸

龟板 盐黄柏 盐知母 牛膝 锁阳 白芍 当归身

虎胫骨 干姜 陈皮 熟地黄 羯羊肉

方解：此方是元·朱丹溪所拟。主治肾阴不足，筋骨痿软不能步履，下元虚冷，精血亏损之下痿症。方中用龟板益肾滋阴，强壮腰膝；虎骨健骨去风；羯羊益气血补虚劳；熟地黄滋补肝肾；牛膝益肝肾强筋骨；当归补血养营；白芍和肝血缓中止痛；锁阳治痿补阳；盐知母、盐黄柏补肾水泻虚火，能治诸痿；干姜通心助阳；陈皮理气燥湿，宣通五脏。诸药合用，对肾亏精枯，湿寒乘虚袭入之下痿证，此药可使足膝强壮，为治痿之良方。

神龟滋阴丸

龟板 黄柏 知母 枸杞子 五味子 锁阳 干姜

方解：此方为宋·李东垣所拟，载于《证治准绳》书中。为治疗下痿之良方。方中以枸杞子、滋补肝肾，生精助阳；锁阳补肾益精，润燥养筋；龟板益肾滋阴；五味子补虚滋水，益肾涩精；干姜祛寒逐冷，通心助阳；知母、黄柏补肾水，泻肾火医治痿瘫。诸药合成，能补肝肾之不足，滋阴润燥。乃治痿之良方。

典型病例

凌××，女，22岁，学生，1976年9月20日就诊。

主诉：一年前由于运动后，睡卧在地上感寒，三天后下肢随即瘫痪，经就医半年，现稍好转，仍不能直立行走，下肢痿软无力。

检查：脉沉细，面色晄白，两下肢软瘫，不能抬举，无力活动，有痛感。

辨证：肝肾不足，气血阻滞。

治法：温补肝肾，活血通络之法。

处方：

肉苁蓉 100克 桂枝 100克 熟地黄 100克 附片 100克
巴戟天 100克 当归 100克 淫羊藿 100克 干姜 100克
石楠藤 200克 乌蛇 50克 穿山龙 200克 党参 100克
功劳叶 100克 黄芪 100克 枸杞子 100克 灵仙 100克

共研细末，炼蜜为丸。每重九克，早晚各一丸。经过针灸配合治疗，服用上药三年，恢复自己行动，生活可以自理，基本痊愈。嘱经常服用健步虎潜丸。

按：痿证是指肢体筋脉迟缓，软弱无力，肌肉萎缩的一种疾病，临床以下肢痿软为主要症状，故有“痿躄”之称。有的下肢全部失去控制能力，名为“截瘫”。身半以下属阴，肾主之；肝肾同源，因之治疗此证应以滋补肝肾，益精填髓为主，首选方剂为虎潜丸，并佐以活血通络之药。此证为疑难大病，可导致终身残废，不可不慎。治疗此证应配合针灸、按摩等治疗方法，以帮助肢体的恢复。

第六章 肾虚内障眼

此证由于肾水虚损，引起瞳孔散大，视物不清，羞明流泪以及复视等症。此乃肾水不足所致。肾主瞳孔，肾虚则瞳孔散大；感光强则怕光；由于光的刺激所以经常流泪；或出现视物成为二体；此为血枯水弱之证。治宜大补肾水，荣养营血之法，用益阴肾气丸加减治之。方用熟地黄、生地黄、当归、丹皮、山茱萸、淮山药、泽泻、茯苓、柴胡、枸杞子、女贞子、旱莲草、菟蔚子等，补肾养血，益阴明目。

益阴肾气丸

熟地黄 泽泻 山茱萸 丹皮 朱砂 淮山药 当归尾
柴胡 茯苓

方解：本方是金·李东垣立方。主治肾水虚亏，营血不足所引起的瞳孔散大，视物不清，复视等内障眼病。方中用熟地黄益肾补血；当归尾行血；丹皮去积血；茯苓益气健中；泽泻利湿行水；生地黄滋补肾阴；五味子能补五脏；淮山药益肾和胃；山茱萸益精强阴而通九窍；柴胡引药入厥阴肝经；朱砂能通心窍。诸药合用，成为滋补肾水治疗内障眼的良方。

典型病例

金××，男，65岁，退休工人，1968年10月4日就诊。

主诉：近年来双目视物不清，怕光，爱流泪，有时视物为重影，眼科诊断为视神经萎缩复视病。

检查：年老体质衰弱，形削气弱，面色微黑黄，脉弦细，舌红苔薄白。

辨证：肾阴虚损。肾主瞳孔，目得血能视，今阴血不足则视物不明。

治法：以益肾滋阴，养血明目之法。

处方：

熟地黄 10 克 枸杞子 10 克 菊花 10 克 当归 10 克
黄精 10 克 女贞子 10 克 杜仲 10 克 川芎 5 克
茺蔚子 10 克 沙苑子 10 克 赤芍 10 克 炙甘草 5 克

经过两个月治疗，服药 50 剂，视力恢复，症状消失。嘱经常服用杞菊地黄丸调补，巩固疗效。

按：人之目能视，专赖瞳神，瞳神属于五轮中之水轮，肾主之。为整个眼睛之重要组成部份。瞳神虽小但其病机变化却很复杂，病势亦较其他四轮为重，也较难治。由于肾虚所引起的视物昏花不清，怕光流泪，以及复视等，均列为内障范围，瞳人既为肾所主，肾主水而藏精，肝肾同源，肝肾阴虚则精气不能上荣于目，目失所养，成为本证。应以益肾补血，滋阴明目之法治之。肾充血盈，目得所养无不奏效。

第七章 遗 尿

凡睡眠中自己不知不觉而尿自排出者，谓之遗尿；日间亦不能制约者，谓之尿失禁。《灵枢·九针篇》曰：“膀胱不约为遗尿”。《灵枢·本输篇》曰：“虚则遗溺，遗溺则补之”。此症多由中气不足，清气下陷，肾气虚惫所致。气虚则膀胱不能约束水道，故遗尿或尿失禁。可用大补中气之法，但必须加固涩精气之药。宜用保元汤、菟丝子散治之，使中气充沛，肾气固摄则尿自能约束之。

保元汤

黄芪 人参 肉桂 甘草

方解：此方是金·李东垣所拟，载于《脾胃论》中。功能调补营卫之气，大补真元之气。夫人身真元之气，藏于肾，得后天水谷精微之气汇合，畅通内外，周流一身，充满无间，如真气不足则体必虚。方中用黄芪保在外一切之气；甘草保在内一切之气；人参保上下内外一切之气；肉桂能充命门之动气，阳充气自足，于法甚为完备。

菟丝子散

菟丝子 牡蛎 五味子 附子 鸡内金 肉苁蓉

方解：本方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。主治由于肾阳虚亏所致尿多，尿频，以及尿失禁等证；方以菟丝子益精强阴；附子、肉苁蓉补命门之相火；五味子补肾涩精；鸡内金能治遗尿；牡蛎涩精止遗，诸药合用，成为温暖下元，固涩止遗之良剂。

典型病例

刘××，女，39岁，朝阳区龙爪树村农民，1962年10月6日就诊。

主诉：第三胎产后已一年余，经常小便失禁，夜间尤甚。

查：面色晄白，精神疲倦，两脉沉细，舌淡苔白。

辨证：中气不足，下元肾气不充，以致水道不能固摄。

治法：温肾祛寒、养气固涩之法。

处方：

益智仁 10克 党参 10克 生黄芪 10克 沙苑子 10克
桑螵蛸 10克 肉桂 3克 金樱子 10克 煅牡蛎 20克
熟地黄 10克 菟丝子 10克 炙甘草 5克 煅龙骨 20克
经过三个月治疗，共服药 60 剂，症状消失而痊愈。

按：遗尿或尿失禁之病，以多产妇，老人，小孩或大病之后为多，皆因中气不足，肾气虚惫所致，中医在临床中辨证施治无不奏效。若配合针灸疗法，则取效更捷。

第八章 水肿病（慢性肾炎）

祖国医学中虽无肾炎病一说，但早在二千年前，就有关于这种病症的记载，把它包括在水肿和肿胀病中。《灵枢·水胀篇》曰：“水始起也，目窠上微肿，如新卧起之状，右颈脉动，时咳，阴股间寒，足胫肿，腹乃大，其水已成矣，以手按其腹，随手而起，如裹水之状，此其候也。”《素问·阴阳别论》曰：“三阴结谓之水。”中医在病理方面早已知道水肿和肾脏的关系，同时，对水肿有精密的观察和明确的认识。如《金匱要略·水气篇》曰：“病有风水、皮水，有正水，有石水，有黄汗。”其中以风水、皮水似与急慢性肾炎的浮肿有关。《素问·水热穴论》曰：“肾者，牡脏也，地气上者属于肾，而生水液也，故曰至阴。”

中医对慢性肾炎可分为四型：

一、脾气虚型：两下肢浮肿，体沉肢重，困倦乏力，脘闷腹胀便溏，食欲不振，面色黄浮，舌质淡，苔白腻，脉沉缓或濡。宜用茯苓、白术、猪苓、泽泻、桂枝、姜皮、厚朴、陈皮、黄芪等药，健脾益气，化湿利水。

二、脾肾阳虚型：面目浮肿，面色晄白无华，下肢及全身浮肿，纳呆，畏寒肢冷，腰膝酸软无力，舌质淡胖，边有齿痕，脉沉迟。宜用黄芪、吴萸、厚朴、木瓜、肉桂、茯苓、姜炭、薏苡仁、白术、陈皮、肉苁蓉、巴戟等药，温补脾肾。

三、肝肾阴虚型：头晕目眩，心烦失眠，手足心热，咽喉干痛，小便黄或黄赤，舌质红，少苔或薄黄苔，脉弦细或微数，宜用生地、白芍、枸杞子、丹皮、泽泻、吴茱萸、龟板、知母、山萸肉、茯苓、山药等药滋养肝肾。

四、贫血型：肾炎贫血多由长期反复出现水肿，损害肾脏所致，肝肾同源，必然出现贫血。宜用当归补血汤加阿胶、熟地、鹿角胶等补血之药以改善低血浆蛋白。

当归补血汤

当归 黄芪

方解：此方是元·罗天益立方，载于《卫生宝鉴》中。此方

以当归补血，黄芪补气。主治气血两虚之证。有形之血，必借无形之气而生；故黄芪应倍于当归，方能补血，通乳时加葱白。吴鹤皋曰：“乳者，气血之所成也，无乳者，皆气血怯弱之妇也。方用归、芪大补其气血，此养乳之源也。加葱白之辛温，直走阳明，阳明达于乳房，故用之为使，此乃通乳之渠也。”

典型病例：

李××，男，26岁，起重机厂工人。1969年7月27日来中医科门诊。

主诉：患慢性肾炎已有三年，近半年来，腰痛、尿频、四肢乏力，经治无效正在病假中，故请中医治疗。

检查：慢性病容，精神萎靡，面微黄，纳差，下肢轻度浮肿，血压120/80毫米汞柱（16.0/10.7千帕），脉沉缓，舌淡薄白。

化验检查：尿蛋白定性（++++），红细胞（++++），白细胞8~10，血常规：血色素11.5毫克，白细胞9000，红细胞4400，000。

西医诊断：慢性肾小球肾炎。

中医辨证：湿热侵入肾脏日久，损伤肾气

治法：益气补肾、利水消肿

处方：

熟地20克 山药15克 茯苓20克 猪苓10克
车前子15克 旱莲草10克 枸杞子10克 桂枝5克
萆薢10克 山萸肉10克 苍术10克 白术10克
砂仁3克 杜仲10克 泽泻10克

水煎服。

按：余体会在治疗肾炎的浮肿和血尿方面是不困难的，惟对蛋白尿感觉棘手。应在补肾药中酌加活血化瘀药如红花、丹参、茜草等；以及清热利湿的药如鱼腥草、倒扣草、车前草等。有助于改善肾小动脉血流量，对降低血压，提高肾功能有一定的好处。总之，肾功能恢复健全，尿呈阴性，肾炎才算达到痊愈。

水肿病鉴别分为三种：一、肾性水肿。其特点是在疾病初期，只在早晨起床时发现眼睑或颜面水肿，以后则发展为全身性水肿。

其中血压升高与尿的改变（血尿，蛋白尿，管型尿），是诊断肾性水肿的有力根据。二、肝性水肿：肝硬化在腹水出现前，常先出现轻度下肢水肿。肝性水肿的出现常提示肝功能已渐失代偿能力。它是由于肝静脉回流受阻，水钠潴留过多，血浆蛋白减少引起营养不良造成水肿。三、心性水肿：一般认为是右心衰竭后静脉压升高而引起水肿。其特点是首先发生在下垂部位，非卧床病人的水肿，首先出现在下肢，尤以踝部最为明显，卧床病人则出现在骶部。

至于功能性水肿、下肢静脉曲张引起的水肿以及肥胖性的水肿也较常见，临床应鉴别之。

第九章 肾功能衰竭（尿毒症）

肾功能衰竭出现尿毒症乃各种肾脏病的晚期病症。由于肾功能不全，不能将身体内的蛋白质代谢所产生的含氮物质从尿中排出，以致使含氮物质在血中潴留，当氮质潴留到一定程度时，就会产生水电解质紊乱，引起全身中毒，使病情恶化，危及生命。

中医辨证认为，此病属于虚损病的范畴，它的病因、病机是虚、浊、瘀、逆四个方面，浊与瘀是本病的特征，患者浊毒大量滞留、壅而化热，以致出现内攻上逆，肾络瘀血，气化不利等一系列症状。如浊毒上逆，蒙蔽心窍，可出现嗜睡烦躁，神昏谵语，循衣摸床，肌肉颤动，甚至抽搐昏迷等“逆”的症状，这种情况下不可专用镇肝熄风之药。此乃浊毒损肝，蒙蔽清阳，应以解毒、降浊、熄风之药。用鱼腥草、倒扣草、生地黄、黄连、生大黄、钩藤、全蝎、清半夏、茯苓、天竺黄、甘草、羚羊角等。如出现心衰，乃脾肾阳虚、浊毒上逆，气不化水，凌心伤肺。症见心悸气短，不能平卧，咳嗽喘息，痰色多白，神疲乏力，口唇青紫，畏寒等症。水溢于表，则见下肢浮肿，甚者过膝，以及眼睑浮肿等。如浊阴内泛可出现大便溏稀，应以四君子汤、金匱肾气丸（汤）加减治之。方用人参、熟地黄、山萸肉、茯苓、白术、远志、五味

子、附片、肉桂、泽泻、炙甘草等，培土补肾，温阳降浊，强心利水。

四君子汤

方解：见第一篇虚证论第三章“气虚”中。

金匱肾气丸（汤）

方解：见第六篇肾虚论第一章“肾阳虚”中。

典型病例：

徐××，男，45岁，工人。

患者近半年来，下肢浮肿，一周来浮肿加重。查尿，蛋白（++++），经治疗无效病情日渐加重。尿量减少，并出现频繁呕吐，每天5—6次，于1972年9月5日住院治疗。

入院查体尿少，下肢浮肿，舌苔白腻，脉弦缓，血压200/130毫米汞柱（26.7/17.3千帕），化验：蛋白（++++），尿中红细胞4—8，有颗粒管型。血：尿素氮132毫克%、肌酐11.6毫克%。血：白细胞14000，中性80%。

症见：头晕头痛，腰酸腿软，气短乏力，胸闷憋气，恶心呕吐，口甜而干，下肢浮肿，尿短少，大便溏稀，日2—3次，食欲不振，夜不能眠，舌质淡胖微暗，苔腻中有裂纹，口气秽臭，可闻尿味，脉弦滑微数。

西医诊断为肾小球肾炎合并肾功能不全。

中医辨证：脾肾虚衰，气阴两伤，同时挟有湿热，用益气养阴，清热利湿之剂。

处方：

鱼腥草 20克 倒扣草 20克 生地黄 20克 茯苓 20克
猪苓 10克 车前子 10克 桑皮 10克 甘草 5克
泽泻 10克 虎杖 10克 桂枝 5克 牛膝 10克
丹参 12克 红花 10克 生大黄 5克

服药半个月后于方中酌加黄精、山萸肉、杜仲等补肾之药治疗，两个月后浮肿彻底消失，诸症改善，血中尿素氮11毫克%，肌酐1.3毫克%，24小时尿蛋白定量为0.21克。于1972年12月19日出院，并携带中药以巩固疗效，至1993年3月，尿蛋白转阴，

痊愈，随访一年未复发。

按：尿毒症患者由于肾功能不全发展至衰竭，乃危重之候也。出现尿少、尿闭。患者不能如正常人一样将蛋白质代谢所产生的含氮物质自尿中排出，从而使含氮物质在血中潴留，当血中非蛋白氮继续升高后，可出现高血钾等合并症。造成电解质的紊乱。进一步加剧氮质潴留的程度，使病情恶化。

中医认为二便闭塞，邪无出路是造成疾病危笃的主要原因。“洁净府”是给“邪”以出路的重要法则。在治疗此危症时除扶正外，应着重利尿、通便。大黄轻泻有荡涤肠胃湿浊，推陈致新的作用，且大黄入血分，更具有清热解毒之功效。

第七篇 男 虚 论

《素问·上古天真论》曰：“丈夫八岁，肾气实，齿更发长；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八筋骨隆盛，肌肉满壮；五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八则齿发去。肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛乃能泻，今五脏皆衰，筋骨解堕，天癸尽矣，故发鬓白，身体重，行步不正，而无子耳。”此经文说明肾是先天之本，受五脏六腑之精以贮之，五脏之精气充足，肾脏才能泄出精液；若五脏精气已衰，天癸尽竭，焉能有生殖能力？

中医对男生殖器称之为外肾，包括阴囊（肾囊）、阴卵（睾丸），以及龟头（阴茎）等，是由肾主之。肾主精室及胞宫，房室过度称之为肾劳。

肾是藏“精”之处所。但所说之“精”并非全指男性精液而言，乃指脏腑之精华，藏于肾能充实体力。肾气充足则精神焕发，衰少则精神萎靡。

《内经》所说：女子十四岁，男子十六岁天癸至，肾气充盛。天癸即至，是指男、女生殖机能的成熟，经过三十余年，肾气逐渐衰退，生殖能力逐渐消失，乃为“肾气”已衰。此“肾气”即代表人体内促使生长和衰老之物质，所以保精节欲为养生之大道也。

第一章 阳 痿

阳痿之病，其症状为：见阴不举，举而不坚，触而即泄。现

代医学称之为性神经衰弱。平日咽干目涩，多思少眠。此型多发于青壮年，乃阴虚火旺，治宜清心泻火，益肾养阴之法。以知柏地黄汤加减，方用生地黄、丹皮、知母、泽泻、山茱萸、茯苓、金樱子、黄柏、山药，滋肾阴以泻虚火。

每当性交，举而不坚，此型多发于四十岁以上之中年。平日气短乏力，乃中气不足也。治宜补益中气，兼顾肾气，以补中益气汤加减。方用党参、生黄芪、白术、当归、熟地黄、升麻、五味子、柴胡、茯苓、远志，以补气益肾。

每届临阵，痿而不振，平日腰酸，腿软，滑精，早泄，此型多发于50岁以上，乃肾阳虚衰也。治宜温肾扶阳，以右归饮加减。方用熟地黄、山药、肉苁蓉、巴戟天、韭菜子、山茱萸、淫羊藿、附子、肉桂，以强肾壮阳。

此病虽然症状相同，但年龄有别，虚实有异；因之在辨证上应详细分析。如不查虚、实、寒、热；不论年老、年少；不管体强、体弱。动辄给以参、茸、桂、附之药，遗害非浅。

知柏地黄汤

方解：见第五篇肺虚论第六章“肺虚喘”中。

补中益气汤

方解：见第四篇脾虚论第十章“中气下陷”中。

右归饮

熟地黄 山药 山茱萸 熟附子 肉桂 枸杞子 杜仲
菟丝子 鹿角胶 当归

方解：此方是明·张景岳立方，载于《景岳全书》中。主治肾阳不足，命门火衰，年老久病出现气衰神疲，畏寒肢冷，阳痿滑精，腰膝酸软等症。应以温补肾阳为主。如《景岳全书》曰：“故善补阳者，必于阴中求阳，则得阴助，而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升，而泉源不竭。”故补阳之中多兼补阴，阴阳必须兼顾。方中以熟地黄、枸杞子、山茱萸滋补肝肾，生精助阳；杜仲补肝肾，壮腰膝；山药补气健脾；菟丝子益精强阳；当归、鹿角胶滋补营血；附子、肉桂补肾火以壮元阳。此药纯补无泻，着重温补肾阳兼益精血，即古人所谓：“扶阳以配阴”之法。

典型病例

谢××，男，46岁，崇文区修管处职员，1967年9月5日就诊。

主诉：近半年来阳痿，举而不坚，交则即泄，腰酸腿软，气短乏力。查：体质较差，脉沉缓，舌淡苔薄白。

辨证：此乃气虚不充，肾阳不足之证。

治法：治以补中益气，益肾助阳之法。

处方：

党参10克 茯苓10克 白术10克 菟丝子10克
淫羊藿10克 黄芪10克 韭菜子10克 淮山药10克
肉桂3克 枸杞子10克 熟地黄10克 炙甘草5克

经过三个月治疗，共服药60剂，痊愈。

按：此证除中气不足和肾精亏损者外，尚有青、中年脑力劳动者，虽然性欲有节，然而由于用脑过度，肾精暗伤，亦可导致阳痿，临床屡见不鲜。

肾主骨髓，脑为髓海，脑肾相通，伤脑即伤肾也。阳痿之证虚者多，实者少，多为肾精亏损，命火衰微致痿者，宜峻补精髓，益命门之火，是可以有疗效的。

第二章 遗 精

遗精之病，有虚、实、寒、热之不同，临床应辨证施治。因壮年气血旺盛，精液满溢，偶然出现滑精者为正常生理现象。如君火不宁而梦遗者，宜用黄连清心饮加减。方用黄连、生地黄、当归、茯神、酸枣仁、远志、莲子肉；或因相火亢盛，茎中痛痒，阳强而遗精者，宜用龙胆泻肝汤加减。

如因劳心太过，心肾不交，酣睡而精遗者，当实土以提水，宜用人参归脾汤加减。方用党参、白术、黄芪、当归、茯神、远志、酸枣仁、木香、龙眼肉、炙甘草、生姜、大枣。

如因斫丧太过，肾气虚惫，以致精关不固，遗精滑泄，乃为

虚损之证。腰为肾之府，肾虚精亏，故腰酸；肾开窍于耳，肾精亏损，不能上充清窍，故耳鸣；精亏气弱，故四肢无力。治宜桑螵蛸散加减。方用桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、茯神、龟板、党参、金樱子、益智仁，复盆子，沙苑子，以固肾涩精。

黄连清心饮

黄连 生地黄 远志肉 人参 当归 酸枣仁 莲子肉
茯神 甘草

方解：此方是清·沈金鳌立方，载于《沈氏尊生书》中。主治由于壮年气血充盛，君火不宁所引起的梦遗、滑精，宜用此方治疗。方中用人参、甘草补脾益气；生地黄、黄连清热滋阴，以泻心火；当归补血润燥；酸枣仁除烦止渴，宁心安神；远志、茯神强心益智，能交心肾；莲子肉补脾涩精，清心除烦。诸药合用，成为益气清心，宁神固涩之良方，对于心火亢盛所致之滑精病，至为有效。

人参归脾汤

方解见第二篇心虚论第四章“心血虚”中。

桑螵蛸散

桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 党参 茯神 当归 龟板

方解：此方是宋·寇宗奭立方，载于《本草衍义》中。本方有调补心肾，固精止遗之功效。主治由于肾虚不摄，心气不足所致之梦遗、滑精病。方中以桑螵蛸补肾、固精、止遗为主药；茯神、远志、菖蒲安神定志，为辅药；党参、当归合用，双补气血；龙骨、龟板相配，调补心肾，组合成方。有补益气血，调补心肾，安神定志，固精止遗之效用。

典型病例

刘××，男，42岁，崇文区工业局职员，1975年5月5日就诊。

主诉：近半年来由于工作劳累，夜晚遗精，一个月内出现三、四次，腰酸肢软，疲倦乏力。查：体质尚健，脉沉细微数，舌微红苔微白。

辨证：脾肾两虚，心肾不交，精关不固之证。

治法：以养心宁神，益肾补脾，固涩止遗之法。

处方：

桑螵蛸 10 克 熟地黄 10 克 芡实 10 克 龟板 10 克
柏子仁 10 克 肥知母 5 克 黄柏 5 克 山药 10 克
沙苑子 10 克 煅龙骨 20 克 煅牡蛎 20 克 菖蒲 5 克
经过两个月治疗，共服药 30 剂，痊愈。

按：遗精之病，有梦而遗谓之遗精；无梦而遗谓之滑精。梦遗多由肾水不足，心火不宁所致；滑精多由误犯手淫，房事无度，耗伤肾气，精关不固所致。因此，在治疗青壮年时，应于补肾固涩药中酌加少量黄连、麦门冬、莲子心等清心之药，以泻心火，而神自安，病自能愈。并对患者讲清此病之危害性，取得患者的主动配合，杜绝手淫，房事有节，治疗方能有效。

第三章 老年癃闭（前列腺肥大症）

小便不通谓之癃。癃闭多发生在男性老年人身上。其病因病机为老年人阳气衰微，气血运行减弱，寒气凝聚，真元不足，命门火衰。现代医学认为癃闭是前列腺肥大引起的。由于腺体之肥大，输尿管受到压迫，排尿障碍，使膀胱膨胀，尿液潴留。宜以桂附地黄丸、固脬丸加减治之。方用熟地黄、菟丝子、沙苑子、淫羊藿、肉苁蓉、肉桂、附子、补骨脂、川续断、牛膝等。外用热水坐浴，局部温熨，以助其气血之流畅，温散寒湿。

固脬丸

菟丝子 小茴香 黑附子 桑螵蛸 大青盐

方解：此方是明·王肯堂立方，载于《证治准绳》中。主治膀胱虚寒，小便不禁，或小便不畅之良方。凡小便不禁者，宜固膀胱。对于年老气衰，肾阳不足，下焦虚寒，气化不利之癃闭证尤为有效。方中用黑附子大辛大热温暖元阳，以助命门之火；以菟丝子强阳益肾，温补三阴；以小茴香补命门火，温暖丹田；以桑螵蛸益精气而固肾；又以大青盐引诸药共同入肾。实为温暖下

焦痼冷，补益丹田肾气之妙方也。

桂附地黄丸

方解：见第五篇肺虚论第六章“肺虚喘”中。

典型病例

朱××，男，74岁，北京帆布厂退休工人，1979年8月23日就诊。

主诉：二个月来尿不畅甚至排泄不出，在外科检查为前列腺肥大症。脉沉缓，舌淡苔薄白。

辨证：年老体弱，肾阳虚衰，气血凝滞，形成寒聚，阻塞水道。

治法：以补气益肾，温暖下元之法。

处方：

党参10克 乌药10克 制附片10克 淫羊藿10克
肉桂5克 吴茱萸5克 萆薢10克 木香10克
牛膝10克 桑寄生10克 桃仁10克 红花10克
服药6剂，尿已畅，又服3剂，痊愈。

按：前列腺肥大症属于中医所讲癃闭病之一种，老年人之癃闭病多由肾阳不足，命门火衰所致，当以温补肾阳为主。局部可用老葱白数根切碎和小茴香共炒热，熨敷之。至于有由气滞、热郁或产后气虚而发生小便癃闭不通者，应当辨证施治。

第四章 寒 疝

疝之为病乃腹部脏器经腹壁薄弱处或缺损处向体表突出时，称之为疝。其中以腹股沟疝最为多见，股疝次之，脐疝多见于婴儿。

《素问·长刺节篇》曰：“病在少腹，腹痛不得大小便，病名曰疝，得之寒。刺少腹两股间，刺腰踝骨间，刺而多之，尽炅病也。”疝之辨证，其因热者缓缓不收而拒按；因寒者则上引作痛而喜按；因湿者则肿胀下垂。大痛为实，不痛为虚，绞痛不能缓解

者为嵌顿疝。不但疼痛剧烈且伴有恶心、呕吐等症状，早期者可使用手法复位，如一时不能缓解应急以手术治疗。

本文所论寒疝乃由于肾气虚弱，寒湿内侵，留滞厥阴，引起阴囊肿大或疼痛，其病在外肾，而病变在肝经，治宜调气和肝，化湿散寒，温暖下元之法，以暖肝煎加减治之。方用小茴香、肉桂、乌药、沉香、当归、枸杞子、橘核、荔枝核、吴茱萸、干姜、附子等。

疝之为病乃睾丸牵连少腹疼痛，有的肿坠，应辨寒、热、虚、实。有由湿热壅遏，浊液凝滞，流入厥阴；有因外为风寒所袭，以致少腹及睾丸红肿暴痛，此为急性睾丸炎或副睾丸炎所引起，应以清热解毒为主，乃为实热之证。本文所指寒疝多为年老体弱，因寒湿侵袭而得之。寒气凝于厥阴，上引作痛，或因湿注下焦，使睾丸肿胀下垂，经年作痛，劳累后下垂增重，肿甚而不痛者乃太阴湿土为患；手足厥冷者为寒甚。临床应审慎施治。

暖肝煎

当归 枸杞子 肉桂 小茴香 乌药 沉香 茯苓 生姜

方解：此方是明·张景岳立方，载于《景岳全书》中。暖肝煎有温补肝肾、行气祛寒之功效。主治肝肾阴寒，少腹疼痛，寒疝等症。方中用当归、枸杞子补肝肾；小茴香补命门火，温暖丹田；肉桂补阴消痞冷沉寒；乌药辛温香窜，能通散下焦之冷气；沉香暖精助阳，行气温中；茯苓渗湿利水；生姜祛寒通阳。诸药合成，对于阴寒偏盛之寒疝最为有效。如因湿热下注阴囊红肿热痛的则不宜使用，临床应审慎辨证。

典型病例

佟××，男，80岁，崇文区延庆寺街10号退休工人，1971年12月5日就诊。

主诉：素有小肠疝气病，稍有劳累或感受寒凉，少腹即疼痛，睾丸下坠肿胀，近日发病。查：脉弦缓，舌淡苔薄白。

辨证：年老气弱，下焦虚寒，固摄失司，气虚下陷之寒疝证。

治法：以温暖下元，补气升提之法。

处方：

党 参 10 克 生黄芪 20 克 白 术 10 克 当 归 10 克
橘 核 10 克 菟丝子 10 克 荔 核 10 克 小茴香 10 克
官 桂 10 克 附 片 10 克 升 麻 2 克 炙甘草 5 克

经过半个月治疗，服药 15 剂，症状消失。嘱经常服用茴香橘核丸、补中益气丸扶养，观察三年未复发。

按：祖国医学对疝之分型有：寒疝、水疝、筋疝、血疝、气疝、癪疝、狐疝等七种，主要是以症状命名。其病因各异，但多属肝经为病。此章所论之寒疝与现代医学腹股沟斜疝相似。中医则认为主要由于命门火衰，寒气凝滞，同时中气下陷，不能提携，以致脏器组织坠入腹股沟内或睾丸内，因此发生“疝”。此病多发生于老年人身上，因为老年人气虚火衰所致，宜用补命门火，暖下元，益中气以升提。虽不能根治，但可以缓解，有时亦能长期不复发。

第八篇 女 虚 论

《素问·上古天真论》曰：“女子七岁，肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时而下，故有子。……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子。”《素问·离合真邪论》曰：“天地温和，则经水安静；天寒地冻，则经水凝泣；天暑地热，则经水沸溢；卒风暴起，则经水波涌而陇起；夫邪之入于脉也。寒则血凝泣，暑则气淖泽，虚邪因而入客，亦如经水之得风也。”宋·王子亨曰：“经者，常候也。谓其一身之阴阳愆伏知其安危，故每月一至。太过、不及，皆为不调，阳太过，则先期而至，阴不及，则后时而来；其有乍多乍少，断绝不行，崩漏不止，皆由阴阳衰盛所致。”以上为古代医家对月经生理、病理之论述。

女子以血为主，血是由“中焦受气取汁变化而赤，是谓血。”它有“调和五脏，洒陈六腑”之作用。血化生于脾而统于心，藏于肝而布于肺，灌溉一身。任脉为阴脉之海，冲脉有血海之称。对于女子更有其特殊作用，营血外循于经络，内荣于脏腑，阴阳调和，诸经满溢，汇于冲任下达胞宫，月经依时而下。因此五脏精气之充沛与冲、任之盈虚，对月经有直接之关系。（见图 10）

中医对于女性生殖系统之子宫，无不以冲、任主之。古代医家对子宫称为：胞宫、胞中、血室、血海等。又有任主胞胎，冲为血海之说。经血常以一月一行不失其期，故称月经，又名月信。现代医学将女性生殖器官分为宫体，左右两侧输卵管以及两侧卵巢，宫体下为宫颈、阴道以及外阴。月经周期性的子宫出血，是直接受卵巢激素控制的。如果身体健康，月经自 14 岁开始，到 49 岁绝经期，大致行经 35 年左右。根据身体的不同情况，有的多几年，有的少几年。月经先期或后期称为月经不调。女科之病，分：调经、种子、胎前、产后等。各种疾病有虚有实。兹将虚证分别

论述如后。

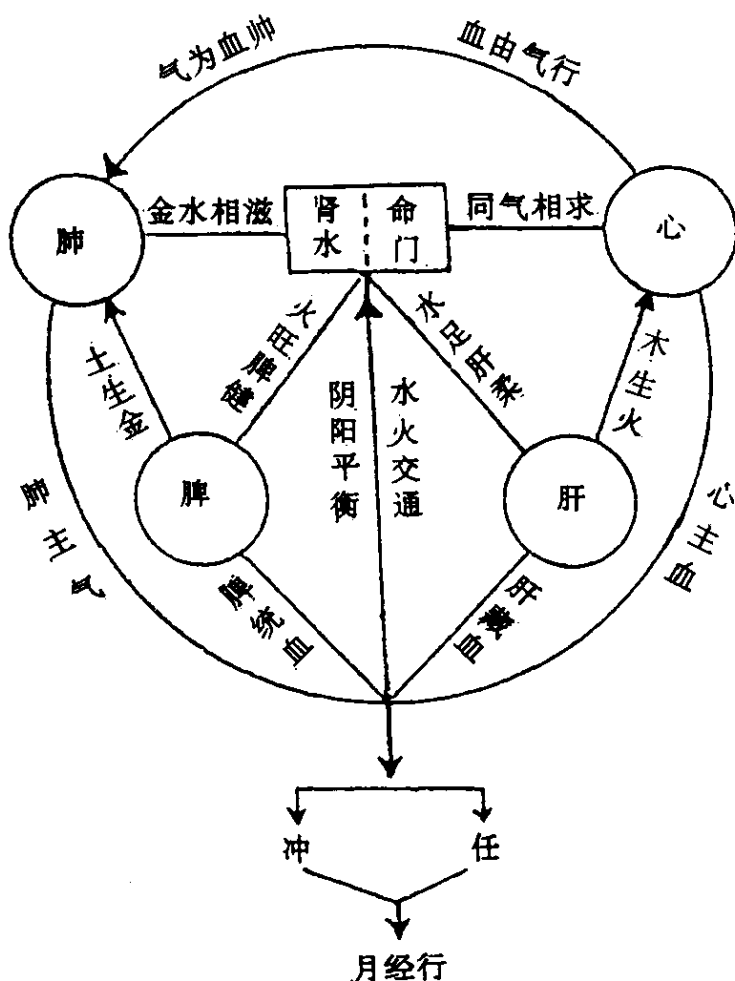


图 10 月经生理与脏腑的关系示意图

第一章 月经先期

月经先期有血实热、血虚热之分。付青主则以经量多少而分实热、虚热。如先期而来，量多者，乃火热症，血有余也；先期而来，血少者，虽云有热，实为阴血不足之症。

一、实热型

如肝热久郁血燥阴虚，以致经血妄行，先期而量多，治应以舒肝解郁，清热凉血之法，逍遥散加减。方用：柴胡、栀子、丹皮、香附、白芍、郁金、侧柏炭、白术、当归、生地、黄芩炭、黄

柏等。

逍遥散

方解：第六篇肾虚论第4章“不寐证”中。

典型病例

王×× 女 24岁 工人 1979年6月8日就诊。

主诉：经期近两个月先期而至，这次已行七天，血量不减。口渴引饮，腹不痛，腰略酸。

检查：面部红润，脉弦，舌红。

辨证：月经先期，血热妄行，渐成崩症。

治法：清热凉血。

处方：

生地 30克 白芍 12克 侧柏炭 10克 仙鹤草 20克

桅子 10克 丹皮 10克 黄芩炭 10克 芥穗炭 10克

当归 10克 柴胡 10克 黄柏 10克 干荷叶 15克

连服7剂经净，嘱服加味逍遥丸每日2次，每次5克连服2个月，痊愈，连访半年月经正常。

二、虚 热 型

如肝肾亏损，虚火妄动，则重在补虚，张景岳曰：“先期而至虽曰有火，若虚而夹火则重在补虚，当以养营安血为主，用凉血调经汤（丸）加减。方用生地黄、当归、白芍、鳖甲、枸杞子、茯苓、白术、青蒿、黄芩、黄柏、柴胡等治之。

凉血调经丸（汤）

当归 黄芩 黄柏 白芍 鳖甲 枸杞子 樗皮

方解：此方为清代沈金鳌所立，载于《沈氏尊生书》中。主治月经先期，量多不止，方中黄芩、黄柏泻血中郁热，止血妄行；当归养血调经；白芍养阴和肝；鳖甲滋阴潜阳；枸杞子补肝肾之阴；樗皮可止女子血崩。诸药合用对冲任不实，血有虚热，月经先期，量多不止之症，有清泻血中郁热，治血之妄行，使血归经，达到调经的止崩作用。

典型病例

刘×× 女 39岁 职员 1978年11月3日就诊。

主诉：月经先期淋漓不净，经期多达10天不止，腰酸痛，心烦不眠，口干不欲饮。

检查：面微黄，舌淡微红，脉沉缓。

辨证：肝肾亏损，肝血虚热。

治法：用补肝肾，养血调经之法。

处方：

熟地 20克 枸杞子 10克 鳖甲 10克 茯苓 20克
首乌 12克 地骨皮 10克 当归 10克 白芍 12克
杜仲 12克 白术 10克 炙甘草 10克 干荷叶 10克
桑寄生 10克

连服14剂月经净，体力渐渐恢复，观查3个月月经正常，痊愈。

第二章 月经后期

妇女月经每28天为一周期。赶前谓之先期，此病多发于青壮年妇女，证多属热、属实。而40岁以上经产妇或身体虚弱的妇女多属虚、属寒。临床应仔细辨认，本书专论虚证，故实热证从简。

女子月经错后谓之后期，同时月经量少。此病多发于40岁以上经产妇或身体虚弱的妇女，此证属虚、属寒。发于青壮年者应辨认是否由于肝郁气滞所致，未婚女子因生理关系常常后期，两个月一至俗称“并月”，三个月一至谓之“居经”，若面色不改，饮食正常，身无内热，无任何痛苦者，结婚以后，阴阳调和，经期自准。如逾三月仍未至，应考虑为气血涩滞，冲任不实，给以调经养血，理气化瘀之药调理之。

清·武之望《济阴纲目》曰：“有因脾经郁滞者宜归脾汤”。元·朱丹溪曰：“经水过期血少也，用川芎、当归、人参、白术。”明·薛立斋曰：“过期而至，有因脾经血虚者宜人参养荣汤。有因体弱者宜八珍汤。”

根据古代医家论述，月经后期多因体质虚弱，气血不足，冲任虚损所致，为属虚、属寒。应以四物汤为主增加培补气血，温暖下元之药治之。方用熟地黄、当归、白芍、川芎、香附、白术、吴茱萸、官桂、菟丝子、党参、炙甘草等。若发生在青年妇女，只宜以四物汤酌加理气解郁之药，如乌药、木香、郁金、香附等，不可擅用温补之药，应慎之。

若长期闭经不行，应考虑是否患有其他慢性疾病，如各种结核病，浮肿病以及肝硬化等病，均可使月经停止，不应舍本逐末，只知调治月经，忽略本病，而应溯本求源，治疗病根，本病痊愈，冲任充实，则月经自行。

四物汤

方解：见第一篇总论第四章“血虚”中。

典型病例

李××，女，42岁，北京料器厂工人，1972年5月4日就诊。

主诉：闭经已有半年，近一、两年经期不准，经常后期，腰酸腹痛，心跳气短，烦躁失眠。生育史：生五存三。

检查：脉沉细，舌淡苔薄白。

辨证：冲任不实，下元虚寒，月经不调。

治法：以补气养血，温暖冲任之法。

处方：

菟丝子 10克 熟地黄 10克 当 归 10克 鹿角霜 10克
白 芍 10克 香 附 10克 台党参 10克 官 桂 10克
吴茱萸 5克 淫羊藿 10克 益母草 10克 甘 草 5克

连服药一个多月，月经始行，继用上药与八宝坤顺丹交替服用，治疗半年，逐渐按月行经，痊愈。

按：月经后期以虚和寒为主。但又多兼郁。清·《傅青主女科》曰：“盖后期而来少，血寒而不足。”“后期而来多，血寒而有余。”据此即后期量少者为虚而无寒；后期量多者乃寒而不虚，血寒则凝，气虚脾易虚，血无生化之源经血必少，血因寒而凝聚不行。治疗此证，以益气养血，温暖冲任为主，凝聚之血得行，诸经之血自通，月经可届时而至矣。

第三章 漏 下

清代叶天士曰：“崩漏不止，经乱之甚者也。盖非时血下，淋漓不止，谓之漏下，忽然暴下，若山崩然，谓之崩中，由漏而淋，由淋而崩。”

清代唐容川曰：“崩漏者非经期而下血之谓也。少者名曰漏下，多则名为血崩。”

根据古代医家对崩漏之论述，十分详尽，大下谓之崩中，属实，属热；淋漓不断谓之漏下，属虚，属寒。但崩后血止，其气血两虚者，亦应给以培补气血之药，防溃止而复决。对漏下证宜先止血以塞其流，用胶艾四物汤加减治之，方用棕炭、蒲黄炭、姜炭、血余炭、艾叶炭、当归、白芍、熟地黄、白术、阿胶、三七、炙甘草。血乃中州脾土所统摄，土虚则必漏下不止，因此治血必治脾，若久漏不止，劳倦伤脾，脾虚不摄血者宜用人参归脾汤加艾叶、阿胶、棕炭、蒲黄炭、三七等。凡漏下已止，大虚者应用十全大补汤或人参养荣汤加减，以端其本，如不端本，则散失之阳，无以自持，脾土不旺，中气不充，漏下之血焉能循经，其旨奥矣。

人参养荣汤（丸）

方解：见第一篇总论第五章“气血两虚”中。

人参归脾汤

方解：见第二篇心虚论第四章“心血虚”中。

十全大补汤

方解：见第五篇肺虚论第九章“脱肛”中。

胶艾四物汤

阿胶 川芎 艾叶 当归 白芍 熟地黄 甘草

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中。胶艾四物汤有补血调经，安胎止漏之功效。主治血虚寒凝，少腹疼痛，月经过多，胎动不安，妊娠下血，产后下血，淋漓不断等症。方

中以熟地黄滋肾补血，以养胞宫，用为主药；肝肾同源，肾虚则肝血亦虚。故以当归补血养肝，和血调经；白芍养血和阴；川芎活血行气，气血畅通，补而不滞；加阿胶养血益气，滋补肾阴；艾叶止血暖宫；甘草益气补脾。为治疗妇女崩漏及安胎的主要方剂，与四物汤之专用于补血调经有所不同。

典型病例

陈××，女，41岁，北京工艺木刻厂工人，1970年3月3日就诊。

主诉：月经淋漓不断已50余天，近日量又增加，腰酸腹痛，心跳气短，懒言，嗜睡，不能坚持工作。

检查：面色晄白，形体消瘦，查血红蛋白为8克，脉沉涩而缓，舌淡苔薄白。

辨证：大下谓之崩，淋漓不断谓之漏，此证乃冲任虚损，脾虚不能统血，近日量多，又一周期耳。宜先调经止血，待本期月经行后，然后培补气血。

处方：

棕炭10克 艾炭10克 地黄炭10克 姜炭5克
白芍10克 芥穗炭10克 香附10克 当归10克
蒲黄炭10克 白术10克 炙甘草5克 阿胶10克（烔化二次）

连服5剂，月经减少。1970年3月8日二诊：服药后月经逐渐减少，症状同上，改用培补气血之药治之。

第二次处方：

党参10克 当归10克 白芍10克 白术10克
远志10克 香附10克 艾叶10克 熟地黄10克
阿胶10克（烔化冲服） 酸枣仁10克 炙甘草5克

经过半月治疗，共服药20剂，经血已止，嘱继服人参归脾丸、人参养荣丸，早晚各一丸。又治疗一个月，身体康复；查血红蛋白为13克，红细胞计数为400万/立方毫米，痊愈。再行经时，经量、经期均已正常。

按：凡崩漏之证皆与心、肝、脾有关，肾水充足则肝木调达，

心火得养，生血之机旺盛。肾水充足与否，是最关键之一环。治崩中以清热凉血为主，治漏下则以补虚养血为主。此乃治疗崩漏之大法也。

第四章 痛 经

月经期少腹疼痛，皆称痛经病。须辨虚实，月经将行而腹痛者属血实气滞，乃有瘀血，宜用四物汤加红花、香附、桃仁、木香、元胡，有热者加黄芩、柴胡，此为实热证非本篇所论述范围，从简。

月经过后少腹隐隐作痛，属气血两虚，或寒湿凝于胞宫，宜加味四乌汤治之。方用熟地黄、当归、乌药、香附、白芍、川芎、炙甘草。加炮姜、官桂、吴茱萸暖宫散寒，增加祛寒止痛之效用。

四物汤

方解：见第一篇虚证论第四章“血虚”中。

四乌汤

熟地黄 当归 川芎 白芍 乌药 香附 甘草

方解：本方是清·张石顽立方，载于《张氏医通》中。四乌汤为张石顽在四物汤之基础上，增加乌药、香附、甘草，名为四乌汤，主治月经期间小腹作痛，气血涩滞者最为有效，对冲任虚衰，少腹有寒而作痛者可加炮姜、官桂、吴茱萸。月经量少不畅，有瘀血者，应加桃仁、红花、元胡。以行血逐瘀，则痛自止。

典型病例

李××，女，45岁，北京针织工厂工人，1970年10月4日就诊。

主诉：月经40余天一行，量少。行经以后少腹隐隐作痛，饮姜糖水时即见好转。

检查：患者身体虚弱，多子女，血红蛋白为10克，脉沉细而涩，舌淡苔薄白。

辨证：气血不足，寒气聚于胞宫。

治法：以温暖下元，培补气血之法。

处方：

党 参 10 克	炮 姜 10 克	官 桂 5 克
白 芍 10 克	乌 药 10 克	吴茱萸 10 克
当 归 10 克	熟 地 10 克	艾 叶 10 克
香 附 10 克	川 芎 5 克	炙甘草 5 克

共服药 50 剂，同时服用艾附暖宫丸与汤剂交替服用，经过三个月治疗，痛经之症痊愈，体力恢复。

按：痛经之证，有虚、实、寒、热之别。经前腹痛属实或兼有热；经后腹痛属虚多兼寒。此乃大法也。辨证错误，必致虚虚；实实；寒寒；热热之害。临证不可不慎。

第五章 带 下

清·傅青主曰：“夫带下俱是湿证，而以带名者，因带脉不能约束，而有此病，故以名之。盖带脉通于任督，任督病而带脉始病。带脉者，所以约束胞胎之系也。带脉无力，则难以提系，必然胞胎不固，故曰带弱则胎易坠，带伤则胎不牢。”带下之辨证，有寒、热、虚、实之别，可分为三种：

一、湿热下注

湿热带下之物，色黄液浓其味腥臭，有时下身灼热感，甚则刺痛。由于热邪羁留于下焦，湿与热合，结于任脉，渗入胞宫，淋漓而下成为带症。此乃湿热下注，治二妙散加减治之，方中用苍术、黄柏、茯苓、猪苓、木通、泽泻、车前子、栀子、滑石、甘草等，清热化湿。

二妙散

黄柏 苍术

方解：此方为朱丹溪所拟，载于《丹溪心法》中。主治：湿热下注，小便短赤，带下浑浊。有清热除湿之功。方中以黄柏苦

寒清热；苍术苦温燥湿。二药合用，具有清热燥湿之效，使湿去热清，症自除。

典型病例

刘×× 女 30岁 工人 1977年8月5日就诊。

主诉：近日下身刺痒，心中烦躁，带下色黄，大便干。

检查：脉弦滑，舌红苔黄。

辨证：湿热下注，黄带症。

治法：清热解毒，化湿止带。

处方：

苍术 10克 茯苓 20克 猪苓 10克 泽 泻 10克

栀子 10克 木通 10克 萆薢 10克 车前子 10克

赤芍 10克 滑石 10克 甘草 5克 竹 叶 10克

服药 10剂，带止痒消，痊愈。

二. 脾胃虚寒

带下之物，如涕如唾，淋物清稀，淋漓不止。此乃脾气受伤，湿土之气下陷，清阳之气不升，不能化生荣血。治法当以壮脾胃升阳气，使脾气健而湿气消，则带自止。用浣带汤加减治之，方用苍术、白术、山药、党参、茯苓、陈皮、白芍、车前子、黑芥穗、柴胡。益气壮脾，除湿止带。

浣带汤

白术 山药 党参 白芍 苍术 黑芥穗 柴胡 陈皮

车前子 甘草

方解：本方是清·傅青主立方，载于《傅青主女科》中。主治妇女带下病。对于妇女因脾虚不运，肝气不舒所致之湿浊下注带下病，颇为有效。本方以健脾燥湿为主，佐以舒肝理气之药；方中重用白术、山药健脾燥湿，以治白带，为主药；以党参益气健脾；苍术运脾燥湿；四药合用，使脾旺则湿无以生，用柴胡、白芍解郁舒肝；再以黑芥穗收敛止带；陈皮理气健脾；车前子利水祛湿；甘草调和诸药。成为益气健脾，燥湿止带之妙方。

典型病例

赵×× 女 46岁 工人 1974年10月28日就诊。

主诉：素有胃病，消化能力较差，大便微溏，带下色白，清稀，腰酸倦怠。

检查：面色黄白，体瘦，脉沉细。

辨证：脾胃虚寒，带下症。

治法：升阳益胃，健脾除湿。

处方：

党参 20克 黄芪 15克 茯苓 20克 白术 15克

山药 20克 白芍 10克 陈皮炭 10克 柴胡 3克

莲肉 10克 葛根 10克 车前子 10克 甘草 5克

服药一个月带止，大便正常，面色红润，体力恢复。

三、冲任虚损，带脉不固

带下日久，淋漓无度，使精血干枯，肌肉消瘦，元阳衰微。应以秘元煎加减治之，方用远志、山药、芡实、酸枣仁、白术、茯苓、党参、五味子、金樱子、炙甘草。虚寒甚者加附子、肉桂、菟丝子。

秘元煎

远志 山药 五味子 白术 酸枣仁 云茯苓 金樱子

芡实 人参 炙甘草

方解：此方是明·张景岳立方，载于《景岳全书》中。秘元煎用四君子汤补中气健脾胃，又将王肯堂治疗梦遗白浊，妇人淋漓白带之水陆二仙丹（金樱子与芡实）合入。张景岳在此二方的基础上又增加远志、五味子以强心益智；酸枣仁宁心安神；山药涩精止遗，共合成此方。对于元阳虚损，久遗火衰，冲任不固之带下病，至为有效。

典型病例

马××，女，41岁，朝阳区十八里店农民，1967年12月2日就诊。

主诉：月经经常后期，近三个月来白带量多，颜色清稀，少腹隐痛，腰酸肢倦，气短乏力。

检查：体质较弱，为多产妇，两脉沉细，舌质淡，苔薄白。

辨证：冲任虚损，带脉不实，元阳不足之证。

治法：以气血两补，温暖下元，化湿止带之法。

处方：

党参10克 附片5克 吴茱萸5克 白术10克

山药10克 芡实10克 官桂10克 茯苓10克

菟丝子10克 木香5克 炙甘草5克 金樱子10克

共服汤药60剂，配合乌鸡白凤丸交替服用，经过3个月治疗而痊愈。

按：明·张景岳曰：“妇人淋带，虽分微甚，而实为同类。盖带其微而淋其甚者也。”清·陈莲舫对此病认为：“总由命门不固。而不固之病，其因有六，盖一以心旌之摇之也。心旌摇则命门应，命门应则失其守，此由于不遂者也。一以多欲之滑之也。情欲无度，纵肆不节，则精道滑而命门不禁，此由于太遂者也。一以房室之逆之也。凡男女相临，迟速有异，此际权由男子，而妇人情兴，多致中道而止，止则逆，逆则为浊为淋，此由于遂而不遂，乃女子之最多而最不肯言者。以上三证，凡带浊之由乎此者，十居八九。而三者之治，必得各清其源，庶可取效。然源未必清，而且旋触旋发，故药餌之功，必不能与情窦争胜，此带浊之所以不易治也。此三者之外，则尚有湿热下流者，有虚寒不固者，有脾肾亏陷而不能收摄者，当各随其症而治之也。”

先贤对于妇人带症有很多阐述。除一部分是湿热引起外，大多带症为湿盛火衰，肝郁气弱，脾气受伤，湿土之气下陷所致。治疗方法当以补脾养胃，解郁化湿。现代医学认为带证有由滴虫所引起的；有由霉菌侵袭致使宫颈糜烂所引起的；更有由于宫颈癌而引起的赤白带下者。应结合检查，以免误诊妄治。

第六章 不 孕 证

妇人有形寒畏冷，非火不暖，交感之际，阴中绝无温暖之气

者。此乃胞宫寒极所致。盖胞宫秉受相火之阳温煦之，今肾火衰微则胞宫因之寒冷。治宜培补命门之火，应以温胞饮加减，方用党参、当归、菟丝子、杜仲、肉桂、熟附子、补骨脂、淮山药、芡实、巴戟天、白术、炙甘草。若胞宫过于寒凉，不能摄精者，宜用蠡斯丸治之。

如妇人饮食不运，胸膈胀满，时多吐泻，久不受孕者，此由脾胃虚寒所致。盖脾阳非心火不生，非肾火不化。心肾火衰，土失生气，即不能消化水谷输运精微，自无津液以灌输胞宫。脾胃不健则带脉无力，即能受孕亦恐流产。治宜补命门与心经之火，以温煦脾胃之阳。用温土毓麟汤加减。方用巴戟天、熟地黄、党参、茯苓、白术、山药、复盆子、菟丝子、肉桂、附片、神曲、当归，益肾强心，补脾健胃，使脾胃健运，水谷运化，胞宫温暖，带脉充实，自能孕育。

温胞饮

白术 巴戟天 人参 淮山药 芡实 杜仲 菟丝子 肉桂
补骨脂 附子

方解：此方为清·傅青主立方，载于《傅青主女科》中。本方之妙在于补心，补心即补肾，温肾即温心，使心肾气旺而火自生，胞宫之寒自散，焉有不孕之理。方中用人参大补心气；附子、肉桂、补骨脂能补命门之火，以壮元阳；巴戟天、菟丝子补肾益精；白术、山药补气健脾；芡实固肾益精；杜仲补肝虚，强筋骨。诸药合用，成为益心脾，补相火，散寒湿，暖胞宫之良方。

蠡斯丸

熟附子 肉桂心 厚朴 秦艽 茯苓 法半夏 人参 沙参
白薇 牛膝 细辛 干姜 杜仲

方解：此方是明·王肯堂立方，载于《证治准绳》中。本方专治子宫虚寒，不能摄精成孕，应加入当归以养血，调和阳药之性，不致阳无以化。方中以附子、肉桂心补命门之火，以壮元阳；杜仲、牛膝补肝肾而壮腰膝；秦艽、厚朴、茯苓、法半夏治理痰积；沙参、白薇专清浊带；干姜、细辛辛散湿寒；人参大补元气。合而用之，可温暖子宫，阳施阴化，孕自成矣。

温土毓麟汤

巴戟肉 复盆子 山药 白术 人参 神曲

方解：本方是清·傅青主立方。载于《傅青女科》中。主治妇人脾胃虚寒而引起的不孕证。此方先补命门与心经之火，脾胃之阳自复，脾胃寒冷之虞自解。药味不多四经并治，使气血旺盛自能育麟，带脉有力，自无坠落之忧。方中用巴戟天补肾强阳，复盆子益肾固精，人参强心补气，这三种药治心肾之本；以白术与山药健胃补脾，神曲调中开胃，此三种药治脾胃之标。六味共用，有益肾强心，补脾健胃，标本兼治之功。

典型病例

吴××，女，32岁，崇文区印染厂工人，1959年10月4日就诊。

主诉：八年前生育一女，近五年来因患肺结核、肠结核，月经不准，有时两个多月一行，经量甚少，腰酸腹痛。现结核病已愈，仍愿再生一子而求医。

检查：体质较弱，两脉沉细，舌质淡苔薄白。

辨证：下元不足，子宫寒冷，不能成孕。

治法：以温暖下焦，调经种子之法。

处方：

菟丝子 10克 淫羊藿 10克 熟地黄 10克 巴戟天 10克
当归 10克 附片 5克 补骨脂 10克 肉桂 5克
杜仲 10克 吴茱萸 10克 牛膝 10克 桑寄生 10克

经过半年治疗，共服150剂，月经正常。于翌年五月怀孕，后产一儿，阖家欢喜，来信感谢。

按：祖国医学认为肾主生殖，女子胞宫有孕育胎儿的作用，它和冲任二脉有密切之关系。冲任二脉皆起于胞宫，任脉为阴脉之海，主胞胎；冲脉有血海之称。若肾阳不足，下焦寒冷，脏腑生理功能低下，胞宫必然寒冷，孕育无能。如天寒地冷，五谷草木枯萎不生之理。

关于胞宫居于心肾之间的说法，傅青主曰：“盖胞胎居于心肾之间，上系于心，而下系于肾。”这种定位是错误的。胞宫即不在

心肾之间，也不是上系于心，下系于肾。乃位于心肾之下，盆腔之中。被四条韧带固定在盆腔中央，前为膀胱，后为直肠。傅青主的错误论点是当时历史客观条件所造成，是可以理解的，但必须予以纠正。

第七章 胎漏（先兆流产）

明·张景岳曰：“妊妇经血不固者，谓之胎漏。”清·傅青主曰：“妊妇有胎不动腹不疼，而小便中时常有血流出者，人以为血虚胎漏也。谁知气虚不能摄血乎！夫血只能荫胎，而胎中之荫血必赖气以卫之，气虚下陷则荫胎之血亦随气而陷矣。”此证多因妇女妊娠之后房室过度，冲任虚损；或误跌闪仆，伤及胎元。故腰酸下坠，腹痛难忍，甚至流出少量血水，乃胎动不安。此属于虚证也。此证多因脾胃虚弱，肾气不足，下元不固，冲任失守，不摄元养胎所致。宜以胎元饮加减治之。方中用人参、当归、杜仲、白术、白芍、熟地黄、陈皮、炙甘草。下元不固者，加菟丝子、补骨脂。腰痛者，加川续断、桑寄生。血热者，加黄芩、生地。出血多者，加阿胶、三七。

胎元饮

党参 当归 杜仲 白芍 熟地黄 白术 炙甘草

陈皮（无滞者不用）

方解：本方是清·沈金鳌立方·载于《沈氏尊生书》中。主治冲任失守，胎动不安，为保胎之良方。方中以党参培补中气；当归补血养阴；熟地黄滋阴益肾；白芍涩敛和阴；白术补脾安胎；杜仲补肾安胎；炙甘草益气补脾；陈皮应少用为佐，无滞可不用。清·陈莲舫对此方注：“如下元不固，而多遗浊者加山药、补骨脂、五味子，气分虚者倍白术，加蜜炙黄芪，虚而兼寒多呕者加炮姜，虚而兼热者加黄芩、生地，阴虚小腹痛者加枸杞子；多怒气逆者加香附、砂仁，若有所触而动血者加炒川续断、阿胶，呕吐不止者加姜半夏、生姜。”此方立法遣药严紧，依法施治均可奏效，胎安

得固。

典型病例

王×× 女 29岁 崇文区教育局职员,1962年6月6日就诊。

主诉:结婚三年,去年曾流产一次,现怀孕三月余,近日腰酸,腹痛下坠,阴道有少量血流出。

检查:两脉滑数,舌淡红苔薄白。

证属:胎动不安,先兆流产。

治法:补肾安胎,益气固本之法。

处方:

菟丝子 10克 熟地黄 10克 白术 10克 杜仲炭 10克
川断 10克 当归 10克 五味子 10克 黄芩 10克
白芍 10克 桑寄生 10克 补骨脂 10克 炙甘草 5克
阿胶 10克〈分两次烔化服〉。

服药6剂,血止,症状消失。嘱经常服用此方可保胎顺产。翌年果然产子,夫妇抱子同来感谢。

按:清·叶天士曰:“妊娠脾胃旺、气血充,则胎安产易,子亦多寿,何必服药。若气血衰,脾胃弱,而饮食少思,则虚证百出,或不妊,或妊而屡坠,更或外感六淫,内伤七情,耗散真元,皆坠胎之由也。”《女科秘诀大全》引徐东皋曰:“胎有不安,而腰疼腹痛,甚至于下坠者,未必不由于气血虚无所养而使之然也。”中医在治疗此症时无不以补虚为主,其病因乃脾胃虚弱,下元不固,冲任失守,不能固摄养胎所致。治疗方法无不以益气、健脾、固肾之药保胎。但亦有兼热、兼寒者,临床应审慎辨之。

第八章 滑胎(习惯性流产)

妊娠胎滑不固,自行流产,连续两三次以上者称为习惯性流产。此病由于冲、任脉虚,肾气不固,所以胎不得养,多次伤坠则肾气愈虚。应于孕前服用补肾之药;以泰山磐石散加减治之。方

中用熟地黄、当归、川芎、白术、白芍、党参、黄芪、炙甘草，加菟丝子、杜仲、桑寄生。成孕之后服用固胎之药，以胶艾汤及金匱当归散加减治之。方中用当归、黄芩、白芍、白术、熟地黄、艾叶、阿胶、炙甘草、杜仲、川续断、桑寄生。或于孕前孕后每日服用千金保孕丸，以保无虞。

泰山磐石散

党参 黄芪 当归 川续断 黄芩 川芎 白芍 白术
甘草 熟地黄 砂仁 糯米

方解：此方是清·陈莲舫立方，载于《女科秘诀大全》中。主治冲任不实，气血两虚，屡有坠胎之妇女。孕前、孕后均可服用，可使气血充实。肾气充，冲任固，胎气壮，保全产。方中以党参、黄芪大补元气；当归、熟地黄、川芎、白芍，四物汤养血和阴；白术、甘草、糯米健中益脾；川续断壮腰补肾；砂仁理气开胃，防补药之臃滞；黄芩与白术相配为安胎之妙药，诸药合成，对屡有习惯性流产者极为有效。如再增加菟丝子、杜仲、桑寄生等药，则更相得益彰。

千金保孕丸

杜仲 川续断

方解：此方是唐·孙思邈立方，载于《千金要方》中。主治妊娠腰背酸痛，动辄小产，常服能固胎。方中用杜仲补肝益肾，强壮腰膝；用川续断补益肝肾，强筋壮骨。两药合用，共成妙方。对于妊娠腰痛，胎滑欲坠，经常服用，有壮腰固肾，安胎保产之功效。

金匱当归散

当归 黄芩 白芍 川芎 白术

方解：此方是汉·张仲景立方，载于《金匱要略》中。张仲景曰：“妇人妊娠，宜常服当归散主之。”徐忠可注：“生物者，土也。而土之所以生物者，温也。血为湿化，胎尤赖之。故以当归养血，白芍敛阴。肝主血，而以川芎行肝气。脾统血，而以白术健脾土。其用黄芩者，安胎之法，惟以凉血，利气为主，白术佐之，则湿无热而不滞，故白术佐黄芩，有安胎之能，是立方之意，

以黄芩为主也。胎产之难，皆由热郁而燥，机关不利。养血健脾，君以黄芩，自无燥热之患，故曰常服易产，胎无疾苦。”仲景为后世立此良方，历代医家无不遵行。

胶艾汤

胶艾汤即胶艾四物汤，方解见本篇第三章“漏下”中。

典型病例

张××，女，34岁，北京109中学教员，1978年12月5日就诊。

主诉：结婚6年，连续流产3次，求医治疗。询及最后一次流产是在三个月以前，现月经正常。

检查：体质中等，脉沉缓，舌红苔薄白。

辨证：冲任不足，胎元不固，习惯性流产。应于孕前与成孕后服用培补肾气之药以固胎。

治法：用补肾固本之法。

处方：

熟地黄10克 菟丝子10克 当归10克 杜仲10克
沙苑子10克 白术10克 山药10克 枸杞子10克
桑寄生10克 川断10克 炙甘草5克 牛膝10克

服药3个月，又怀孕。上方减牛膝加黄芩10克，嘱经常服用。于1980年产一子，阖家感谢。

按：习惯性流产为妇科常见病之一，自然流产3次以上，每次流产均发生在同一妊娠周数者，称为习惯性流产，祖国医学谓之滑胎。发病多因孕妇体质素弱，肝肾不足，气血虚亏，兼之孕期不戒房事，以致冲任不实，胎失所养。应在孕前孕后服用补肾固元之药，以免再度发生流产。连续流产，冲任虚惫，焉能育麟。

第九章 产后缺乳

乳汁者，乃气血所化生。产妇大伤气血，或失于调养，气血衰微。乳汁不丰或无乳，乃气血不能化生之故尔。治宜大补气血，

健壮脾胃，以滋化源，同时增加产妇饮食营养，使所纳入之水谷厚味，通过脾胃之运化，达于乳房，使乳汁丰富。宜用当归补血汤加减。方用黄芪、当归，加葱白、王不留行，或加四君子汤，党参、茯苓、白术、炙甘草，则更相得益彰。

当归补血汤

方解：见第六篇肾虚论第八章“水肿病”中。

典型病例

李××，女，28岁，崇文小学教员，1972年3月5日就诊。

主诉：产后20天，乳汁清稀不丰，用牛乳补充。希望增加乳液。询及恶露已净，无不适感。查：体质稍差，脉沉细。舌淡苔薄白。

辨证：产后气血大伤，脾胃虚亏，缺乳证。

治法：以大补气血，健脾增乳之法。

处方：

党参10克 炙黄芪10克 白扁豆10克 熟地黄10克
山药10克 干姜10克 茯苓10克 当归10克
白术10克 炙甘草5克 大枣5枚 王不留行15克

并嘱增加营养饮食，连续服药20余剂，体质增强，乳汁逐渐增加，已敷婴儿食用之量。

按：产后缺乳为新产常见病之一，其病因不外有两种：一产后气血大虚，乳汁化生乏源。二产妇体质素强但偶遇不遂之事，以致肝郁气滞，乳汁不通。凡郁结不通者除乳汁缺少外，多伴有乳房胀痛，胸胁苦满，其脉必弦。鉴别要点：乳汁全无而乳房胀痛者为郁；乳汁清稀量少而乳房不胀者为虚。郁者以解郁行滞之味治之，虚者以益气养血之药补之。

第十章 产后腰痛

产后腰痛，乃因产伤冲任，肾气虚惫所致。腰者，肾主之，胞胎系于肾。产后损伤胞络，纯属虚损之证，但兼有风寒和血滞者

为多，可出现遍身疼痛，甚则腰背强硬，不能俯仰，手足拘挛，不能展伸，皆为风寒乘虚留滞经络之故。治应以补益肾气为主，以祛风散寒，活血化瘀为辅。用补肾地黄丸加减治之。方中用熟地黄、当归、杜仲、独活、肉桂、川断。可加川乌、草乌、灵仙以增散寒之力，加苏木、元胡索以增活血化瘀之功。

补肾地黄丸

当归 熟地黄 杜仲 独活 肉桂 续断

方解：此方载于《中国医学大辞典》中。主治产后腰痛。方中以熟地黄、杜仲、续断、补肝益肾，强腰壮骨；当归补血化瘀；独活驱寒化湿。对于产后劳伤肾气，虚未平复，寒湿乘之，致令腰痛，连带脊背，宜用此方治之。甚者应增加黄芪、党参，肾虚痛甚者，应增加桑寄生、菟丝子、补骨脂、牛膝；寒甚者应增加川乌、草乌，以增强补肾助阳，化湿止痛之效。

典型病例

刘××，女，32岁，北京模具厂工人，1962年12月5日就诊。

主诉：产后一个月，腰痛不能俯仰，行动困难。询及恶露已净，乳汁尚可，惟天冷屋寒，过早下地劳动所致。

检查：脉沉缓，舌淡苔薄白。

辨证：产后冲任虚损，复受风寒，滞留督脉。

治法：以补肾壮腰，温经散寒之法。

处方：

熟地黄 10克 肉苁蓉 10克 党参 10克 杜仲 10克
川乌 5克 草乌 5克 当归 10克 川断 10克
桂枝 10克 淮牛膝 10克 苏木 10克 独活 10克
桑寄生 10克

经过一个月治疗，共服药25剂，腰痛消失，行动恢复正常，痊愈。

按：产后腰痛为新产妇常见病之一，由于在分娩时劳伤肾气，冲任受损，故腰痛。《内经》曰：“腰为肾之府，动遥不能，肾将惫矣。”肾气不足，气血大虚，风寒乘虚而入故腰痛。亦有由于产

后气虚，荡瘀乏力，恶露不尽，瘀血凝滞于经脉而致腰痛者。辨证要点：腰酸软无力而疼痛者，为肾气虚损；腰痛上连脊背，下引腿膝者，为产后受风寒；腰痛如刺，痛而不移者，为产后瘀血也。

第十一章 产后腹痛

清·陈莲舫曰：“新产先消瘀血为第一，产后以大补气血为主。”因为产后胞衣（胎盘）与宫体脱离及子宫复旧时期，会产生瘀血，滞留宫内，势必为患。所以，历代医家均以去败血为先。《妇人大全良方》曰：“产后以去败血为先，血滞不快，乃成诸病。夫产后元气即亏，运行失度，不免瘀血停留；治者必先逐瘀，瘀消然后方可行补，此第一义也。今人一见产后，有内虚证，遽用参、芪甘温之剂，以致瘀血攻心而死，慎之。”这段论述甚为精辟。若瘀血未除，引起腹痛者必先逐瘀。《产宝新书》曰：“产后气血暴虚，理当大补，但恶露未尽，用补恐致血滞，惟生化汤行中有补，能生又能化，真万全之剂也。”因此新产腹痛应以逐瘀为主，用生化汤加减治之。方用川芎、当归、桃仁、炮姜、炙甘草。如恶露未净，小腹胀满，加元胡索、红花、肉桂，气虚自汗加黄芪，血虚气脱加人参、黄芪，阳虚厥逆加肉桂、附子。

生化汤

当归 川芎 桃仁 炮姜 炙甘草 黄酒 童便

方解：此方为清·傅青主所立，为中医产科著名方剂，载于《傅青主女科》中。主治产后血虚，寒邪乘虚而入，寒凝血瘀，留滞胞宫，以致恶露不行小腹冷痛，此药以温经散寒，养血化瘀为主，瘀血化而血自行，故名生化。方中重用当归补血活血，化瘀生新为君药。以川芎活血行气，桃仁活血祛瘀，共为臣药，炮姜入血散寒，温经止痛，黄酒温通血脉，以助药力，加入童便者，取其益阳化瘀，并有引败血下行之效，共为佐药。炙甘草调和诸药，为使药。此方为“新产之主剂”、“血块之圣药，”广泛用于中孕引

产、足月产后子宫收缩乏力，人工流产后阴道不规则出血，以及产后胎盘、胎膜残留等病证，有养血化瘀，温经止痛之效。

傅青主曰：“血块日久不消，半月后可加三棱、肉桂、元胡索。攻补兼治，其块自消。”若腹痛未止，不可加芩、术。若恶露已行，腹痛已止，应去桃仁。若血块痛甚者，加肉桂。

典型病例

程××，女，32岁，崇文织带厂工人，1962年5月10日就诊。

主诉：产后10天，恶露未净，微量紫血，小腹疼痛，有时恶心。查：脉沉涩，舌暗有斑。

辨证：寒凝血瘀，留滞胞宫，以致腹痛，上冲心胃，引起呕逆。

治法：以活血化瘀，温通散寒之法。

处方：

当归尾10克 桃仁10克 红花10克 生蒲黄10克
姜炭10克 川芎10克 油肉桂5克 木香5克
乌药10克 吴茱萸5克 白术10克 炙甘草5克
服药3剂后瘀血流出，腹痛停止。

按：新产元气亏损，百脉空虚，应以补虚为主，但由于恶露不净，瘀血未除，引起腹中隐隐作痛，当以活血逐瘀之法，祛瘀止痛。首选方剂为傅青主之生化汤。方中加生蒲黄、红花增加活血力量，白术健脾养胃，吴茱萸、姜炭温暖下元，木香、乌药理气定痛，提高生化汤功效。药不在多，贵在得当，自可通神矣。

第十二章 产后虚汗

产后去血过多，阴不维阳：阴虚则阳无所附。卫气不固，腠理不密，则周身汗出不止。产后失血又多汗，乃阴阳两虚之候也。如汗出气喘乃虚之极也；汗多小便不通乃亡津液之故也，不可用利水药。宜用参附汤、芪附汤加减治之。方用人参、黄芪、附子、

白术、浮小麦、白芍、干姜、当归、炙甘草、大枣。以纯补元阳，兼益气血，敛阴止汗。

参附汤

方解：见第一篇总论第十章“厥逆”中。

芪附汤

方解：见第一篇总论第八章《阳虚自汗》中。

典型病例

庄××，女，29岁，无线电零件厂工人，1962年3月3日就诊。

主诉：产后一个月，汗出不止，心跳气短，疲倦乏力，嗜睡，询及恶露早已净尽，无乳。查：脉细弱，舌淡苔薄白。

辨证：产后气血两伤，阴阳两虚之证。

治法：以补气养血，敛阴止汗之法。

处方：

生黄芪 30克 白 术 10克 熟地黄 10克 浮小麦 30克
白 芍 10克 五味子 10克 生龙骨 20克 当 归 10克
党 参 15克 茯 苓 10克 附 片 5克 炙甘草 5克

经过一个月治疗，服药30剂，汗止体力恢复，痊愈。

按：清·傅青主曰：“若分娩后倦甚濈濈汗出，形色又脱，乃亡阳脱汗也。”清·陈莲舫曰：“产后虚汗不止者，由阴气虚而阳气加之。里虚阳气独发于外故汗出。血为阴，产则伤血，是为阴气虚。气为阳，其气实者阳加于阴，故令汗出，阴气虚弱不受者汗出不止。”产后即伤血而又汗出乃为亡阳之征象。汗为心之液，阴亡阳亦随之而去，故曰危证，应速用参、芪、附之剂回阳固脱急救之，不可掉以轻心。

第十三章 产 后 浮 肿

产后浮肿。明·薛立斋曰：“若寒侮土，宜养脾肺，若气虚浮肿，宜益脾胃，若水气浮肿，宜补中气。”又曰：“产后浮肿，或

兼咳喘，脉沉细无力，此命门火衰，脾土虚寒，八味丸主之。”产后浮肿乃脾肾阳虚之候也。脾主四肢，如脾阳虚不能运化水湿则肢体浮肿；肾阳虚则不能蒸化水液，故尿少，水不得排出，聚于体内则水泛为肿。因此，治疗此证，应以温补肾阳，益气健脾之法。宜用桂附地黄丸、参苓白术丸加减治之，方用人参、白术、茯苓、熟地黄、山茱萸、山药、附子、肉桂、牛膝。

产后浮肿不可作水气治，不然必犯产后三禁之过。三禁者：不可汗，不可下，不可利小便。因产后元气大伤，全身脏腑运行失度，可以出现各种病变。朱丹溪曰：“产后有病，先固气血，故产后当大补气血为主。”但亦应注意恶露未净，瘀血未消，于补药之中应入逐瘀行血之药，庶免败血伤人。

参苓白术散

方解：见第四篇脾虚论第七章“脾虚久泻”中。

桂附地黄丸

方解：见第五篇肺虚论第六章“肺虚喘”中。

典型病例

周××，女，41岁，丰台区农民，1961年2月5日就诊。

主诉：产后一个月，面浮肢肿，食欲不振，心跳气短，全身乏力。恶露已净，无乳。

检查：颜面轻度浮肿，两下肢有凹陷之水肿。无腹水，面色晄白，查尿为（-），血红蛋白为9克，红细胞为200万。脉沉涩无力，舌淡苔薄白。此妇人体质较差，又为多产妇。

辨证：产后气血大伤，命门火衰，脾阳不振，寒湿留滞经络。

治法：以补肾火益脾阳，祛寒化湿之法。

处方：

党参20克 炙黄芪20克 白术10克 茯苓10克
肉桂5克 熟地黄10克 附片10克 干姜10克
当归10克 山茱萸10克 大枣5枚 炙甘草5克

经一个月治疗，服药30剂，浮肿消退，体质渐恢复。嘱继服桂附地黄丸、参苓白术丸以巩固疗效。

按：产后气血大虚，气虚则脾必虚，脾虚则制水无能；产后

伤精亡血则肾必虚，肾虚则行水无权。脾肾两虚，水湿泛滥而为浮肿。因此，治疗产后浮肿必以大补脾肾为主，脾健肾充水肿自消。

第十四章 阴脱（子宫脱垂）

阴脱又称“阴挺”、“阴下垂”。现代医学称：“子宫脱垂。”宋代以后，对子宫脱垂有了更深一步的认识，分别订出不同的名称：对一般的都称之为“阴挺下脱”；专由产后引起的称之为“产门不闭”或“玉门不闭”；产后子宫全部脱出的称之为“产后子宫不收”，“产后子肠不收”等。清·叶天士《女科全书》称为“子宫脱出”，膀胱随前阴壁脱出的称为“膀胱落下”。

其主要原因有三种：第一，胞络损伤。所谓胞络是指子宫周围组织而言，由于分娩时用力过度，使周围组织受到损伤或破坏。第二，胞宫虚寒。胞宫即子宫，虚是气血不足，寒是身体机能减低或衰退。第三，气虚下陷，清阳不升。这三种原因归根结底是：气血虚弱。元代朱丹溪曰：“妇人产子后，阴户中下一物，如合钵状，有二歧，此子宫也，必气血弱而下坠”。薛立斋校注《妇人大全良方》曰：“产后玉门不闭，气血虚弱也。”

本病的治疗方法，明代薛立斋曰：“阴挺下脱，当以升补元气为主。”所谓升补元气就是补中益气，增进身体机能。应以补中益气汤加减治之。方中用党参、生黄芪、白术、升麻、当归、川芎、茯苓、柴胡、青皮、熟地黄、生姜和大枣。

补中益气汤

方解：见第四篇脾虚论第十章“中气下陷”中。

典型病例

李××，女，35岁，小红门牌坊村农民，1965年9月1日就诊。

主诉：第二胎产后八个月，因未注意休息，不久便出现轻度子宫脱垂，时好时脱，近日增重，（呈二度脱垂）。

检查：脉沉缓，舌淡苔薄白。

辨证：分娩时用力过度，损伤冲任。复因产后失调，气血虚弱，气虚下陷，清阳不升所致。子宫脱垂症。

治法：以补中益气，升提固脱之法。

处方：

党参 20 克 白术 10 克 青皮 5 克 升麻 3 克
当归 10 克 川芎 10 克 柴胡 3 克 茯苓 10 克
生姜 3 片 生黄芪 20 克 熟地黄 10 克 炙甘草 5 克
大枣 5 枚

每天服药 1 剂，并用五倍子 10 克煎汤薰洗后，用干净布揩干，敷上五倍子面，再将脱出部份纳入阴道中，用月经带包扎。连敷半个月，脱出停止。又服半个月汤药巩固疗效。经过一个月治疗完全痊愈。

按：子宫脱垂为妇科常见病之一，其病因、病理多端，而归根结蒂，均为中气下陷所致。中气即膻中之气，居身之上、下、左、右之间，具有上能擎，下能提，左右能撑之作用。故中气下陷，脏腑皆趋下也。应以益气升提佐以收涩之药，可获良效。

第十五章 产后毛发脱落病 (席汉氏综合征)

此病由于产后元气大衰，精血亏耗，八脉失养所致。

冲为血海，连于胞宫，任督之脉又系养于肝肾，今产后下虚及肾，阴阳互不维系，证见：毛发尽行脱落，乳房萎缩，阴道不润，性欲消失，畏寒肢冷，一派肾阳虚衰之象。付青主云：“产后以大补气血为主。”纵观此病之病因，必须大补气血，益肾壮阳，用四君子汤、四物汤、右归丸（汤）并加黄芪以补元气，加首乌，肉苁蓉、淫羊藿培补肾阳。

四君子汤

方解：见第一篇总论第三章“气虚”中。

四物汤

方解：见第一篇总论第四章“血虚”中。

右归丸（汤）

方解：见第七篇男虚论第一章“阳痿”中。

典型病例：

刘××，女，32岁，崇文织布厂女工。

1965年7月5日来诊，患者一年来全身毛发尽脱，自云：从去年产后开始，至今全身毛发已基本脱落。

检查患者头部，脱发异常严重，几乎全无。眉毛、腋毛、阴毛亦全无，体质一般。每至晚间疲乏倦怠。产后乳房萎缩，阴道干涩，性欲减退。经妇科检查，子宫轻度萎缩，阴道分泌物极少。化验尿：17—羟类固醇 5.60，17—酮类固醇 6.0，血色素 10.5 克%，白细胞 5,800，红细胞 280 万，血小板 11 万，脉沉细，舌色淡。

西医诊断为席汉氏综合征。

中医辨证：气血双亏，肾气虚损。

治以益气养血，健脾补肾。

处方：

太子参 20 克 黄 芪 20 克 当 归 10 克 熟 地 15 克
川 芎 5 克 白 芍 10 克 茯 苓 20 克 白 术 10 克
仙 茅 10 克 仙灵脾 10 克 沙苑子 10 克 山萸肉 10 克
女贞子 10 克 旱莲草 10 克 黑芝麻 10 克 炙甘草 6 克

用上方加减连服 2 个月，已无疲倦之感，月经来潮，性欲正常，头部已有新毛发萌出，体重增加，精神体力基本恢复。复查尿：17—羟 7.0，17—酮 10.0。妇科检查：符合临床治疗标准。为巩固疗效，使毛发生长整齐，给以八宝坤顺丹、七宝美髯丹，连服半年后，随访毛发已全部长齐，头发黑亮，据患者讲较产前还黑润。在整个治疗过程中，灵活制订治疗法则，及时增减药物，方能取得满意效果。

按：席汉氏病的症状，大多进行缓慢而且是逐渐加重，早期往往不引起患者的重视。当其他症状出现时才促使患者治疗。此

病多发生于 20—40 岁左右女性，由于妊娠期垂体呈生理性肥大，易受损伤，一旦并发分娩大出血，则引起垂体前叶功能的减退，导致此病的发生。

中医虽无席汉氏病名，但根据患者的临床表现，如面色苍白无华，全身毛发脱落等症，应属虚证范畴。根据病情轻重缓急，作出标本先后的治疗措施。强调全面辨证，治病求本的原则，细心体察病情，灵活制订治疗方案，方能取得满意效果。

第十六章 产后厥逆

妇人有产后突然晕厥者，乃由于产后元气大损，恶露乘虚上攻，蒙蔽清阳，以致突然晕厥，不省人事。元·李东垣曰：“妇人分娩，乃半产漏下，昏冒目瞑，盖因血暴亡而火上炽，但补其血则神自安。”《济阴纲目》中曰：“产后血气暴虚，未得安静，血随气上，迷乱心神……，令人闷绝，不知人事，口噤神昏。”此乃险症也，不可按痰火治。元·朱丹溪曰：“产后当大补血气为主。”应以十全大补汤、生化汤加减救治。方用人参、生黄芪、附片、红花、桃仁、白术、茯苓、炮姜、肉桂、菖蒲、远志、赤芍、炙甘草等大补元气，以救欲脱之阳，逐瘀以开闭，使瘀散气充，阳回复甦。

十全大补汤

方解：见第五篇肺虚论第九章“脱肛”中。

生化汤

方解：见第八篇女虚论第十一章“产后腹痛”中

典型病例：

张××，女，23 岁，海淀区厢红旗工人，1989 年 10 月 3 日围产住于解放军某医院待产，10 月 5 日产一男婴，未久出现高热，继而突然休克，诊断为产褥热，使用各种抗菌素及各种药物治疗均未奏效，三天后病情恶化，由产科转入内科抢救，家属延余医治，10 月 8 日经院方同意后趋车前往。

临床所见：患者呈深度昏迷状态，呼之不应，面色苍白，四肢软瘫，凉过肘膝，体温高达 40℃，头部、胸部、背部敷有冰袋，血压 90/60 毫米汞柱（12.0/8.00 千帕），神经系统无任何反应，双目瞳孔对等大，光照有反应，脉虚数，急针刺十宣出血，刺时病人稍有知觉。

辨证：产后元气大伤，阴阳两虚，恶露攻心，厥闭虚脱，病势险恶，危在旦夕。

治法：急以大补元气，回阳救逆，祛除败血，醒窍开心之法，以希冀于万一。

处方：

人 参 10 克 生黄芪 20 克 附 片 5 克 生蒲黄 10 克
远 志 10 克 郁 金 10 克 当 归 10 克 桃 仁 10 克
红 花 10 克 茯 苓 20 克 炮 姜 10 克 炙甘草 10 克

上药水煎二次取 400 毫升，两小时鼻饲一次，每次 100 毫升，进药 6 小时后，患者身出大汗（阳回）而甦醒，体温亦随之逐渐下降至正常，三剂药服后遂出院。

第二次处方：

人 参 3 克 生黄芪 20 克 茯 苓 20 克 白 术 10 克
肉 桂 3 克 当 归 10 克 炮 姜 10 克 远 志 10 克
桃 仁 10 克 红 花 10 克 川 芎 6 克 炙甘草 10 克
连服 7 剂，经过一个月疗养，身体完全康复。

按：中医认为，此证乃由于产后气血大伤，阳气暴脱，出现厥逆，实为虚证。《济阴纲目》曰：“凡妇人产后阴血虚，阳无所依，浮散于外，故多发热。……此热非有余之邪热，乃阴虚生内热耳。”又曰：“三日发热，其脉虚疾而大，恶露不行，败血攻心。”清·薛生白亦曰：“产后虚烦生热，乃阳随阴散，气血俱虚，若恶寒发热，烦躁作渴，急用十全大补汤，若热甚加桂附……。”

余此次临床在须臾之间即诊断为产后恶露不净，败血攻心，气血大虚，阳随阴散，出现厥逆乃虚脱之症，当机立断使用参、芪、附、炙甘草大补元气，回阳救逆；用当归、桃仁、红花、生蒲黄逐除败血；用菖蒲、郁金、远志醒窍开心。挽救其生命于旦夕之

间，一剂即阳回复甦。因此，中医中药使用得当，有起死回生之功效。

第十七章 妇人更年期综合征

妇人在绝经期前后出现各种神经症状，称之为更年期综合征。祖国医学早在二千多年前对此病即有深刻认识，提出一系列理论，至今中医奉为圭臬。

《素问·上古天真论》曰：“七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通……。”说明妇人年到四十九岁左右，将临绝经之年，由于肾气渐衰，冲任亏虚，精血不足，天癸将竭，阴阳失调以及血虚等，导致肾阴不足，肝阳失于潜藏，以致使肝血不和。有的体质虚弱，肾阳虚衰，经脉失于温养，发生阴阳偏衰现象，从而导致其他脏腑功能也失衡。因此，肾虚、血虚是此病发生的主要原因。

此病可分三种类型：

一、肝血不和型：此型临床较为多见。肝素喜条达，今血虚肝失所养，以致出现头晕头痛，耳鸣，烦躁多汗，手足心热，喜怒无常，屑小之事即大发雷霆，情志异常，心悸失眠等症状。宜用逍遥散加减，方用柴胡、丹皮、栀子、白芍、苍术、香附、当归、茯苓、百合、柏子仁等清热舒肝，理气和血定智。

二、肝肾阴虚型：临床表现以头晕，头痛，耳鸣，腰膝酸软，烦躁易怒，恐惧不安、倦怠嗜卧，月经周期紊乱，经量少，色紫红，淋漓不断，舌红少苔，脉细数。乃肾阴不足，肝失所养，用大补阴丸、二至丸、一贯煎加减，方用熟地黄、山萸肉、女贞子、旱莲草、莲子心、白芍、沙参、麦冬、龟板、龙骨、牡蛎、枸杞子、益母草、香附、夜交藤等以补肾平肝，滋阴潜阳。

三、肾阳虚型：临床表现：面色苍白或晦暗，精神萎靡，喜静怕扰，情绪淡漠，倦怠无力，腰膝酸软，手足发凉，背部怕冷，阴部有下坠感，带下清稀如水，夜尿多，舌淡苔白，脉迟而弱，乃

肾阳虚衰，阳气不能到达，用左归丸加减。方用党参、熟地黄、巴戟天、仙茅、仙灵脾、菟丝子、当归、益母草、补骨脂等，以培补肾阳。

逍遥丸

方解：见第六篇肾虚篇第四章“不寐证”中。

大补阴丸

方解：见第一篇总论第二章“阴虚”中

二至丸

旱莲草 女贞子

方解：此方是明·王肯堂立方，载于《六科准绳》中。二至丸有补肝肾，养阴血之功能。方中：旱莲草能补肾、黑发；女贞子能补肝肾，强腰膝，明耳目。二至者原指鹿茸与麋茸而言，此方旱莲草与女贞子合用，功同二茸，故亦名二至丸。主治肝肾阴虚；对于高血压，神经衰弱中肝肾阴虚型者最为有效。本方药少，性味平和，补而不腻不滞，为平补肝肾之良方。

左归饮

方解：见第一篇总论第二章“阴虚”中

一贯煎

生地黄 麦冬 当归身 枸杞子 沙参 川楝子

方解：此方是清·魏之琇所拟，载于《柳州医话》中。主治由于肝肾阴虚，肝气横逆所引起的胸肋疼痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津等症。方中重用生地黄为君，滋阴养血以补肝肾；以沙参、麦冬、当归、枸杞子为臣，配合君药，滋阴养血，生津柔肝；用少量川楝子疏泄肝气为佐使。共奏滋阴柔肝以代舒肝之功。川楝子虽有苦燥伤阴之说，但若配在滋阴养血之药中，则无伤阴之弊。

按：此方是以养血柔肝之药来疏泄肝气，有别于柴胡舒肝散、逍遥散等理气舒肝之药。

典型病例

杨××，女，50岁，和平里13区5号楼101号

主诉：数月来头晕，烦躁，易汗，手足心热，口渴多饮，易

饥多食（尿常规正常，酮体（-） T_3 T_4 正常），遇人多语，喜怒无常，夜不能寐，有时彻夜不眠，外出游荡，发病严重时颇似精神病患者，脉细数，舌红少苔。

辨证：精血不足，阳失潜藏，肝气郁结，肝血不和。

治法：滋补肾阴，理气潜阳，定智安神。

处方：

生地黄 20 克 白 芍 20 克 百 合 30 克 莲 心 5 克
香 附 10 克 柴 胡 5 克 茯 苓 20 克 黄 连 3 克
女贞子 10 克 益母草 20 克 鳖 甲 20 克 煅龙骨 20 克
煅牡蛎 20 克 柏子仁 10 克 龟 板 20 克

连续服药 60 剂，症状减轻已能眠，改用加味道遥丸、柏子养心丸，2 个月后痊愈。

按：本病症状表现较为复杂，虚实互见，往往与神经官能症之失眠症以及脏燥病有相似之处，容易混淆，中医在治疗上可以异病同治。

此病以肝血不和型与肾虚肝热型较为多见。用舒肝理气，调和经血，清泻肝火，滋补肾阴是治疗此病之根本大法。更年期综合征中医认为与妇女的月经有关，也就是西医所说的内分泌失调。因此，余在治疗此病时多增加益母草、香附，使肝血和畅。

更年期综合征多属虚证，临床虽常见忽然身热汗出，心烦失眠等阴虚火旺之象，但在治疗中不宜过多使用泻火平肝之药，应着重滋补肾阴，以便使阳潜阴秘，则虚火自平。

更年期妇人脏器趋向衰老，抗病能力逐步下降，应保持乐观情绪，加强营养，适当做些体育锻炼活动，使人体的正气充沛，增强抗病能力，延缓衰老。

第十八章 脏 躁

脏躁病在现代医学中称之为癔病，属于心因性疾病的一种。此种病多因思想狭隘，抑郁寡欢，或精神受到某种刺激不能排除所

致。患者大多文化水平较低，或相信迷信邪说，想入非非。得病者以中青年女性居多。除上述原因外，还与妇女的生理特点也有关系，患更年期综合症的妇女大多有或轻或重的抑郁症的表现。此病发作时，患者情绪反常，丧失自控能力，哭笑无常，多疑猜忌，情绪低落，常常呆坐呆立，默不作声，或产生幻觉。患病时，头晕，目眩，失眠，健忘，烦躁，有时惊悸，怔忡或全身震颤，四肢抽搐，类似癫痫

此病系情志内郁所致，日久不得发泄，以致气机不利，阴血亏耗，不能濡养五脏，五志之火内动，属于虚证，但不能热补，有虚火又不能用苦寒之药。《金匱要略·妇人杂病篇》曰：“妇人脏燥悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。”方中用甘草、淮小麦、大枣。亦可酌加生地黄、麦冬、白芍、香附、百合、女贞子、合欢花、黑芝麻、煅龙齿、煅牡蛎等，使方剂润而不膩，养阴而兼顾肝脾。

甘麦大枣汤

甘草 淮小麦 大枣

方解：本方为后汉·张仲景所拟，载于《金匱要略》中。主治脏躁病，它可以养心安神，和中缓急，有补脾益气之功效。脏躁一病多由心气虚弱，肝气郁结所致，临床表现神志失常，精神恍惚，语无伦次，睡眠不安等，凡此皆属心失所养，神不守舍而至。仲圣立此方剂，流传后世，至今医家奉为圭臬。方中甘草甘缓和中，养心以缓急迫为主要药；辅以小麦微寒，以养心宁神；大枣补益脾气，缓肝之急躁并治心虚。三味甘药合用伍配得当，具有甘缓滋补，柔肝缓急，宁心安神之效。《素问·脏气法时论》曰：“肝苦急，食甘以缓之。”

本方对现代医学所言的癔病以及神经衰弱等病亦有奇效。

典型病例：

刘××，女，52岁，家庭妇女。1972年8月21日就诊。

患者孀居多年，七情内郁，近2年经常发生癔病。数月发病一次，曾用西药镇静剂治疗无效。近因精神刺激，癔病复发已有3天。

症见：头晕目眩，悲伤欲哭，精神恍惚，失去自控能力，手足心热，四肢发抖，易出汗，口唇干燥，脉细数，舌红少苔。

中医辨证：忧愁思虑而伤心，营血亏耗，肝失濡养。

治法：养心宁神，安脏润燥，培养肝肾。

处方：

淮小麦 30 克 百 合 30 克 白 芍 20 克 莲 心 6 克
梔 子 6 克 生 地 20 克 玉 竹 10 克 女贞子 10 克
旱莲草 10 克 合欢皮 10 克 煅龙骨 20 克 煅牡蛎 20 克
竹 茹 10 克 麦 冬 10 克 甘 草 10 克。

连服 10 剂，病情稳定，症状大减，嘱经常服用丹梔逍遥丸、柏子养心丹。随访一年未复发。

按：脏躁病多因心理因素所致，对这种病患者除用中药治疗外，很重要一方面还应用心理疗法。如改变患者生活环境，针对患者具体情况做些思想开导工作，调节患者情绪，尽量使患者心胸开阔，能正确对待自己的境遇。同时，要求患者适当进行体育锻炼，可使身心一起恢复健康。

第九篇 儿 虚 论

小儿乃纯阳之体，患病多为食、火之疾，不应有虚证之出现。但由于小儿脏腑脆弱，气血未盛，易虚易实，邪盛之时必伤正气，因之虚象随时可以出现，往往各种虚实症状同时互见。又由于小儿体质强弱不同，变化迅猛，第一天为实证，第二天即可能出现衰竭现象，甚至早晚的变化均莫测。临床医生不可不慎。

观察小儿形体可以辨别小儿体质的强弱，证候的虚实和病情的轻重。凡发育正常，筋骨坚强，肌肉丰满，皮肤柔嫩，毛发润泽，姿态活泼者为健康儿之表现，不易生病。虽或偶然生病亦较容易治愈。反之若发育不正常，形瘦发枯，面黄无华，筋骨软弱，颅囟逾期不合，睡时露睛，胸部凸出或凹陷，均属先天不足或后天失调；若腹部胀满或肝脾肿大，多属慢性疾病；若四肢伸屈不利，瘫软、枯痿、拘挛、颤动、抽搐、足膝外翻或内弯，应注意是先天畸形，还是疾病的反映，或疾病的后遗症。

形体虚弱的小儿正气衰微，对外界抗病能力低弱，容易感染疾病，染病后多见虚证、寒证。病情重而难治，易出险情，治疗亦难速效。由于婴幼儿象苗芽初茁，在用药时应谨慎小心，药量均应权衡适当，所谓“中病即止，不要过剂，免伤正气”而犯“虚虚”之过，不可不慎。

小儿与成人不同者，如婴儿胎疾，先天不足，成长缓慢均属于虚证。又小儿痧、痘、惊、疳四大病为儿科特有疾病，儿科医生应当通晓。至于各种杂病则基本与内科相同。儿科的辨证论治是和内科一样的。清·吴鞠通曰：“不精于方脉妇科透彻生化之源者，断不能作儿科也。”方脉乃指内科而言。由此可见，儿科临证在病源、辨证、治法等各方面，都不能离开内科的范畴。

从小儿的活动也可以看出发育是否正常。谚语云：“三躺、六坐、八爬。”就是说小儿六个月以前主要是躺着生活，待筋骨健壮，

尤其是做为身体支柱的脊椎，更为重要，六个月以后就可以稍坐片刻，并能两手各握一个玩具，应注意不可久坐。八个月以后可以自己爬行，此时更应注意照看，以免从床上跌下摔伤，甚至死亡。抱一周岁以内之婴儿应注意脊椎部位，取平直姿势，小儿脊椎十分脆弱，如脊椎扭伤可终身致残。一周岁左右可以独自站立，扶栏杆或扶大人的手可以走得很好。一周岁半以后自己可以独立行走。

由于大脑发育正常，八个月以后可以发音，开始“哪哪”、“达达”“妈妈”“爸爸”的叫喊，并逐渐懂得言语，一岁以后开始说话。小儿语言正常发育，固然要有先天大脑的完善，更重要的是后天教养问题，这是个很重要的因素，它可以促进大脑皮层的发育。

乳牙在六个月左右即可萌出，一岁时可出6~8个牙，二岁时可出18~20个牙。

健康儿之头发应乌黑，坚韧，致密。若头发黄、脆、稀疏，生长缓慢，即非健康儿之表现。

综合上述情况发育迟缓之小儿称为“五迟”即：立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟。均为先天不足或后天失调所致，属于虚损证象。

第一章 小儿五软五迟

小儿五软为：头软、项软、口软、四肢软、肌肉软。五迟为：立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟。此病皆因先天禀赋不足，五脏之气虚弱，不能滋养充达，故筋骨不强，肢体痿弱，宜用大补脾胃益肾强阳之法，以补中益气汤加熟地黄、鹿茸、枸杞子、五味子治之。并应以壮年人乳哺育，同时加强护理，渐渐调养。

补中益气汤

方解：见第四篇脾虚论第十章“中气下陷”中。

典型病例

陈××，女，5岁，大兴县安定村，1966年8月5日出诊。患儿已5岁，下肢软痿，肌肉不丰，行动迟缓，面黄肌瘦，头项亦软，发育不良。脉沉细涩迟，舌淡苔白。

辨证：此乃先天不足，后天失养，气血两虚为五软证。

治法：以大补气血、益肾强阳之法。

处方：

太子参 10 克 生黄芪 10 克 白 术 5 克 当 归 5 克
熟地黄 10 克 川 芎 3 克 桑寄生 5 克 附 片 2 克
功劳叶 5 克 肉 桂 2 克 炙甘草 3 克 茯 苓 5 克
牛 膝 5 克 生 姜 3 片 大 枣 3 枚

经4个月的治疗，上方连服50剂。每剂药煎2次，每煎分2次服同时给以人参鹿茸丸，每丸分四次服，每日2次，嘱汤剂和丸药交替服用，经过4个月的治疗，患儿肢体逐渐健壮，痊愈。随访半年未复发。

按：此病多因儿母身体较弱，或为早产儿，同时后天调护失宜营养不良，以致发育迟缓，如不及早医治，影响患儿大脑的发育，使智力发展缓慢，致残终身。

小儿五软五迟病有些症状与现代医学的“遗传性之共济失调”病相似，即遗传性中枢神经性疾病。《古今医统大全》曰：“有日月不足而生，或服坠胎之剂不去竟成胎者，耗伤真气。”属父精不足，母气血亏，以致禀赋不足，精气亏少，脏器虚弱，筋骨肌肉失去濡养而成。《医宗金鉴》曰：“小儿五软之病，多因父母气血衰弱，先天有亏，使儿生下，筋骨软弱，步行艰难，齿不连长，坐不能稳，皆肾气不足之故。”现代医学证明，由于先天不足导致的脊髓萎缩或小脑萎缩，中医认为应从补益先天之肝肾和后天的脾胃着手，用补肾健脑，益气健脾为治疗此病之大法，使先天得益，后天得培，筋强骨壮，发育自能正常。

第二章 慢 惊 风

慢惊风多因先天不足，土虚木盛，或大病过用峻利之药，以致正气受损而成。发时缓缓搐搦，时作时止，面淡黄或青白相兼，昏睡眠合，眼睛外露脉来迟缓，神气惨惨。此乃脾胃虚弱，治宜培补元气为主，气虚夹痰者，醒脾汤治之；有搐搦者，可加钩藤少许。

醒脾汤

人 参 酸枣仁 白 术 柴 胡 地骨皮 桔 梗
生黄芪 龙眼肉 黄 连 木 香 香 附 远 志
茯 神 生甘草 生 姜 大 枣

方解：此方是明·陈实功所拟，载于《外科正宗》中。主治脾胃气虚，食欲不振，气短懒言，四肢倦怠等症。方以黄芪补中益气；人参、白术、甘草甘温益气，补脾健胃；龙眼肉、酸枣仁、远志养心安神；茯神补心益智，安魂养神；木香理气醒脾；地骨皮能泻肺中伏火；桔梗宣通气血；黄连泻火燥湿，香附调气解郁；柴胡协同黄芪升举清阳；姜、枣调和营卫。诸药合用，有益气醒脾、补中养心之功效。

典型病例

金××，女，4岁，崇文区榄杆市44号。患儿先天不足，体质较弱，1959年感染麻疹病毒高烧疹出又合并肺炎，经服中西药治疗，疹透体温渐退，惟元气衰惫，精神萎靡，渐渐不支，出现轻微抽搐，时作时止，1959年11月5日，经中医会诊，临床症见：患儿昏睡，目闭，面色晄白，不思饮食。四肢厥逆，时有搐搦，脉迟细，唇淡舌微红。

辨证：为大病损伤元气，土虚木盛，应以培土补元为主。

治法：益气理脾，缓肝熄风之法。

处方：

人 参 3 克 茯 苓 10 克 白 术 5 克 白 芍 10 克
当 归 5 克 砂 仁 2 克 莲子肉 10 克 陈 皮 2 克
钩 藤 3 克 炙甘草 5 克 生 姜 3 片 大 枣 3 枚

连服 3 剂，搐止，精神渐复，原方去钩藤，又服 5 剂，饮食正常，已能在床玩耍，给以补中益气丸，日服 3 次，每次 2 克，扶养一月，身体恢复。

按：慢惊风病多为邪盛体弱，正不胜邪；或大病之后正气大损，发生全身衰竭现象，应以扶正为主。如病势急迫，气血暴脱，生命危在旦夕，宜用峻补之剂，以抢救危亡之阳气。

人参能续中气；附子能回元阳；参附汤为抢救虚脱证之首选有效良方。

第三章 慢 脾 风

此病多因小儿先天不足，秉赋素弱；或大病之后，气血严重受损；或吐泻日久，不进饮食，严重伤及脾胃。后天正气乃水谷之精微化合而成，今脾虚不能纳谷，正气必竭，土不能生金，金弱不能制木，肝木强盛必克脾土，故曰慢脾风。症见：目闭昏睡，肢体有时轻微搐动，面唇青暗，额出冷汗，四肢如冰。此乃阴盛阳衰之候，惟宜大补脾土，益胃回阳。病势发展，气血衰败，急救时可用独参汤、参附汤，待阳回后，再用参芪补脾汤调治。

独参汤

方解：见第一篇总论第十章“厥逆”中。

参附汤

方解：见第一篇总论第十章“厥逆”中。

参芪补脾汤

人 参 黄 芪 白 术 茯 苓 甘 草 五味子 升麻
当 归 陈 皮

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。脾为后天之本。脾虚则水谷不化，正气无从补充，中气不足。脾主四肢，脾气不足，肢软倦怠。方以参、苓、术、草四君为主，补中益气扶脾养胃；气虚则血弱，故用当归补血和营；五味子益气生津，补虚强精；升麻协同黄芪升举清阳，大补元气，使下陷之气

得以补充和升提；陈皮理气调中，使补而不滞。诸药合成，有益气生血、健脾补虚之功效。

典型病例

张××，男6岁，青云店乡农民之子，1965年3月4日出诊。

患儿由于先天不足，元气不充，又兼饮食不节，感受寒凉，吐泻交作，已有10天，饮食不进，已有3天，患儿有脱水现象，呈现目闭昏睡，肢体有时搐动，面黄唇青，额出冷汗，四肢冷过肘膝，大便稀水，脉沉细而迟。

辨证：久病元气大亏，吐泻伤津，阴随阳脱，成为阴竭阳亡之危证。

治法：急以大温大补，回阳固脱之药，峻补救急。

处方：

人 参 5 克 附 片 3 克 干 姜 3 克 黄 芪 15 克
茯 苓 15 克 肉 桂 3 克 白 术 5 克 炙甘草 3 克
生 姜 3 片 大 枣 3 枚

连服2剂，3天后神清阳回，泻停搐止，嘱饮红枣粥，以助胃气。上药连服20剂，经过一个月扶养，体力逐渐恢复。嘱服小儿健脾丸一个月，随访半年，精神大为转变，痊愈。

按：近年来由于医疗保健事业不断发展和儿童健康水平的不断提高，虽有脱水病儿，亦皆由儿科医生给以补液抢救，中医治疗不多，因此病例较少。但中医对儿童与成人心力衰竭的抢救工作，各方面已有很多报导。

第四章 小 儿 虚 胀

凡小儿脾虚久病失其健运，或因吐泻，损伤脾气，饮食不化，少食腹即胀满，精神倦怠，症见腹胀痞满，脾主四肢，神疲倦怠。此症应以健脾为主，根据“结者散之”可酌加理气消导之药，则胀自消。宜用枳实消痞丸治之。

枳实消痞丸

党参 茯苓 白术 厚朴 黄连 半夏曲 麦芽曲 干姜
枳实 炙甘草

方解：此方是明·李东垣所拟，载于《兰室秘藏》中。主治由于脾胃虚弱，升降失常，气机不利，食滞中阻所引起的中脘痞闷，腹部胀满，恶食体倦，大便不畅。方用参、苓、术、草补气健脾而扶正；以枳实化滞下气，消痞除满；厚朴、半夏曲、麦芽曲行气化痞，去痰除湿；干姜、黄连一辛一苦，一升一降，能开泄寒热之互结；更加四君坐镇中州，消补兼施，寓攻于补，寓补于攻，痞满自消。

典型病例

刘×，男，4岁，崇文区细米巷5号。1965年10月5日就诊。

小儿体质素弱，由母代诉：近半月不思饮食，大便不畅，腹部胀满，精神倦怠。检查：小儿较为虚弱、颜面微黄，舌淡白尖微红，脉沉细微数，腹部膨隆，扣腹部胀满，叩诊鼓音。

辨证：脾胃虚弱，饮食停滞，患儿病程较短，正气尚未虚损，应攻补兼施，早存正气。

治法：以健脾益胃化痞消胀之法。

处方：

太子参5克 茯苓12克 炒白术5克 厚朴3克
陈皮5克 焦槟榔3克 苍术5克 焦三仙20克
干姜3克 黄连3克 枳实3克 莱菔子3克
酒川军2克 炙甘草3克

每剂药煎两次，每煎药分2次服，经过10天治疗，共服6剂，大便泻下黏滞不消化之物甚多，胀消痞除痊愈，嘱常服小儿启脾丸以巩固疗效。

按：小儿之病多由饮食过度，伤及脾胃，食滞积停于肠胃之间，以致便秘腹胀。病程短，正气未损，尚未成疳者。掌握病机，急以攻补兼施之法治之，以存正气免成疳积之证。

第五章 小儿脱证

此证多由温热疫疹等病，高烧日久，气血受燔，灼伤阴津，阳气随之而去，虚极欲脱所致，症见：精神萎靡，昏睡无神，呈半意识状态，手足厥逆，冷过肘膝，身出冷汗，阴囊蜷缩，脉细欲绝。此乃心气衰竭之证，即现代医学之心力衰竭。治宜峻补其气，扶元固脱，使气返阳回。用独参汤或参附汤治之。

独参汤

方解：见第一篇总论第十章“厥逆”中。

参附汤

方解：见第一篇总论第十章“厥逆”中。

典型病例

钱××，女，18个月，住崇外西火桥二号。1959年10月5日就诊。

家长代诉：发烧第五天口腔及咽喉轻度糜烂，皮肤生有疱疹，住院治疗。

检查：体温 39.5℃，神志清，精神萎靡，颜面及上下肢均有浮肿，口唇周围溃烂；咽充血，舌充血，均有白膜溃疡，皮肤有溃烂之处，口角糜烂，两肺多数干湿性罗音，但胸透心肺未见异常，血常规检查：血红蛋白 7.5 克、白细胞计数 5 600/立方毫米，红血细胞计数 267 000/立方毫米，大便常规（-），尿常规（-）。

诊断：一、支气管肺炎。二、溃疡性口炎。三、脓疱病。四、营养不良性贫血及浮肿。

经住院治疗 7 天、注射奎宁、青霉素、链霉素，头敷冰囊，先后口服红霉素、金霉素，同时静脉点滴葡萄糖和输血，以便控制肺炎的发展。体温在 18 日曾下降正常，18 日晚间又回升，21 日体温曾高达 40℃，经 X 线照片两肺中带点状模糊阴影，诊断为两侧肺炎，急使用冬眠灵及冰袋、冰褥冷敷来降温。次日（10 月 22 日）上午体温已正常；但至下午二点患儿渐精神萎靡，情况逐渐恶化，体温 35℃ 即不上升，心音减弱，心率减低，给以强心剂和肾上腺素等注射针，同时又输血，并用热水袋来保温，仍不见好

转，继续恶化。下午四点急请中医会诊。

临床所见，患儿平素体质羸弱，又兼病势急剧，邪极猖獗。经用西药治疗之后，病邪虽暂被抑制，但儿体“易实易虚”更因体质羸弱，正气已经大伤，形成邪暂去而正将亡之象。表现真阴濒绝、元阳将尽之状态，形势已严重万分。症见：神识昏愦，呼吸微弱，四肢厥逆，肢冷已过肘膝，冷汗频出，颜面苍白，口干无津，嗜睡神疲，目无精光，不哭不语，不饮不食，口角糜烂，口内生疮，两脉微细欲绝，且有间歇出现代脉（动3次停2次），（心率55次/分，血压收缩压80毫米汞柱（10.7千帕），舒张压为零），阴阳有离决之势。急以张景岳之独参汤救之。人参6克煎汤，频频鼻饲，以回阳固脱，维护正气为主。务使阳回阴固，方不致阴阳睽离而成不救！

10月23日上午患儿体温回升正常36.5℃，厥回肢暖，精神好转，目已灵活，已能哭、能饮、能食，心率80次/分，心律正，两肺散在细小水泡音，苔干舌赤，两脉微细。给以益气养阴，生津润肺之剂。

人 参3克 元 参5克 沙 参5克 天门冬10克
麦门冬10克 玉 竹10克 紫 菀5克 丹 皮5克
花 粉5克 川贝母5克 生石膏15克 炙甘草3克

上药2剂，（随时口服）连用3天，10月25日患儿精神大见好转，两肺罗音已很少，咳嗽已止，唯口炎及头部脓疱及鼻腔脓疱仍在蔓延，不见好转。停汤药，给以五福化毒丹，每次半粒，一日3次，连服3天，10月28日口鼻周围、口内及鼻腔脓疮已大部分结痂并有部分脱落，仍有轻度咳嗽痰声，两肺未听到罗音，体温稳定，精神很好，已食用半流，脉微数有力，给以润肺化痰之剂：

紫 菀5克 法半夏3克 枇杷叶5克 杏 仁2克
前 胡5克 橘 红10克 茯 苓10克 甘 草3克

上药连服两剂，至10月31日，检查口角和鼻部的结痂已全部脱落，头上脓疱已结痂，病已痊愈。经西医大夫给以少量维生素，嘱回家休养。

按：病邪侵入，早期虽然来势凶猛，但中医多以开鬼门、洁净府等法来驱邪，再以清热养阴，益气生津之法扶其正，使受侵之躯迅速恢复。如误治失治，失去治疗机会，邪扰正气，必然生变，轻则酿成大患，重则丧命。

此例患儿邪盛正耗，气血双亏，正气不支，病见绝脉，元气欲脱。故先以扶正固脱为主，先存正气，后议驱邪，此即古人所谓：“急则治标，缓则治本”之意。故用独参汤挽回其已脱之阳，冀拯于万一。小儿乃稚阳之体，况病已八日高烧灼津，真阴耗尽，因之在次日阳气回转之后，急用天门冬、麦门冬、生地黄、元参、沙参滋阴养液；人参、玉竹、炙甘草补气扶脾；生石膏、丹皮清热；川贝母、紫菀清肺。经服药三日，正气及津液得以恢复。惟病毒流窜，头疮及口疮仍在蔓延，当使用化毒丹消解病毒，控制脓疱之发展，服三日后均结痂。尚有少许咳嗽痰声，用橘红、法半夏、杏仁化痰、紫菀、枇杷叶清热润肺；茯苓、甘草健脾利水。服药三天咳嗽消失。中医自10月22日接治至31日出院，仅用10天即完全控制病情，机体得以恢复。

第六章 小儿多汗

小儿由于秉赋虚弱，或大病之后，卫气不固，汗向外泄，甚至汗出淋漓，长期不愈，可使阴液消耗过多，出现面黄肌瘦，甚则苍白无华，情绪烦躁，倦怠无力，食欲不振，多饮思水，缠绵日久，影响小儿健康的发育成长。此乃正气内虚、津液耗损，气阴两伤。治宜调和营卫，益气固表，养阴生津，收敛固涩之剂。以六神散治之，可酌加麦门冬、牡蛎、白芍、浮小麦等药，以加强敛阴潜阳，生津止汗的作用。

六神散

人参 茯苓 白术 甘草 白扁豆 生黄芪

方解：此方为明·王肯堂拟方，载于《证治准绳》中。为治疗脾胃虚弱，自汗盗汗，津液枯竭之方剂。方用参、苓、术、草

四君子扶脾养胃，补益中气，使脾胃健旺，运化力强，滋生气血为主药；更以黄芪益气御风、固表止汗；白扁豆补脾除湿，升清降浊，土强湿去，正气自旺。脾为后天之本，此方为益气健脾之良方。方中加牡蛎以敛阴潜阳，收敛止汗；加白芍和肝补血，敛阴止汗；加浮小麦敛阴除烦，养心止汗；加麦门冬清心润肺，泻热生津。以此增强固表止汗之功用，则效果更佳。

典型病例

秦××，男，5岁，青云店乡人，1965年9月4日就诊。

家长代诉：夏季曾多次患胃肠炎，现在每日日间自汗，夜间盗汗，食欲不振，倦怠喜卧，不爱玩耍。

检查：患儿身体羸弱，面黄肌瘦，发枯无泽。脉沉细、舌质淡白。

辨证：久病卫阳虚衰，不能约束津液。表虚证。

治法：益气健脾，固表敛汗之法。

处方：

太子参5克 生黄芪5克 茯苓10克 淮山药10克
五味子3克 浮小麦10克 麻黄根3克 生龙骨10克
白术5克 炙甘草3克 生姜3片 大枣3枚

连服10剂汗止，精神好转，食欲正常，嘱经常服用参苓白术丸巩固疗效。随访半年未复发，小儿体质大为改变。

按：多汗证有生理性出汗与病理性多汗之分，应认真鉴别诊断。生理性之出汗，多见于天气炎热，室温过高，穿衣盖被过厚，使体内产热过多。这时的多汗是机体自身调节体温的作用。而病理性多汗，往往表现在病人安静状态下，大汗淋漓，出汗不止。汗后四肢酸软，倦怠乏力，口干舌燥，精神萎靡不振，此为阴阳两伤之病理反应也。临证应详细审慎。

第七章 小儿脱肛

小儿脱肛皆因泻痢日久，中气下陷，肠壁薄瘦，肛门滑脱不

收，症见：面色青黄，指梢冰冷，唇色淡白。脉沉细迟缓。证属：中气下陷，脾阳不足，先以补中益气汤升举其气，再以真人养脏汤温补固滑，外用五倍子面热敷，其肠自合矣。

补中益气汤

方解：见第四篇脾虚论第十章“中气下陷”中

真人养脏汤

方解：见第五篇肺虚论第八章“肠虚不固”中

典型病例

王××，女，12岁，崇文区营房九条15号，1960年6月5日就诊。

母亲代诉：患儿自5岁患痢疾，至今不愈已成慢性痢疾，时好时犯，每日2—3次，粘液便，近二个月来，大便后脱肛，不能自举，用手揉托可以恢复，患儿面黄微青，两目无神，发枯齿燥，肌肤消瘦，脉沉而细，舌淡薄白。

辨证：久泻久痢，脾胃虚寒，中气下陷。

治法：用益气升提，温中散寒，化痢止泻之法。

第一次处方：

党参10克 白术10克 陈皮炭10克 乌梅炭10克
茯苓10克 当归10克 川军炭3克 桃仁10克
桔梗10克 山楂炭10克 冬瓜子10克 生甘草5克

连服5剂，泻下粘稠腥臭之物甚多，腹痛稍减，外用五倍子面热敷肛门。

第二次处方：

党参10克 白术10克 肉豆蔻10克 木香10克
诃子肉10克 姜炭10克 陈皮炭10克 当归10克
炙黄芪10克 云茯苓10克 炙甘草5克 生姜3片

连服10剂，腹痛大减，大便日1~2次，粘物消失。继服参苓白术丸一个月，巩固疗效，随访二年，并未复发，身体发育大为改变，面色红润二目有神，头发虽稍黄，但已不枯，躯体肌肉丰满，较前望若两人。

按：此病为痢久不愈成难治之症。久病脾虚，中气下陷而脱

肛，但由于湿热滞留，秽毒凝结，腐蚀肠管，因之分泌大量粘液，随便而下。治疗此病首先清涤肠管之湿热毒秽。因此在第一方中首先使用桃仁、冬瓜子、桔梗、川军炭荡涤肠管之毒秽，使污秽之物清除，同时使用补法，以扶正气，攻补兼施，标本兼治。第二次处方，专以建中扶脾巩固疗效。

第八章 疳 证

此证由于小儿先天不足气血虚损，后天脾胃受伤，出现全身虚衰之症状；或因后天缺乳少食，所造成营养不良之佝偻病，均属中医疳疾范畴。脾胃为后天之本，如小儿缺乳进食过早，损伤脾胃，运化迟滞，渐生积热，热久伤津，乃成疳疾。临证多见：头皮光秃或毛发焦稀，腮缩鼻干，口唇皴白，两眼昏烂，揉鼻捋眉，脊耸体黄，腹胀肠鸣，形体消瘦，致成疳疾。疳疾本以脾疳为主，由于疾病缠绵，兼见各脏症状，因此，中医临证分为五疳，兹将五疳分别论述如下：

一、心 疳

心疳之疾，多因小儿乳食不调，心经郁热所致。症见：身体壮热有汗，面赤唇红，口舌干燥，口渴引饮，咬牙弄舌，口舌生疮，小便短赤，上吐下利，懒食干瘦，睡喜伏卧。热盛者用导赤散，病久心气虚者用茯神汤调理之。

导赤散

生地黄 木通 甘草

方解：此方为宋代钱仲阳所拟，载于《小儿药证直诀》中。本方是用治疗心经与小肠有热之症，症见心胸烦热，面赤口渴，口舌生疮，小便赤涩，且痛。方用生地黄凉血滋阴以制心火；木通上清心经之热，下则清利小肠，利水通淋；生甘草清热解毒，调和诸药。诸药合成共收清心养阴，利水通淋之功效。

茯神汤

人参 当归 茯神 炙甘草

方解：此方为明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中。主治小儿心气不足，惊悸频哭，小儿下生羸瘦多惊等症。方用人参补益中气，健脾扶正；当归补血养心；茯神补心宁神，并可“开心益智，安魂养神”；炙甘草补中健脾。治疗“心虚不足、血虚化风”之时，使用此方至为有效。

二、肝 疳

肝疳之疾，多因乳母寒温不调，滋味不节，或外感风寒，内伤喜怒，气未平复，遽以哺乳。使小儿肝经受热。症见：目生眵泪，隐涩难睁，摇头揉目，甚至经月合眼，耳流浓水，面身湿疮，腹中积聚，膈上伏热，身体羸瘦，躁渴烦急，粪如青苔，痰涎壅塞。治宜先用清泻肝热之法。柴胡清肝散加肥儿丸治之。若病势稍减改用抑肝散加减治之。

柴胡清肝散

柴胡 人参 黄芩 梔子 连翘 桔梗 川芎 甘草

方解：此方是明·薛立斋立方，载于《妇人大全良方》中，主治肝、胆、三焦风热怒火，头面生疮，耳内流脓，以及妇人阴痒等症，方用柴胡清肝胆郁热。《本草备要》曰：“柴胡治小儿五疳羸热，散十二经疮疽，血凝气聚，功同连翘；连翘治血热，柴胡治气热”；连翘清热解毒，消肿排脓，为疮家圣药；梔子泻三焦之郁热；桔梗入肺，泻气分热，宣通气血；黄芩可除脾家湿热；川芎乃血中之气药，能润肝燥，补肝虚，助清阳而开诸郁；人参培补元气，益土生金，以扶正气；甘草补脾胃协和诸药。八药相配成为清泻肝经湿热之良方。

肥儿丸

人参 白术 胡黄连 茯苓 黄连 使君子 山楂肉
神曲 炒麦芽 芦荟 甘草

方解：此方载于清·《医宗金鉴》中。主治小儿食积、乳积、痞块等症。小儿食滞的形成与脾胃有关，若脾失健运，胃失通降，必产生伤食之证。由于气机不畅，寒、热、痰、食交搏，日久必

成痞块，可用此药消之。方中用神曲、麦芽、山楂肉消食化水，导滞除积；胡黄连性味苦寒能清心经热，《本草备要》曰：“消果子积，为小儿惊疳良药”；与黄连同用，有清热燥湿，开郁除烦之功；芦荟清热除烦，治小儿五疳；使君子健脾消积，杀虫治疳。《本草备要》曰：使君子“为小儿诸病要药”；方中并以参、苓、术、草四君子补中健脾，培养正气，达到祛邪而不伤正，扶正而不碍邪的目的。

抑肝散

柴胡 当归 川芎 白术 茯苓 钩藤 甘草

方解：此方是明·王肯堂立方，载于《证治准绳》中，主治小儿肝经虚热，咬牙发搐，寒热惊悸，腹胀少食，睡卧不安等症，方用钩藤定惊除热，《本草备要》曰：“治大人头旋目眩，小儿惊啼癇疾”；用当归、川芎养血荣筋，可补肝阴；柴胡清肝胆之郁热；茯苓、白术、甘草益气健脾和中宁神；药仅七味搭配整齐，标本兼顾有抑肝健脾之作用。

三、脾 疳

脾疳之疾多因乳食不节，或乳母恣食生冷肥腻，或饭后与乳，或乳后即眠，小儿脾胃受伤所致。多见面黄，肌肉消瘦，头大项小，身体发热、困倦，常喜睡眠，心下痞硬，懒进乳食，腹满肿胀，腹痛坚硬，不思饮食，引饮无度，有时吐泻，口干烦渴，大便腥粘酸臭。根据“结者散之”、“坚者削之”、“通可去滞”的原则，应先攻其积，用消食丸、肥儿丸治之。待积退然后补之，补脾以参苓白术散为先。

消食丸

砂仁 陈皮 三棱 神曲 乌梅 麦芽 香附 莪术
枳壳 槟榔 丁香

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中，主治小儿乳食过度，宿食不消，成为疳积，四肢羸瘦，肚大青筋，泄下酸臭。方用槟榔行气破结；陈皮理气和中；枳壳行气消痞；砂仁醒脾和胃；麦芽除胀消食；香附调气解郁，消积散聚；乌梅生

津止渴，涩肠杀虫；丁香治胃冷壅胀，开郁消痰；神曲化滞消积；莪术开胃化食，行气消积，可破气中之血；三棱破血消积，可破血中之气。两药合用可消癥瘕痞块。以上诸药成方。为治疗脾胃虚弱所引起的饮食停滞癥瘕痞块的有效良方。

四、肺 疳

肺疳之疾，多由乳食不调，壅热伤肺所致。症见：面白气逆，有时咳嗽，皮毛干焦，肌肤干燥，多涕时啼，咽喉不利，壮热憎寒，唇边赤痒，鼻颊生疮，腹内气胀，乳食渐稀，口有腥气，此肺疳也。宜先用清肺饮以治肺，后用补中益气汤补土生金，久嗽肺虚者，用补肺散最效。

清肺饮

前胡 荆芥 桑白皮 枳壳 知母 贝母 薄荷 赤茯苓
桔梗 杏仁 苏叶 阿胶 天门冬 甘草 乌梅 生姜

方解：此方是清·沈金鳌拟方，载于《沈氏尊生书》内。主治肺肾阴亏。阴虚则生内热。肺主皮毛，肺热则发枯皮干，易感风寒。此方以补肺养阴，清肺润燥，兼散风寒。方中用阿胶补肺养血；苏叶、荆芥、薄荷疏风解表，宣散肺中风寒；《本草备要》曰：前胡能治“小儿疳气，有推陈致新之绩”；桔梗清咽利痰，宣通肺气，有升开之能；枳壳降气消痞，一升一降，肺气得宣；知母清金泻火，润燥滋阴；贝母宣散结热，润肺化痰；杏仁消积下气，润肺化痰；天门冬清金降火，止渴消痰；赤茯苓补脾益气，燥湿化痰；桑白皮下气行水，止嗽清痰；乌梅止渴生津，敛肺涌痰；甘草和中能调和诸药，与桔梗相遇成为甘桔汤能清咽利喉；生姜辛散逐寒，降逆和中。诸药合用，散中有敛，开中有合，润中有补，补中有泻，为治疗小儿肺疳症之良方。

补中益气汤

方解：见第四篇脾虚论第十章“中气下陷”中。

补肺散

阿胶 茯苓 马兜铃 糯米 杏仁 甘草

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中，主治

肺虚久嗽，咳嗽气促，阴虚火炽，津液不足等症。方以阿胶补阴和血，清肺养肝，滋肾益气，润燥定喘，为主药；以茯苓益气健脾，生津止渴，宁心定魄；马兜铃清热降气，定喘化痰；杏仁消积下气，润肺化痰；糯米补脾温肺，能散肺寒，《本草备要》曰“阿胶、糯米乃补肺之正药”；甘草健脾和中协调诸药，各药合用，寓清于补，清补兼施，以补为主，古人立方考虑周全。

五、肾 疳

患肾疳者初生必有解颅鹤膝，齿迟行迟等肾气不足之证，更因肥甘失节，久则渐成肾疳。临证多见：肌骨消瘦，面色黑黧，齿龈生疮，口中臭气，寒热时作，口鼻干燥，足冷如冰，腹痛泄泻，哭啼不止，乃肾疳也。以九味地黄丸治之。

九味地黄丸

熟地黄 赤茯苓 山茱萸 川楝子 当归 川芎
丹皮 山药 使君子肉

方解：此方是明·王肯堂所拟，载于《证治准绳》中，本方以滋补肝肾为主，兼消疳疾，方中以熟地黄补肾填精，为主药；佐以山茱萸养肝益精；山药补脾固精；赤茯苓补心脾益气胜湿，以助山药之健运；丹皮清泄肝火，并制山茱萸之温；当归补血养肝；川芎活血行气，畅通气血，使补而不滞，营血调和；川楝子理气止痛，能杀三虫；使君子补脾杀虫，消积治疳。此方对治疗小儿肾气不足引起的肾疳症，至为有效。

典型病例

刘×，男6岁，大兴县安定乡人，1965年10月9日出诊。

患儿发病已半年之久，面色青黄，日渐羸瘦，腹胀青筋，发竖黄枯，皮肤粗糙不润，口渴引饮，精神不振，脉细数，舌红苔白。

辨证：饮食失节，食伤脾胃，积滞停于胃肠之中，成为疳症。

治法：以健脾养胃消导化滞之法。

第一次处方：

太子参10克 茯苓10克 苍术5克 三棱5克

莪 术 5 克 鸡内金 5 克 建莲肉 10 克 焦槟榔 5 克
川厚朴 3 克 酒军炭 3 克 枳 实 3 克 木 香 3 克
生甘草 3 克 生 姜 3 片 大 枣 3 枚

连服 10 剂，下粘滞之物甚多，腹胀轻减，在治疗当中配合捏脊按摩方法治疗。

第二次处方：

太子参 10 克 茯 苓 10 克 白 术 5 克 枳 壳 3 克
砂 仁 2 克 鸡内金 5 克 建莲肉 10 克 当 归 5 克
陈 皮 3 克 焦三仙 10 克 生甘草 3 克 生 姜 3 片
大 枣 3 枚

上方连服 20 剂，二个月后患儿体质大为改观，面色红润，腹胀消失，肌肤转为丰润，体力逐渐恢复而痊愈，嘱服参苓白术丸巩固疗效，随访半年未复发。

按：小儿疳疾，俗称“积”。顾名思义，此病为胃肠功能失调所致。小儿由于饮食不节，损伤脾胃，消化功能减低，严重地影响营养物质的吸收，从而造成身体营养不良状态。因此，中医除服药外尚有按摩捏脊，和推拿等方法，简便易行，应予推广。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTA0Mjl4OTguemlw",
  "filename_decoded": "10422898.zip",
  "filesize": 12650494,
  "md5": "791398e9cc5748040c92d185c29cb9f8",
  "header_md5": "7f2d37e8ff85a745272679b0e31aae5c",
  "sha1": "c821b89d7ed2ffa432f36a9f7778039a203dd048",
  "sha256": "007a3f967e69c674ba35f5db0a23ef92e03bac929e4bf5a7e9f5da84e7945906",
  "crc32": 1949314187,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 12853505,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 185,
  "pdg_main_pages_max": 185,
  "total_pages": 201,
  "total_pixels": 802718400,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```